

안이비 1주차

<써머리 참고사항>

- 검은 글씨 : 강의자료 PPT 내용
- 회색 음영 : PPT 빈칸
- ★노란 음영 : 기출
- 빨간 글씨 : 중요 내용
- 회색 글씨 : 교수님 말씀

<목차>

1. 안구의 구조

0) 개괄

- 1) 안부속기관 - 안와, 안검, 누기, 누액, 결막
- 2) 안구 - 공막, 각막, 포도막, 수정체, 유리체, 망막
- 3) 혈액공급
- 4) 시신경 및 시로 - 시신경, 시로

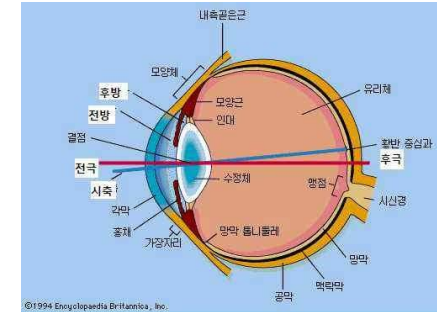
2. 눈의 검사

0) 문진법

- 1) 기본검사 - 외안부, 시력, 굴절, 동공반사, 안구운동, 세극등, 안압측정, 안저
- 2) 특수검사 - 시야측정, 색각검사, 광각검사
- 3) 안외이상검사 - 누기검사, 안구돌출검사

01 안구의 구조

개괄

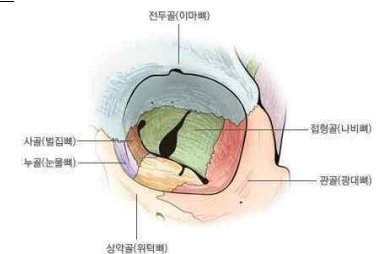


안구	외막(섬유막 - 단단)	각막, 공막
	중막(혈관막 - 영양공급)	홍채, 모양체, 맥락막
	내막(신경막 - 물체의 상 파악)	망막
	안내용물	방수액, 수정체, 유리체
시로	시신경(안구에서 얻은 모든 정보를 뇌로 전달)	
안부속기	안와, 안검, 누기, 누액, 결막, 외안근, 안구집	

- 안내용물 : 투명해야함
- 시로 : 망막에 맺힌 정보를 시각중추로 보내줌. 시신경을 의미
- 안구집 : 외막 중 공막의 일종으로 볼 수 있음

안부속기관 - 안와

- 앞면을 기저로 한 피라미드 형태
- 상하내외의 4벽
- 7개의 뼈로 구성: 전두골, 비골, 상악골, 관골, 누골, 사골, 접형골
- 성인 안와
 - 높이: 3.5cm
 - 깊이: 4~5cm
 - 용적: 약 25~28ml ▶ 안구 용적: 6.5ml



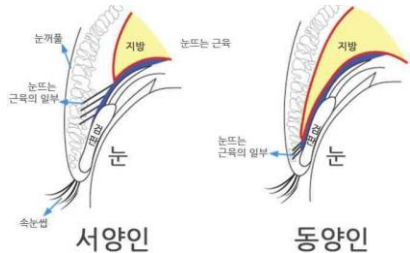
- 시신경공: 난원형 구멍
- 상안와열: 외안근 지배신경 + 삼차신경 제1지
- 하안와열: 삼차신경 2지
- 눈알이 들어가 있는 공간
- 안와의 공간이 넓기 때문에 침 치료 시 두려워하지 않아도 됨
- 파열골절: 하벽이 안구의 직접적인 충격에 쉽게 손상되어 안구의 내용물이 상악동 속으로 빠져 하직근과 하사근이 골절사이에 끼이는 것 → 안구운동에 문제가 생김

- 안구용적은 6.5ml, but 실제 눈의 안와용적은 4배정도
→ 이 넓은 용적을 지방, 근육 등이 채우고 있음

안부속기관 - 안검

- 회백선: 앞층판(피부, 안륜근)과 뒤층판(검판, 결막)을 구분
- **피부층, 근육층, 검판, 결막**의 4층으로 구성 → 앞쪽 피부, 근육 / 뒤쪽 검판, 결막
- 검판은 치밀섬유조직으로 안검의 형태를 유지
- 기능
 - 외상, 강한 빛으로부터 안구를 보호
 - 순목운동을 통해 안구 앞면으로 눈물의 확산을 도우며 눈물과 함께 이물질 제거

- 서양인과 동양인의 차이_상안검거근



- 서양인은 상안검거근이 발달되어 있어서 쌍꺼풀이 잘 생김
- 동양인은 상안검거근이 하나라서 주름이 잘 생기지 않아 쌍꺼풀이 잘 생기지 않음
- **상안검거근** : 상직근 기시부 바로 위 안와첨에서 시작하여 안와결막의 바로 앞에서 부채꼴 모양으로 넓게 퍼진 건막
- 신경: 동안신경의 지배를 받아 안검을 끌어올림

분비선

- ① 마이봄선
 - 지방분비선, 검판에 수직으로 나란히 한줄로 배열
 - 모낭과 연결되지 않음
 - 염증은 **내맥립종**
- ② 짜이스선
 - 변형된 기름샘, 모낭과 연결됨
 - 염증은 **외맥립종**
- ③ 몰선: 한선(땀샘), 염증은 **외맥립종**
- ④ 부누선(덧눈물샘): 크라우제선, 볼프링선

- 피지 분비 주관: 마이봄선, 짜이스선
- 수분 분비 주관: 몰선, 부누선
- 다래끼가 생기는 가장 큰 이유: 마이봄선

안륜근

- 검열과 평형하게 배열된 동심성의 얇은 수의근
 - ▶ 안검부 안륜근: 무의식적으로 눈을 감을 때 사용
 - ▶ 안와부 안륜근: 눈을 질끈 감는데 사용(의식적으로)
- 신경: 안면신경의 측두지와 관골지의 지배

- 안면마비가 심해지면 눈을 못 감음

- 상안검거근, 안륜근 꼭 알아두기!!

안부속기관 - 누기

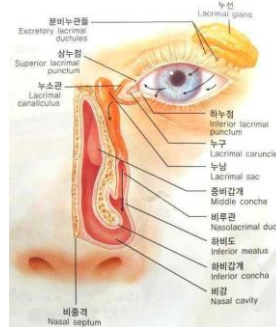
- 눈물을 분비하는 누선과 이를 배출하는 누도로 구성

1) 누선

주누선	부누선
- 누선와 속에 길이 약 20mm, 폭 12mm - 안와부와 안검부로 구분	- 크라우제 및 볼프링 선 등이 상·하 안검의 결막에 약 50여개 존재

2) 누도

- 주·부누선 → 상·하누점 → 누소관 → 누낭 → 비루관 → 하비갑개 (비강의 하비도)
- 눈물이 빠져나가는 경로
- 상·하누점: 눈물점
- 극도로 많은 눈물이 나게 되면 코로도 나올 수 있음



안부속기관 - 누액

★ 각막의 표면이 건조하지 않은 이유는 ()이 눈물막의 break-up time보다 더 빠르기 때문이다. (05,07,09,11,13)

- 한쪽 눈에 $6\mu\text{L}$ 씩, pH 7.4의 약 알칼리성의 투명한 액체
 - 약 98.2%가 물로 구성
 - 성인에서 약 $1.2\mu\text{L}/\text{day}$ 누액 분비
- 누액의 기능
 - 균일한 각막표면유지: 광학적기능 향상
 - 각막에 영양공급
 - 이물질제거: 노폐물 세척작용
 - 유허작용
 - 살균작용
 - ▶ IgA: 바이러스 중화, 각막 표면 박테리아 결합을 방해
 - ▶ IgG: 식균작용을 증진시켜 보체에 의한 박테리아 용해



- ▶ IgE: 알러지성 염증시 증가

- 각막건조 방지

- 누액막: 지질층(약 0.5nm), 중간수분층(약 8nm), 점액층(약 0.5nm)

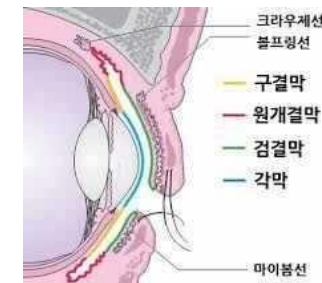
→ 점액층은 결막 관련 / 지방층이 있어야지 수분 증발을 막아줌

- 각막의 표면이 건조하지 않은 이유는 순목운동이 눈물막의 Break-up time(누액층 파열 시간: TBUT)보다 더 빠르기 때문

- 눈물 자체가 표면을 매끄럽게 만들어주는 역할 → 광학적으로 물체가 뚜렷하게 보임

안부속기관 - 결막

- 검결막, 원개결막, 구결막의 3부분
- 결막상피는 안검연에서 피부의 표피에, 각막윤부에서 각막상피에 각각 연속
- 상피세포층, 고유층(분비선층, 섬유층)의 2층 구조
- 분비선
 - 배상세포: 상피세포층에 분포하여 점액을 분비함으로써 결막, 각막을 자윤하고 보호
 - 부누선: 원개결막하에 위치하여 누액을 분비
- 신경: 삼차신경의 안분지
- 淚丘: 내안각의 황색 융기물
 - 눈을 감을 때 내안각부의 눈물을 남김없이 누점쪽으로 보내는 기능



안구

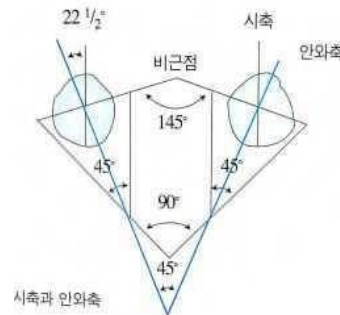
★ 안축은 내벽과 ()의 각을 이루며 시축과 내벽은 평행하다. (05)

- 정상 성인에서 전후 길이가 평균 24mm, 용적은 약 6.5cc.
- 안축: 안구에서 각막의 중앙을 전극, 공막후면의 중앙을 후극 이라 하며, 이 양극을 잇는 선
- 시축: 망막의 중심와와 눈의 주시점을 연결하는 선
- 안축은 내벽과 (22.5°)의 각을 이루며 시축은 내벽과 평행

→ 약간은 눈알이 밖으로 도는 방향성을 띄게 됨

→ 물체를 입체적으로 볼 수 있게 해줌

- 성인 안축
 - 평균길이: 24mm
 - 고도근시: 27mm - 초점이 앞에서 잡힘
 - 고도원시: 22mm - 초점이 뒤에서 잡힘

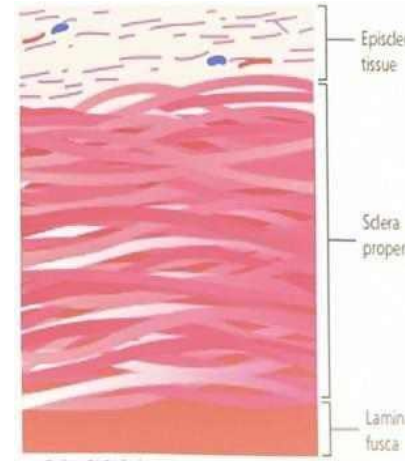


- 사람의 눈이 평면상에 있다면 안축=시축. But, 입체적으로 있어 각도가 약간 어긋나 있어 안축과 시축이 같지 않아지고 이로 인해 공간을 판단할 수 있음

안구 - 공막

★ 공막이 각막과 다르게 불투명한 구조인 이유를 쓰시오. (12)

- 후면 5/6을 차지하는 견고하고 불투명한 흰색의 섬유조직
- 전면은 각막윤부와, 후면은 시신경초와 연결
- 안구의 형태 유지 및 보호 기능



- 조직학적으로 3개층: 공막외층(상공막), 공막실질층, 공막 내층
- 상공막: 얇고 미세한 탄력섬유층, 공막에 영양을 공급하는 많은 혈관(상공막 혈관), 안구에서 외안근의 견에 의해 연결
- 공막실질층: 공막의 대부분을 구성, 교원섬유다발, 크기 다양, 불규칙배열, 많은 수분 함유 (65~70%)
- 공막내층: 갈색판(색소세포에 의해 갈색; 멜라닌색소), 맥락막과 연결
- 영양공급: 상공막의 혈관들, 맥락막의 혈관망으로부터 공급
- 신경: 장·단 모양신경이 풍부하여 염증이나 손상시 통증이 심하고, 황달시 색소침착.

- 공막의 실질층이 흰색을 띄는 이유 : 많은 수분 함유

→ 공막과 각막의 차이 꼭 알아두기!!

테논낭

★ 일명 안구집이라고 불리는 안구 주위를 둘러싸고 있는 섬유상 막으로, 안와 내에서 안구의 위치를 안정시키고 지지하며, 외안근이 안구를 움직이게 하는 것을 가능하게 하고 뒤로는 시신경의 공막 부착부에서 앞으로는 외안근의 근초를 지나 각막윤부에서 2mm 떨어진 곳에 이르며 공막 및 시신경초와 유착되어 있는 섬유성 막은? (09,11)

- 안구 주위를 둘러싸고 안구를 안와지방과 경계를 짓는 얇은 섬유성 막(안구집)
- 뒤로는 시신경의 공막 부착부에서부터 앞으로는 외안근의 근초를 지나 각막윤부에서 2mm 떨어진 곳에 이르며 공막 및 시신경초와 유착
- 기능

- 안와내에서 안구의 위치를 안정시키고 지지해줌
- 외안근이 안구를 움직이게 하는 것을 가능하게 함
- 안구 적출시 테논낭은 의안의 소켓역할을 함
- 공막의 일부

안구 - 각막

★ 각막이 공막과 다르게 투명성을 유지할 수 있는 이유는? (05,08,09,10,11,13,14,15)

★ 각막은 안구를 보호하는 방파막의 역할과 동시에 광선을 굴절시켜 망막에 도달시키는 작용을 하며, 굴절력은 대략 +()dioptr의 렌즈와 같다. ~ (05,07,09,11,12,13)

- 안구의 앞쪽 1/6을 차지(약 3㎢의 면적)
- 투명한 무혈관 조직
- 굴절력: + 43 Diopter
- 형태
 - 가로(11.5mm), 세로(10.5mm)의 횡타원형
 - 변연부 약 1.2mm두께로 중심부(0.9mm)쪽으로 갈수록 점차 얇아지는 오목렌즈형
- 기능
 - 안구보호
 - 광선을 굴절시켜 망막에 도달시키는 작용
- 각막의 투명성유지 → 각막과 공막의 투명성 차이 이유
 - 균일한 구조
 - 무혈관성
 - 낮은 수분 함유량(탈수상태)
 - 상피 및 내피세포의 Na⁺-K⁺ 펌프 작용
- 1~3번이 중요. 꼭 알아두기!!
- 조직학적으로 5층 구조
- 영양공급: 각막윤부의 혈관막(전후결막동맥), 누액, 전방수
- 지각신경: 삼차신경 안분지, 특히 상피에 신경말단이 풍부하게 분포하여 작은 자극에도 심한 통증, 유루 등을 일으킴
 - 각막상피의 손상: 일시적이며, 국소적인 손상, 국소종창을 수반
 - 각막내피의 손상: 각막의 현저한 부종과 투명도의 상실초래
- 각막 내피의 손상이 예후가 더 좋지 않음 → 각막상피는 여러 층, 각막내피는 하나의

층으로 구성 → 각막상피의 손상은 일시적, 국소적인 반면, 각막내피의 손상은 스펀지에 물이 차듯이 부종이 생기고 혼탁이 생기며, 시력에도 영향을 줄 수 있음

안구 - 포도막

- 홍채, 모양체, 맥락막의 3부분으로 구성
- 풍부한 색소를 함유한 혈관성 조직
- 각막과 공막에 의해 보호되고 망막에 영양을 공급
- 눈으로 들어오는 광선을 조절하거나 차단
- 광학적 매질은 없다
- 암실효과를 갖는다 → 눈을 어둡게 만들어서 확실하게 상이 맺히게 함
- 자가면역 기능이 강하다

포도막의 구성_홍채, 모양체, 맥락막

① 홍채

- 직경 12mm, 두께 0.5mm의 윤상판. 그 중앙에 형성된 원형의 공간을 동공
- 동공연에서 바깥쪽으로 약2mm 되는 곳이 가장 두텁고 모양체연(홍채근부)이 가장 얇은 구조
- 각막과 수정체 사이에 위치하여 전방과 후방을 구분
- 기능: 안구내로 들어오는 광선의 양을 조절
 - 동공괄약근: 부교감신경(축동)
 - 동공산대근: 교감신경(산대)
- 다량의 색소와 혈관, 감각신경이 풍부 → 염증 발생시 삼출물, 통증이 심함

② 모양체

- 전(홍채근부), 후(맥락막의 앞쪽 끝), 외측(공막), 내측(수정체 적도부)을 감싸고 있는 직각삼각 형 모양으로 평활근과 혈관조직으로 구성
- 冠部(모양체 전면 약 2mm폭의 부분): 수정체와 연결
- 평면부(모양체 후면의 약 4mm폭의 부위): 맥락막과 연결
- 기능
 - 수정체 조절기능
 - 방수액 생산 및 배출기능

- 모양체근 수축 → Schlemm관이 열리면서 모양체소대가 늘어짐 → 수정체가 두꺼워짐 → 굴절력이 증가하여 근시
- 모양체근 이완 → 모양체소대가 당겨짐 → 수정체 얇아짐 → 굴절력이 감소하여 원시

③ 맥락막

- 망막과 공막 사이, 0.1~0.2mm 두께의 혈관막
- 시신경유두연에서부터 시작하여 망막의 주변부 끝인 거상연에서 모양체로 이행
- 기능
 - 주로 망막의 바깥층 1/3 부분의 영양 담당
 - 풍부한 색소를 이용해 광선을 차단하여 안구 내에 암실 형성
 - 공막에 영양공급
- 맥락막의 혈액용량은 안구 공급 총혈액량의 약 65% → 혈관이 잔뜩 분포함
- 4개 층으로 구성
 - 맥락막 상층: 교원, 탄력섬유
 - 혈관층: 가장 많은 부분
 - 모세혈관층: 망막 외층 영양공급
 - 브루크막: 색소상피 기저막과 맥락막, 모세혈관 내피 기저막. 물질이동 → 맥락막이 망막과 붙어있는 부위가 브루크막. 나이가 들면서 생기는 황반변성 같은 질병들이 브루크막의 기능이 떨어지면서 발생하기 때문에 강조하심

방수액

- 성분: 약 0.2ml의 투명한 액체로 전방(80%), 후방(20%) 분포. 포도당, 아미노산, 고농도의 아스코르빈산이 함유
- 순환: 모양체 상피 → 후방 → 동공 → 전방 → 슬렘관으로 흡수(유출된 방수의 90%)
- 기능
 - 안압을 일정하게 유지
 - 각막과 수정체에 확산에 의해 영양을 공급
 - 각막을 광학적으로 적당한 형태가 되도록 유지

안구 - 수정체

★ 수정체는 각막과 같이 안구에서 렌즈역할을 하는 기관으로, 혈관, 신경, 결체조직이 없고 수분구 성은 약 ()%로 인체에서 가장 낮으며, 굴절률은 +()diopter의 볼록렌즈와 같다. (14,15)

- 혈관, 신경, 결체조직이 없어 무색투명 구조
- 두께는 4mm, 직경은 9mm의 볼록렌즈 모양(약 +20 Diopter)
- 기능: 각막과 더불어 광선을 굴절시키는 굴절장치
- 구성
 - 65%의 수분 → 인체 중 최소
 - 35%의 단백질
 - ▶ 수용성(85%)
 - ▶ 불용성(15%) → 증가하면 백내장
- 영양공급: 방수, 유리체에서
- 조직학적으로 수정체낭, 전면상피, 수정체섬유로 구성
 - 수정체낭: 탄성의 균질한 반투과성 막. 주변부가 두툼하고 전면이 후면보다 두텁다.
 - 전면상피: 전면의 단층 입방체 모양의 세포 적도부에서 수정체 섬유로 진행
 - 수정체 섬유: 양파껍질 모양의 층을 이루고 수정체의 투명도에 관여. 중심을 향해 진행하여 수 정체핵, 수정체 피질을 형성

안구 - 유리체

- 무색 투명하고 혈관이 없는 gel, 안구용적 및 무게의 2/3 차지
- 기저는 평면부 상피와 거상연 뒤의 망막에 단단히 부착
- 영양공급: 모양체, 맥락막, 망막에서 공급
- 성분: 수분(99%), collagen과 hyaluronic acid(1%)
- 기능
 - 안구 형태와 투명도 유지
 - 안구내압을 15~20mmHg 유지

클로케관(Cloquet canal) → 참고

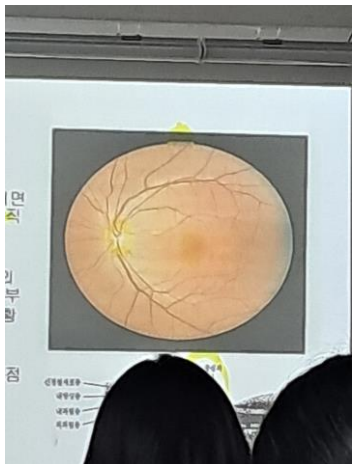
- 태생기에 유리체 동맥이 있었던 부분
- 유리체 동맥은 태생 후 곧 소실되나 이 관은 그대로 남아 후수정체강에서부터 시신

경유두 전면 까지 이름

- 그 앞쪽이 수정체 후면에 붙은 흑점으로 보일 수 있음(미텐도르프점)

안구 - 망막

- 안구 후방 $\frac{2}{3}$ 부위
 - 맥락막 내면을 덮고 있는 투명한 신경조직
 - 망막내의 특수한 부위
 - 황반
 - 시신경 유두의 약 3.5mm 외측 약간 아래에 타원형 함몰부
 - 엽황소가 많아 갈색. 주위(황반륜반사)
 - 중심와
 - 황반 중앙 가장 함몰 부위
 - 점상반사
 - 추체만 존재
 - 물체를 볼 때 가장 뚜렷하게 보는 부위
 - 시신경유두
 - 시신경 섬유로만 구성
 - 시야검사에서 생리적 암점
 - 왼쪽 시신경유두 있는 곳이 코쪽 / 황반은 바깥쪽
- 사진을 통해 안구의 좌우구분 가능



- 조직학적으로 10층

- 1) 색소상피층: 맥락막과 연결
- 2) 시세포층: 추체, 간체
- 3) 외경계막: 시세포 외절
- 4) 외과립층: 시세포의 핵
- 5) 외망상층: 시세포의 축삭, 양극세포의 수지상돌기 등
- 6) 내과립층: 양극세포의 핵
- 7) 내망상층: 양극세포의 축삭, 신경절 세포의 수지상돌기
- 8) 신경절세포층: 신경절세포 핵
- 9) 신경섬유층: 신경절세포 축삭
- 10) 내경계막: 유리체막과 결합

추체와 간체

① 추체

- 약 600만개, 밤에 주로 합성
- 시색소, 밝은 광선에 민감하게 반응
- 적, 녹, 청색에 대한 시색소
 - Red cone: 추체의 74%차지, 적색(570nm)에 민감
 - Green cone: 추체의 10%차지, 녹색(535nm)에 민감
 - Blue cone: 추체의 16%차지, 청색(440nm)에 민감

② 간체

- 약 1억 2000만개, 낮에 주로 합성
- 시물질인 시홍(rhodopsin)은 빛에 매우 민감하여 대체로 어두운 곳에서 작용
- 간체의 밀도가 제일 높은 곳은 중심와에서 약 3~4mm정도 떨어진 곳, 그래서 야간시는 중심시보다 주변시가 더 좋다.

망막의 혈액공급

★ 망막의 혈액공급에서 망막 바깥 1/3은 맥락막의 모세혈관, 내측 2/3은 망막중심동맥이고, 중심 와는 ()이다. (14,15)

★ 망막의 혈액공급을 망막 바깥1/3, 망막 안쪽 2/3, 중심와로 나누어 설명하시오. (12,13)

- 망막바깥 1/3 → 맥락막 모세혈관층
- 망막안쪽 2/3 → 망막 중심 동맥의 분지
- 중심와 → 맥락막 모세혈관 → 특히 더 강조하심

- 망막박리가 되면 돌이킬 수 없는 손상
 - 초기 망막박리가 발생하면 양방에서 레이저로 강제로 붙임
- 망막의 혈관벽은 아주 투명하고 혈관의 색깔은 혈액내의 산소량에 따라 다르게 나타남
 - 세동맥: 좁은 빛 반사가 있음 (희끗희끗)
 - 정맥: 빛 반사가 없음 (검고 어두움)

외안근

★ 외안근과 지배신경(서술-07~19)

- 상직근, 하직근, 내직근, 외직근, 상사근, 하사근으로 구성
- 상사근과 하사근의 작용시 안구의 움직임 생각
 - 4개의 직근 / 2개의 사근 : 눈을 사방으로 움직일 수 있게 해줌
 - 안구를 돌리는 역할을 사근들이 해줌
- 안위: 안구의 운동에 따라 변하는 안구의 위치
 - 제1안위: 머리를 직시하고 눈높이의 물체를 멀리 볼 때 안구위치
 - 제2안위: 제1안위에서 수직축, 수평축 중심으로 상, 하, 내, 외전
 - 제3안위: 제1안위에서 사선으로 회전한 상태
 - 안정안위: 잠잘 때 안구의 위치로서 양안의 융합 중단시 눈의 상, 하, 내, 외로 계속 불규칙 적인 회전을 함

근육	상직근	하직근	내직근	외직근	상사근	하사근
기시	총건륜				총건륜 상내측	누낭구 이측
길이(mm)	40.8	40.6	40.8	40.6	60	37
정지	윤부와의 거리				상외직근간	하외직근간
	8mm	6mm	5mm	7mm		
지배신경	동안	동안	동안	외전	활차	동안
분포혈관	전모양 동맥				안동맥	

혈액공급

- 망막중심혈관 계통(안저검사)
 - 망막중심동맥(시신경유두) → 상·하 후 내·외로 분지 → 모세혈관망 → 동맥과 같은 명칭의 4개 정맥 → 해면정맥동
- 모양체혈관 계통
 - 전모양체동맥(4개 직근의 근육동맥): 공막위, 내로 분지 → 각막연 혈관망, 대홍채동맥륜
 - 후모양체동맥
 - ▶ 장후모양체동맥(2지): 시신경양측 → 맥락막을 지나 모양체 도달 → 대·소홍채동맥륜 형성

- ▶ 단후모양체동맥(비측, 이측): 5개분지 → 시신경주위에서 맥락막에 들어가 모세혈관 구성

시신경

- 시신경유두에서 시신경교차 전까지 42~50mm
- 망막 신경절세포에서 나온 약100만개의 축삭으로 구성
 - 안내부: 시신경유두에서 공막의 사상판을 통과하는 부위까지(약 1mm 정도)
- ▶수초 X
 - 안와내부: 약 30mm의 "S"자형으로 안구운동에 유리
- ▶초막(뇌막에서 유래)
 - 시신경관내부: 시신경이 두개골을 통과하는 시신경관의 부위(6~10mm)
- ▶골막에 고정
 - 두개강내부: 시신경 교차부 전까지의 부위(약 10mm 정도)

눈의 자양물질

★ 해부학적 명칭(서술-05,07)

한의학	서양의학	한의학	서양의학
瞳神(동신)	동공	目系(목계)	눈과 연결된 경락
神膏(신고)	유리체	內瞼(내검)	검결막
神光(신광)	자연적인 精華	瞼弦(검현)	안검연
眞血(진혈)	눈을 유양하는 血	白睛(백정)	구결막, 공막
眞氣(진기)	눈에서 발생, 왕래하는 氣	黑睛(흑정)	각막
眞精(진정)	눈에 있는 精, 津液	黃仁(황인)	홍채
神水(신수)	방수, 눈물	神衣(신의)	맥락막, 망막
黃精(황정)	수정체	眼眶(안광)	안와골

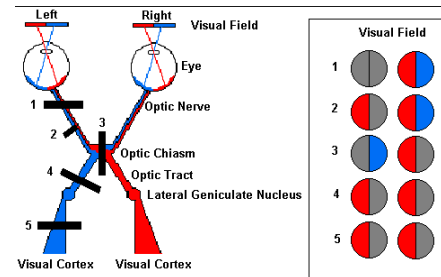
시로

- 시각정보가 망막의 광감수기에서 시작하여 후두엽의 시각 중추인 시피질에 전달되기까지의 경로
- 경로: 시신경 → 시신경교차

시신경교차

★ 시신경이 지나가는 시로에서 시신경 교차부분에 결손이 발생했을 때 생기는 시야결손은? (12,14,15,19)

- 시신경교차에 문제가 생기면 양외측이 보이지 않음
- 양안의 바깥쪽 시야 상실



- 1번 위치의 손상: 시신경의 전체 손상 / 좌안 전체의 시력 상실
- 2번 위치의 손상: 왼쪽 시신경의 부분적 손상 / 좌안의 코쪽 시야(nasal visual field) 상실
- 3번 위치의 손상: 시신경교차(optic chiasm)의 신경섬유 손상 / 양안의 바깥쪽(temporal: lateral) 시야 상실
- 4번 위치의 손상: 시각로(optic tract) 손상 / 양안의 우측 시력 상실
- 5번 위치의 손상: 가쪽무릎 ~ 겉질까지의 신경섬유다발 손상 / 양안의 우측 시력 상실

02 눈의 검사

눈의 검사 - 문진법

- 눈의 특수한 구조 및 생리기능 때문에 임상에서 주로 望診과 問診을 중요시함
- 問診(눈의 자각증상, 병력사, 기왕력, 개인생활, 혼인력, 가족력)
 - 인터뷰: 환자가 진찰받으러 온 동기
 - ▶ 주소증(발생빈도, 시기, 위치, 지속시간, 연관증상 등)
 - ▶ 환자가 필요로 하는 시기능(직업, 취미, 운전 등)
 - 설문
 - ▶ 먼저 신경학적 혹은 안과적 질환이 있는지 감별질문
 - ▶ 환자의 안과적 과거력, 전신질환 과거력, 가족력 등
 - 요약: 주소증과 여러 정보를 자신의 용어로 정리 요약

기본검사 - 외안부검사

★ 각막 지각 검사(객관-12,13,14,15)

★ 각막지각검사를 시행했을 때 반응이 다른 것은? (객관-19)

- 항상 우측 → 좌측, 또는 건강한 눈 → 환측 눈의 순서
 - 안검과 안검열: 안검하수, 안검부종
 - 침모와 안검연: 침모난생, 안검내반, 안검외반
 - 안구의 위치: 돌출, 내함
 - 결막: 맥립종, 산립종, 트라코마, 춘계 결막염, 결막충혈 등
 - 각막: 궤양, 부종, 혼탁, 색소침착, 각막환, 백내장
 - 순목검사: 각막지각검사
 - ▶ 증가: 찰과상, 이물, 렌즈착용
 - ▶ 감소: 수술, 외상후 반흔, 포진, 안면신경마비, 전신마취



기본검사 - 시력검사

- 최소가시시력: 눈으로 느낄 수 있는 최소 광선량
- 최소분리시력: 떨어져 있는 두 점을 두 개로 인식하는 최소간격
- 최소가독시력: 읽고 판단할 수 있는 문자 또는 형태의 최소 크기
- 한천식 시시력표: 조명 200 lux, 5m, 피검자가 우안, 좌안, 양안 순서로 검사
 - 손가락세기(counting finger): 30cm
 - 손흔들(hand motion): 30cm
 - 빛 방향 알아보기(Light projection)
 - 빛 느낌(Light perception)
- 기록: 교정시력(Vcc, VAcc), 우안(OD), 좌안(OS), 양안(OU), 나안(Vsc; 안경을 벗고 볼 때 시력)
- 失明, 弱視

기본검사 - 굴절검사

- 굴절이상은 각막과 수정체의 굴절력과 눈의 길이에 의해 결정
 - 검안경검사: 검안경렌즈를 삽입하여 안저를 명확히 보는 것. -3~-5D 렌즈 삽입시 분명함
 - 망막검영법: 주시 시표(5m)를 직시하게 한 후 50cm거리에서 우안-우안, 좌안-좌안 검사. 중화 (-2D 근시), 역행, 동행
 - 각막곡률계: 각막중심 2.5mm 직경부 표면의 만곡반경 측정
 - 자각적 검사: 굴절상태 측정후 검안렌즈세트의 렌즈로 좌우 단안교정 후 양안교정

기본검사 - 동공반사

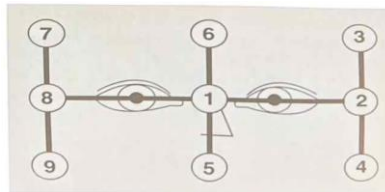
★ 정상동공의 크기는 3.5mm이고 ()이하면 축동이고 ()이상이면 산동이다. (08)

- 평균 3.5mm(2~4mm)
- 4mm이상 → 산동(mydriasis)
- 2mm이하 → 축동(miosis)
- 근시안 > 정시안 > 원시안 동공
- 환자에서 60~90cm 거리에서
 - 우안의 직접반사: 우안에 빛을 비추면서 우동공 변화 관찰
 - 좌안의 간접반사: 우안에 빛을 비추면서 좌동공 변화 관찰
 - 좌안의 직접반사
 - 우안의 간접반사
- 교대불빛검사: 불빛을 한쪽에 3~5초 비추었다 반대쪽을 검사. 2~3회 반복시행

기본검사 - 안구운동

★ 외안근과 지배신경(서술-07~18)

- 방법: 연필로 먼저 먼 곳을 보도록 하여 開散을, 환자의 코에서부터 50~90mm 거리에서 멈춘 후 輻輳를 관찰
- 외안근의 기능 검사시 6개 기본방향(우측, 좌측, 상우측, 상좌측, 하우측, 하좌측) 눈운동을 관찰
- 마비성 사시: 외안근과 지배하는 신경마비로 발생
 - 근육이 마비되어 움직여지지 않음
- 비마비성 사시: 물체를 보려고 조절을 할 경우에 안구가 내측이나 외측으로 편위가 발생. 특히 피로하거나 장시간에 걸쳐서 물체를 주시한 후에 교대성이나 간헐성 사시 발생
- 안구의 기본 방향에 따라 어떤 근육이 움직이는지
- Ex. 왼쪽눈
 - 내측(1) = 내직근 / 외측(2) = 외직근
 - 상외측(3) = 상직근 / 하외측(4) = 하직근
 - 하내측(5) = 상사근 / 상내측(6) = 하사근



기본검사 - 세극동검사

- 특수 조명장치와 현미경으로 구성
 - 보통 10배~16배로 확대 관찰
- 세극광선을 안구에 비치게 되면 각막, 전방, 홍채, 수정체 등이 세극광선에 의해 횡단되어 그 단면을 현미경을 통하여 관찰
- 특수한 보조기구를 환자의 눈에 부착시키면 유리체의 뒷부분과 망막, 전방각까지 상세히 관찰

기본검사 - 안압측정

- 지측법: 상안검 위로 검판 상단에 양손 검지 놓고 측정
- 안압계측량법
 - 함입안압계: 쉬와츠 안압계(안압계추의 무게에 의해 막대가 각막을 누름)
 - 압평안압계: 골드만 압평안압계(각막의 일정한 면적을 편평하게 만드는데 필요한 힘을 측정하여 안압을 재는 것)
- 정상 안압은 10~21mmHg
 - 낮을 때: 심한 탈수상태, 안구위축, 망막 맥락막 박리, 안구 천공상 등
 - 높을 때: 녹내장

기본검사 - 안저검사

- 직상검안경검사: 검안경을 통해 약 15배의 확대된 망막상을 관찰 가능
- 도상검안경검사: 양안도상검안경을 머리에 쓰고 +14~+30D의 볼록렌즈를 손으로 들고 렌즈를 통해 안저를 검사하는 방법.
- +14D의 렌즈로 약 5배의 확대된 망막상이 상하좌우가 바뀌어져 보임
- 세극등 검안법: 특수한 렌즈를 각막에 부착시켜 안저를 관찰

특수검사 - 시야측정

- 시야: 황반의 중심와 이외 망막에서 볼 수 있는 시력, 주변시
- 물체의 형태 및 색채에 대해서는 선명하지 못하지만 물체의 움직임에는 예민
- 시야측정법
 - 대면검사: 환자(우안)-검사자(좌안), 50~100cm 거리
 - 주변시야측정: 반경 330mm의 등근 호형판, 8방향 이상 검사
 - 중심시야측정: 탄젠트 스크린 1~2m에서 측정(평면시야계), 중심반경 30도 이내 시야 특성
 - 자동시야계측정: 프로그램된 검사시표를 이용 반응결과를 명암도로 표시
- 정상시야: 귀쪽 90, 코쪽 60, 위쪽 50, 아래쪽 70
- 시야장애
 - 협착: 시표의 색이나 크기에 관계없이 보이지 않게 된 시야결손이 있는 곳
 - 감도저하
 - ▶ 전반적 저하: 매체혼탁(각막반흔, 유리체 혼탁, 백내장)
 - ▶ 국소적 저하: 가장 흔한 형태. 양이측반맹, 전동측반맹, 양비측반맹
 - 암점: 정상 또는 비정상적인 시야 내에서 부분 또는 완전한 흠이 있는 지역. 절대암점, 상대암점, 중심암점, 중심부근암점, 맹점중심암점, 부분암점
 - ▶ 다 보이는 것처럼 느껴지지만 실제로는 존재함

특수검사 - 색각검사

- 추체가 3원색(빨, 초, 파)을 감수하는 것
- 색각장애
 - 색맹: 감광색소가 결핍되어 완전히 색을 감별하는 능력이 없는 것
 - ▶ 2원색시, 단원색시
 - ▶ 치료 가능성 없음
 - 색약: 색을 변별하는 능력이 부족한 것
 - ▶ 3원색시의 이상
 - ▶ 치료 가능성 있음
- 검사: 가성동색표인 한색각검사표.
 - “읽은 페이지수/검사한 페이지수”로 기록
- 우리나라에서 전체 인구 중 약 8%가 색각 이상
 - 대부분 남자
 - 3원색시 > 2원색시
 - 청색약, 청색맹은 매우 희소
 - ▶ 적색과 녹색은 파장이 비슷해서



특수검사 - 광각검사

- 광각: 광선의 강도 차이를 구별할 수 있는 능력.
 - 최소광선량, 최소광선차
- 검사: 주로 암순응검사. 암실에서 최소 30~40분간 머물러 있게 하여 검사를 실시
 - 명순응(30~40초): 추체
 - 암순응(50~60분에 최고조): 간체
- 야맹: 선천성, 후천성. 비타민 결핍, 망막 및 맥락막의 광범위한 병변
- 주맹: 전색맹, 각막 및 수정체 동공중앙부의 혼탁

안외이상검사 - 누기검사

★ 35세 환자가 눈물흘림증으로 내원했다. 이에 할 수 있는 검사방법 2가지와 누액과다분비를 나타 내는 질환 2가지는? (08,14) (15: 누액감소분비)

★ 누액분비이상 시 시행하는 검사와 누액분비 과다, 누액분비 감소 시 발병 질환을 각각 하나씩 쓰시오 (08)

★ 누액분비 이상이 있을 경우 시행하는 검사 2가지를 쓰시오. (10)

- 눈물의 반사적 분비: 삼차신경 안분지(각막, 결막, 비점막 자극)
 - **쉬르머 검사**: 용지를 하안검 외측 1/3에 놓고 5분 후 젖은 부분 길이 측정
 - ▶ 저하(10mm이하)
 - **눈물막 파괴시간 검사(TBUT)**: 점액양 측정.
 - ▶ 플루레신 염색(녹색)후 세극등 현미경으로 염색막 균열 시까지 시간 측정
 - ▶ 정상(13초), 눈물막 불안정(10초 이내)
- 누액분비이상
 - **누액분비과다**: 주로 배출장애. 갑상선, 알레르기, 각막질환 등
 - **누액분비저하**: RA, 비타민 A결핍, 중년이후 정상 생리현상 등
- 피눈물: 대상궤양, 결막출혈, 누낭종양, 고혈압환자의 비출혈시
- 악어눈물: 벨마비 후유증 → 저작할 때마다 신경이 눈물샘까지 자극해서 눈물이 남

안외이상검사 - 안구돌출검사

- 안와 공간내 안구의 위치를 검사하여 안구돌출, 안구함몰의 유무 확인
- Hertel 안구돌출계를 사용.
- 정상안구돌출계치: 10~14mm정도. 양안 차이가 2mm이상이면 임상적으로 의미
- 원인: 대부분 안와용적의 증대로 인함
 - 외안근마비 등도 원인
- 가성안구돌출: 고도근시, 牛眼, 눈꺼풀후퇴

안이비 2 주차

<써머리 참고사항>

- 검은 글씨 : 강의자료 PPT 내용
- 회색 음영 : PPT 빈칸
- ★노란 음영 : 기출
- 빨간 글씨 : 중요 내용
- 회색 글씨 : 교수님 말씀

<목차>

3.눈의 생리

0) 안과 오장육부의 관계

1) 안과 경락, 경근, 기경팔맥과의 관계

4. 눈의 병인병리

5.일반적인 눈의증상

6.변증 및 치료

0)내치법

1)외치법

2)침구치료

7.관리 및 예방법

각론

0)

제3장

눈의생리

1. 眼과 五臟六腑와의 관계

- 1) 肝・膽의 관계
안 간 담
- 2) 心・小腸의 관계
심 소장
- 3) 脾・胃와의 관계
비 위
- 4) 肺・大腸의 관계
폐 대장
- 5) 腎・膀胱의 관계
신 방광
- 6) 三焦와의 관계
삼초

《靈樞大惑論》“五藏六府之精氣, 皆上注于目而爲之精 目者, 五藏六府之精也..”

영주 대혹론 오장육부부지정기 개상주우목이위지정 목자 오장육부부지정야
Q.교과서p.47 ★眼과 오장과의 관계를 종합적으로 설명하시오.

- 눈이 만물을 보고 장단을 살피며 오색을 변별하는 생리기능을 정상적으로 발휘하도록 하는 것은 심주혈, 간장혈하여 눈을 개규함으로 가능하게 됨.
- 심혈이 충족되고 간혈이 왕성하며 간기가 조달될 때만 腎에 저장된 오장육부의 精氣가 비폐기의 유포와 운화의 도움을 신 정 기 받아 경맥을 끊임없이 순환하여 눈에 주입된 결과임.
- 반대로 장부기능의 실조로 편성/편소의 상태가 되어 정기, 진액, 혈 등이 위로 눈에 관개하지 못하거나, 장부에 사기가 침범하여 경맥을 통해 눈에 침입하여도 눈 부위에 각종 병리변화가 나타남.
- 따라서 임상에서 안부의 국소적인 병변을 제외하고는 반드시 상응하는 장부기능의 성쇠를 관찰하고 분석하여 전체적으로 종합/분석하여 정확한 진단을 하자.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - 肝開竅于目
<small>간개규우목</small> | - 脾輸精氣, 上貫于目
<small>비주통혈 혈양목규</small> |
| - 肝受血而能視
<small>간수혈이능시</small> | - 脾主統血, 血養目竅
<small>비주통혈 혈양목규</small> |
| - 肝氣通于目
<small>간기통우목</small> | - 脾主肌肉, 瞼能開合
<small>비주기육 검능개합</small> |
| - 泪爲肝液
<small>물위간액</small> | |
| - 肝脈上連目系
<small>간맥상연목계</small> | |

2. 眼과 經絡, 經筋, 奇經八脈과의 關係

1) 十二經脈의 關係

2) 奇經八脈의 關係

크게 안 중요 - 임맥, 독맥, 양교맥, 음교맥

#《靈樞邪氣臟腑病形論》“十二經脈三百六十五絡其氣血皆上于面而走空竅其精陽氣上注于目而爲睛.” 365락이 다 들어온다고 봄. 임상적으로 보면 아래와 같다.

- 足陽明胃經

눈에 주로 많이 분포(거기에 간경, 신경 정도가 추가된다고 보면 됨).

- 足太陽膀胱經

- 足少陽膽經

- 手陽明大腸經

- 手太陽小腸經

- 手少陽三焦經

- 足厥陰肝經

- 手少陰心經

- 足太陽經筋: 상안검

- 足陽明經筋: 하안검

- 足少陽經筋: 외자

- 手太陽經筋: 외자에 연결

- 手少陽經筋: 외자에 연결

- 手陽明經筋: 태양,소양과 교회

수삼양경은 외자 쪽 등과 서로 간접적으로 연결되어 있다고 본다.

《靈樞大惑論》“五藏六府之精氣, 皆上注于目而爲之精. 精之窠爲眼, 骨之精爲瞳子. 골지정이 동자가 되고, 筋之精爲黑眼. 근지정이 흑안이 되고, 血之精爲絡. 혈지정이 락이 되고, 其窠氣之精爲白眼. 기지정이 백안이 되고, 肌肉之精爲約束. 기육지정이 약속(=눈꺼풀)이 되고, 裹結筋骨血氣之精而與脈并爲系, 上屬于腦, 後出于項中.”

원문 그대로를 배속시킨 게 아래의 표 <<眼과 五輪★★★★>>

★ 안과 오륜 및 배속장부를 쓰시오. (05) / ★ 안과 오륜과의 관계에서 상하안검에 대해 오륜학적 설명 (08)

간	심	비	폐	신
흑정	대, 소자	상, 하안검	백정 (폐 관련)	동신
風輪	血輪	肉輪	氣輪	水輪
筋精	血精	肉精	氣精	骨精
膏汁 내포, 瞳神 영양	君火(대), 相火(소)	動靜 동정	가장 堅固, 氣를 주관	물체를 봄

눈에서는 오륜이 매우 중요. 오륜과 각각에 배속되는 장부를 잘 알아두면 각 질환의 병리변화를 파악하기 쉬

眼과 八廓 - 굳이 기억할 필요 없고, 이런 학설이 있구나~정도만 알고 넘어가면 됩니다.

乾卦(天廓) 건 제 천 역	肺, 大腸 폐 대 장	傳導廓 전 도 역
兌卦(澤廓) 대 제 택 역	腎, 膀胱 신 방 광	津液廓 진 액 역
離卦(火廓) 리 제 화 역	心, 命門 심 명 문	抱陽廓 포 양 역
震卦(雷廓) 진 제 태 역	心, 小腸 심 소 장	關泉廓 관 천 역
巽卦(風廓) 손 제 풍 역	肝絡中焦 간 덕 중 조	養和廓 양 화 역
坎卦(水廓) 곤 제 수 역	腎絡下焦 신 락 하 조	會陰廓 회 음 역
艮卦(山廓) 간 제 산 역	肝, 膽 간 담	淸淨廓 청 정 역
坤卦(地廓) 곤 제 지 역	脾, 胃 비 위	水穀廓 수 곡 역

外障과 內障 - 개념 잘 이해할

구분	外障(눈바깥에서부터) 외 장 외부로 노출된 부분	內障(백내장 등..(눈속에서부터) 내 장 시야의 문제 like 비문증
발생	肉輪, 血輪, 氣輪, 風輪에 발생 육 룰, 혈 룰, 기 룰, 풍 룰	水輪에 발생(수정체, 유리체,망막) 수 룰
병변	胞瞼, 兩眦, 白睛, 黑睛의 병변 포 검 양 자 백 정 흑 정	瞳神 및 그 뒤 안내 조직의 병변. 검안경, 안저촬영 등의 검사 요망
병인	病因: 六淫, 外傷이 주. 食滯, 濕毒, 痰火 병 인 육 음 외 상 식 체 습 독 담 화 등으로도 유발	病因: 七情傷, 시력 과도, 피로 과도 등이 주. 외傷으로도 유발 병 인 칠 정 상 외 상
특징	- 돌발적, 변화가 신속 - 外症 分명(胞腫如桃, 瞼弦赤爛, 上胞下垂) 국소 자각증상(眼痒, 眼痛, 羞明, 流淚) 가렵고 아프고 눈 붓고 등.. 및 전신증상 (風熱頭痛, 二便不利) 뚜렷 외 증 분 명 포 종 여 도 검 현 적 만 상 포 하 수 풍 열 두 통 이 변 부 리	특징: 모두 視物昏蒙을 수반. 1) 瞳神 外관이 정상: 暴盲, 青盲, 螢星滿目, 夜盲 등 동 신 외 관 시 물 문 몽 폭 맹 청 맹 형 성 만 목 야 맹 2) 瞳神 外관이 이상: 瞳神緊小, 瞳神散大, 綠風內障, 圓翳內障 동 신 긴 소 동 신 산 대 녹 풍 내 장 원 에 내 장 (녹내장, 백내장 등)
허실	대부분 實證. 虛證(上胞下垂)도 있음 실 증 허 증 상 포 하 수	대부분 虛證, 초기(虛證, 實證, 虛實夾雜證 등 겸함) 허 증 허 증 실 증 허 실 잡 증

4.翳와 膜

예	막
흑정상(각막, 수정체 쪽) 혼탁. 시력저하 각막의 손상! 흑정 자체의 염증반응이나 손상으로 인해 혼탁이 온 것	백정 혹은 흑정과외의 경계부에서 一片의 障이 일어나 白色 혹은 赤色을 띠면서 점차 黑睛의 中央으로 만연되는 것 막이 하나 일어나 백/적색을 띠면서 점차 흑정을 덮는 것
❶ 新翳 급성 - 회백색 혼탁, 거친 표면, 경계 모호, 진행 신속 - 목적동통, 유루 등을 수반	적색을 띠수록, 동신을 덮을수록 重症 (赤膜下垂 → 赤脈下垂 → 血翳包睛) *각막을 감싸므로 혈예포정이라 표현함
❷ 宿翳 만성 - 혼탁 표면 광활, 경계 분명, 진행 신속하지 않음 - 적통, 유루 등을 수반 안 함	★ 백막과 적막의 구분 ❶ 적막 - 혈관이 밀집된 것. 肝肺風熱. 대부분 實證 ❷ 백막 - 혈관이 보이지 않는 것. 肺氣壅實. 虛中夾實 인체 내 어떤 조직이 만들어지면 처음에는 백색으로 보이는데(백막), 여기에 혈관들이 들어오면서 적막으로 바뀐다.

cf) 胬肉: 眥部에서 白睛을 가로질러 黑睛의 표면으로 들어감. 心肺熱壅

위에서 아래가 아니라 가로로! 야외에서 일을 많이 하시는 농부 등이 햇볕, 자외선, 먼지 등에 의해
백정 쪽에 구결막이 자극을 많이 받으면 내자에서부터 살이 자라 오르는 것.

★ 적막과 노육을 감별하시오. (17)

감별 point1. 증식방향

적막 = 위(백정)에서 아래(흑정)로 세로로 증식해 나감.

노육 = 내자쪽에서 백정을 향해 가로로 증식해 나감.

감별 point2. 병리

적막 = 백정이 폐 관련, 흑정이 간 관련이므로 폐와 간과 관련된 병리로 봄(肝肺風熱)

노육 = 내자가 심장 관련, 백정이 폐 관련이므로 병리를 심폐열로 봄(心肺熱壅)

5.紅腫

실증	선홍색, 단단하고 紅痛 (단단한게 실증에 가까움)
허증	담홍색, 연하고 不紅不痛, 혹은 微紅微痛

6.眵

실증	眵가 많고 硬結. 稠膿(熱盛) 아침에 눈곱이 끼는데 돌덩이처럼 딱딱한 것 粘膠(濕熱) 끈적끈적한 느낌 -> 습열
허증	眵가 적고 不硬結 단단하게 뭉쳐지지 않음

7.流淚 눈물의 허실 → 뜨겁냐, 차갑냐

실증	熱淚(肝經風熱) 뜨거운 듯한 눈물
허증	冷淚(肝腎不足) 뜨겁지 않은 눈물

7.眼昏, 8. 眼盲

	안혼	안맹
실증	시력 갑자기 저하	- 暴盲 - 갑자기 시력 저하 혹은 상실. 火, 熱, 瘀 上攻 - ex) 급성 폐쇄성 녹내장
허증	시력 완만히 저하	- 青盲 - 외관상 정상이고 翳障도 없으나 서서히 진행되는 시력 저하 - 脾虛氣弱, 肝腎陰虛 - 소아에서 발생하면 小兒青盲 - ex) 당뇨, 고혈압 합병증 등으로 발생

10.夜盲

肝虛雀目 간허작목	비타민 A 결핍증(야맹증). 후천적으로 섭취가 부족하여 생김. 肝虛血少. 소아 疳積上目으로 발생(小兒雀目)
高風雀目 고풍작목	선천적, 태어날 때부터 문제. 선천 품부부족, 命門火衰로 陽이 亢盛되는 陰을 制約하지 못함. 高風內障

11.妄視

망 시

妄視 망 시	외관 양호, 눈앞에 없는 것이 있는 것처럼(귀신 보는 거), 혹은 사물의 색이 변하여 보이는 것
視感證 시혹증	외관 정상, 사물이 변형, 전도되어 보이거나 혹은 옅은 그림자가 가려 보이는 것
雲霧移睛 운무이정	痰濁, 肝腎不足 눈앞의 티끌 같은 먼지를 눈동자가 다 따라가는 것 담 탁 간 신 부④족
視物變形 시물변형	痰濁, 肝腎不足 물체가 변형되어 보이는 것 담 탁 간 신 부④족
視一爲二 시일위이	風痰阻絡, 陰虛血少(허증) 하나를 봤는데 2개가 보인다. (복시 or 난시). 풍담초박 음허혈소

11번 망시의 구분이 매우 애매하나 교수님이 말씀하신 구분점.
1. 망시는 아예없는게 있는것처럼 / 시혹증은 일자인 막대기가 s자로 휘어보이는 것.
3 번 운무이정은 수정체에 뭔가가 들어갔을 때 나타나는 증상을 말함.

12. 近視(=양허음성)

근 시

- 먼 것은 모호하고 가까운 것은 잘 보이는 것
- 陽氣不足으로 陽虛陰盛, 혹은 神傷, 氣弱하여 目中神光이 외부로 發越하지 못해 발생

양 기 불④족 양 허 음 성 신 상 기 약 목 중 신 광 발 월

- 경도(-2D 이하) / 중등도(-2~-6D) / 고도(-6D 이상)

13.遠視

원 시

- 먼 것은 잘 보이고 가까운 것은 잘 보이지 않는 것
- 양기는 충족이 되어 있는데 음이 부족 → 陰虛陽盛
음 허 양 성
- 腎陰不足, 陰精虧損되어 陽을 수렴하지 못해 神光이 산란되어 발생
신 음 불④족 음 정 유 손 양 신 광
- 아이들의 경우 책을 눈에 지나치게 가깝게 대고 눈을 심하게 찌푸림 / 어른은 노안과 혼동하기 쉬움
- 안정피로: 원시로 인해 눈이 피로하고 머리가 아픈 증상

+cf) 난시, 약시

① 난시

- 두 점 이상의 초점으로 글씨가 퍼져 보이거나 찌그러져 보임
- 대부분 각막 난시

② 약시(lazy eye; 게으른 눈)

- 구조 이상 없는데 교정시력이 잘 나오지 않는 상태, 양안 시력이 시표판의 차이가 2줄 이상 일 때 낮은 쪽
- (가장 큰 요인 두 가지): 사시, 폐용약시(한쪽 눈을 계속 가리고 있으면 그쪽 눈에 약시가 생길 수 있음), 굴절부등약시(선천적인 문제 등)
- 6세 이전에 치료 효과

14. 일반적인 眼底症狀

안 저 증 상④

- 내장안병 범주. 안저검사 필요

充血 충 혈	시신경유두나 망막 충혈. 염증초기	肝氣鬱結, 血瘀阻滯 간 기 울 결 혈 어 조 제
水腫 수 종	시신경유두나 망막 수종. 염증기, 두개내압 증가	水濕停留, 肺脾腎 三臟의 機能失調 수 습 정 류④ 폐 비 신 삼 장 기 능 실 조 물이 참 → 수습제거약 用 (이수약, 오령산 계통)
滲出物 오 출 물	망막이나 유리체의 솜덩어리 삼출물	痰濕 등의 病理 產物 담 습 병 리④ 산 물
出血 출 혈	시신경유두, 망막, 맥락막, 유리체 출혈	熱邪 迫血妄行, 心肝脾 3臟과 관련 열 사 맥 혈 망 행④ 심 간 비
循環障礙 순 환 장 애	안저혈관의 경련, 阻塞 조 색④	氣滯血瘀, 肝臟과 관련 기 제 혈 어 간 장
增殖 증 식	유리체 증식, 망막 신생혈관, 색소 증식 등 항상 신생혈관은 출혈 고려. 동맥류(뇌동맥류 - 신생혈관의 일종). 압력이 순간적으로 올라가면 터질 확률 up	氣滯血瘀, 痰濕蘊結 기 제 혈 어 담 습 운 결
變性, 萎縮 변 성 위 축	망막, 유리체의 퇴행성 변화 ex) 노인성 황반변성: 시력이 점차 떨어지게 됨	久病, 氣血不足, 先天稟賦不足 구 병 기 혈 부④족 선 천 품 부④족

제6장 변증 및 치료(1) 내치법

- 內障眼病 : 內治 위주
내장안병 내치
- 外障眼病 : 點眼, 洗眼, 敷眼, 手術 등의 外治 배합
외장안병 점안 세안 부안 수술 외치

1. 내치법

1) 거풍해표법	① 疏散風熱法 眼痒澀 가렵고 까끌거림, 熱淚頻流 눈물남, 羞明 눈부심, 灼熱痛, 眵多, 胞臉腫脹, 白睛紅赤하면서 전신증상(惡風發熱, 頭痛, 鼻塞, 脈浮數 등)을 수반 洗肝明目湯 『萬病回春』 아폴론 눈병, 결막염 등에 가장 많이 쓰이는 처방 중 하나. 대부분의 눈병 초기에 사용 治一切風熱 引起眼目赤腫疼痛方. 일절의 풍열로 인해 나타나는 목적동통 등을 치료 ② 疏散風寒法 눈병에서는 한이 거의 없으므로 크게 신경 안 써도 된다.
2) 사화해독법	*풍열이 더 안쪽으로 침범하여 열이 더 심할 때 사용하는 방법 / 급성기에 열이 더 심할 때 이용함 ★ 안질환의 내치법 중 청열사화법에 대한 설명이다. 빈칸을 채우시오. (06,10,12,13,14,15) *주된 환부가 어디냐에 따라서 5장을 배속시키면 크게 안 어렵다. ① 清熱瀉火法 瀉心火: 腎部 赤脈이 白睛을 침범, 血翳包睛, 漏睛膿出 瀉肺火: 白睛紅赤, 灼熱疼痛 瀉胃火: 胞腫赤痛, 口渴喜飲 비와 관련된 것, but 비위는 하나 瀉肝火: 黑睛生翳, 羞明, 綠風內障(녹내장) ② 清熱解毒法 火熱과 毒邪가 겸. ③ 瀉火通腑法 大便燥結이 있는 경우 ④ 清熱涼血法 內外眼에서 出血이 있는 경우
3) 자음강화법	白睛의 은은한 紅赤, 黑睛에 星翳가 보였다 없어졌다 하거나 瞳神이 乾缺하여 변형

4) 거습법	- 胞臉水腫, 瞼弦濕爛痛痒, 白睛汚黃, 混睛障, 神水混濁, 眼底滲出水腫 등이 있으면서 전신증상(頭痛如裹 머리에 비닐모자 등을 씌운 것처럼 아픔, 口不渴, 腹脹便溏 등) 수반 구부갈 복창변당 - “습열증”에 이용하는 방법 ① 清熱除濕法 진물이 많이 나오고 부어오를 때 瞼弦濕爛痛痒, 白睛汚黃 + 心煩口苦, 小便短赤, 身重 胞臉病, 兩脅病, 白睛病에서 다발 脾胃濕熱, 肝膽濕熱 ② 健脾化濕法 胞虛如球, 視物昏蒙, 眼前黑影 如蚊蠅飛舞 + 倦怠乏力, 食少納差 (허증) 포허여구 시물혼몽 안전흑영 여문승비무 권태핍력 식소납자 ③ 溫陽利濕法 (허증) 胞臉浮腫, 視神經網膜水腫, 黃斑水腫, 出血 + 小便不利, 四肢重痛, 肢冷形寒 포견부종 시신경망막수종 황반수종 출혈 소변부리 사지중통 지냉형한 ②, ③은 허증 관련 → 쓸 일이 별로 없다.
5) 리혈법	: 출혈 어혈 관련 ① 止血法 涼血止血法(출혈 대부분): 天行赤目, 血灌瞳神, 出血性 暴盲 등 + 煩熱不安, 口乾咽燥 益氣止血法: 眼內出血(血色淡紅, 血量 較多 持續) + 頭暈乏力, 少氣懶言, 面無華 혈액에 물 탄 것처럼 보임. 혈액량은 비교적 많음. 비장을 다스리면서 지혈하는 방법. 일반적인 출혈성 질환들은 익기지혈법보다는 대부분 양혈지혈법을 사용한다. ② 活血祛瘀法 胞臉腫硬紫脹, 白睛溢血, 黑睛混濁, 黃仁腫脹, 유리체 積血, 眼底出血이 오래되어 眼底 機化物, 外傷損目, 수술후 出血 후기 등 眼部 동증극렬 지속, 拒按, 동증이 한 곳에 고정 + 舌質瘀點

6) 소간이기법	★ 退赤 消腫 降眼壓 明目의 효과를 얻고자 하는 치료법으로 目赤清血 眉種骨痛 視力下降 睡神散大 眼壓上升 증상을 수반하고 전신증상으로 두훈 목적 현홍협 창동 인후이물감을 동반하는 청풍내장, 녹풍내장의 내장안병 내치법은? (08,10,13,15) - 青風內障, 綠風內障, 視瞻昏渺, 暴盲 등의 內障眼病에 많이 사용 - 目赤脹痛, 眉稜骨痛, 視力下降, 瞳神散大, 眼壓上升 등이 있으면서 전신증상(頭暈目眩, 胸脇脹悶, 咽部似有物阻 등) 수반 - 退赤, 消腫, 降眼壓, 明目의 효과를 얻고자 하는 治療法 綠風羚羊角飲『醫宗金鑑』 (녹내장에 많이 쓰는 처방) 주치: 治綠風內障, 黃風內障方 녹내장 초기 등에 안압을 낮춰줌
7) 익기양혈법	허증에서 언급됨. ① 補氣法: 上 + 기허증상 ② 補血法: 上 + 혈허증상 ③ 氣血雙補法: + 전신증상(少氣懶言, 乏力自汗, 面色蒼白 或萎黃, 心悸失眠 등)
8) 보익간신법	- 肝血(養目), 腎精(司明) ① 滋養肝腎法 - 乾澀, 無淚 或 冷淚長流, 視物昏蒙, 夜視不見, 수정체혼탁, 유리체 혼탁 + 전신증상(頭暈耳鳴, 失眠, 盜汗, 腰膝酸軟 등) - 杞菊養血湯加味 (교수님께서 많이 사용하시는 처방 중 하나) - 주치: 肝虛하여 目暗, 目昏. 神經過勞로 인한 視力障碍 ② 溫補腎陽法 - 目無光彩, 視物昏花, 變形, 視物異色, 夜盲, 안저검사상 網膜水腫 및 삼출물이 消退 않음 + 전신증상(面色淡白, 刑寒肢冷, 夜尿, 陽痿)
9) 연견산결법	- 痰濕互結하거나 氣血瘀滯로 인한 胞生痰核, 火疳, 視瞻昏渺, 雲霧移睛 등 - 胞臉腫核, 白睛 結節隆起, 안저검사상 시신경유두, 망막, 황반 水腫, 機化된 실이나 막 같은 것이 형성

10) 퇴예명목법	★ 퇴예명목법에 대해 서술하시오. (17,18) - 眼科의 독특한 치료방법 - 黑睛에 翳膜이 발생한 경우에만 적용(聚星障, 凝脂翳, 混睛障) ★ 퇴예용약의 본초 중 3가지 이상 쓰시오. (07,11,13,15) *15: 4가지 이상 - 退翳藥物: 蟬蛻, 蛇蛻, 秦皮, 木賊, 白蒺藜, 菊花, 穀精草, 密蒙花, 草決明, 青箱子, 夏枯草, 石決明 - 대부분 소산풍열, 청사간화, 퇴예명목 - 목적초: 50% 점안액이 녹농균의 각막궤양에 효과(임상 논문 결과) - 선제: 해열, 진정, 항경결, 항알레르기 작용 예막이 생겼다고 판단될 때 목적 or 진피, 밀모 등 활용
--------------	--

제6장

변증 및 치료(1) 외치법

외치법

- 外障眼病의 치료에 있어 중요

외장안병

1) 점안법

① 點眼藥粉法

- 左手로 上眼瞼을 가볍게 들어올리고 右手로 면봉을 잡아 생리식염수에 적신 후 소량의 藥粉을 원개결막부위 또는 大眦角의 눈물이 고인 부위에 직접 點入
약분 자체가 눈에 남으면 자극을 준다. 약분이 잘 녹는 것을 넣어야 함. 이거보다 점안약수법을 더 쓴다.

② 滴眼藥水法: 急性 眼病에 多用. 인공누액 넣는 법과 동일

- 洗眼湯, 黃連약침액, 프로폴리스 활용

洗眼湯 『東醫寶鑑』 고전에 나오는 대표적인 외용약

탕액을 끓여서 여러 번 걸러도 침전물이 계속 나와서 만들기 번거로움

* 黃連약침액 등을 대신 사용하기도 함

- 治暴赤眼

- 當歸, 黃連 各 4g, 赤芍藥, 防風 各 2g, 杏仁 4箇, 人乳 少許

* 人乳: 눈에 좀 더 점착하게끔 하는 약

③ 塗眼膏法: 藥粉, 濃汁에 油脂 혹은 白蜜 등의 賦形劑를 加하여 膏劑를 만들어 튜브나 작은 통에 넣어 사용. 연고는 만들기 번거로움..약수법이 보편적!

2) 혼세법

결막염 등 급성기 눈병에 사용

- 熏法: 藥液을 끓인 후 熱氣와 수증기를 눈에 쫓는 것

- 洗法: 煎湯液을 여과해 맑은 液으로 患眼을 씻어내는 것

- 外障 急症(臉弦赤爛, 風赤瘡癢, 椒瘡, 粟瘡) 등에 적용.

① 藥物敷

거즈를 적셔서 눈에 덮어두거나, 밀가루 반죽 등에 약을 섞어서 부착

- 針眼, 漏睛瘡, 暴風客熱, 天行赤目, 外傷損目, 瘀血腫痛

- 藥液敷, 布包敷, 調糊敷(밀가루 반죽 등에 섞는 거)

② 非藥物敷

비약물부

외상 후 24시간 이내에 냉찜질을 하는 것처럼, 눈도 마찬가지로 냉부시켜야 함

- 冷敷: 散熱, 涼血, 止血, 緩痛, 減輕赤腫하므로 熱毒壅盛, 紅腫焮熱, 疼痛難忍 等に 적용. 胞瞼, 眼窩의 外傷이 24시간 이내, 皮下出血

腫脹하나 破損은 없는 경우에 活用

더 부어오르지 않게 하는 것이 중요.

(24시간 이내에는 냉부해야함! 그 이후 열부시킴)

- 熱敷: 疏通經絡, 行氣活血함으로 消腫定痛, 退赤消瘀를 돕고 아울러 膿

형성 및 潰破되는 것을 促進해 주기 위해 目赤腫痛의 證候가 있을 때

活用. 濕熱敷와 乾熱敷로 구분

4) 총세법

실험실 등에서 화학약품이 들어갔을 때 빠르게 물이나 약물로 씻어내는 것.

- 물이나 藥液으로 직접 眼部 結膜囊을 冲洗하는 방법

- 결막이물, 분비물 등이 많은 경우 이를 청결하게 소독하거나 눈의 화학상으로 화학물질 제거 또는 중화시키기 위해 사용

- 약액을 담은 용기와 고무관을 이용 환부를 씻어냄

5) 위락법

- 특별히 제작된 烙器나 火針에 가열하여 적당한 온도가 되면 환부를 눌러

덥히거나 지지는 방법

- 齋肉攀睛, 贅生物 등의 수술 후 재발을 예방하고 아울러 止血시킬 목적

다래끼 등을 제거하고 났을 때 지혈하기 위해 지지는 것

제6장

변증 및 치료(3) 침구치료

鍼灸治療 _ 설명하신 내용 위주로만 정리했습니다.

침구 치료①

1) 眼部周圍 常用穴位

- 睛明 및 上, 下睛明

睛明: 내직근 자극 / 上, 下睛明: 전침을 위해 用

- 承泣 및 球後

- 瞳子膠 및 絲竹空 瞳子膠: 외직근 자극

- 陽白 및 魚腰

- 攢竹 및 魚上

- 健明 및 健明₁, 健明₂: 하직근 자극

- 太陽

- 上明(HN56): 상직근 자극

- 健明(HN51), 健明₄(HN55): 상사근 자극

교수님曰

※ 침치료 시 주의사항

- 눈 치료 시 쉽게 멍들 수 있다고 환자에게 설명해야 한다. 상안검보다 하안검 쪽에 특히!
- ex) 매선침 시술 시, 안구 주위 및 안와 내에는 혈관이 풍부하여 자침 시 혈락을 손상하여 출혈이 자주 발생할 수 있다(멍).

- 공막 자체가 아주 단단한데, 각막에 기스를 내면 안 된다. 가급적 각막을 건드리지 않게!

- ex) 눈을 감으라 하면, 흑점이 위로 올라가는 경향이 조금 있다. 이때 상명 쪽을 시술하는 것을 주의(HN56)

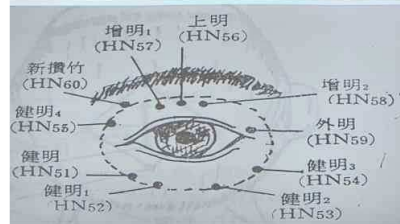
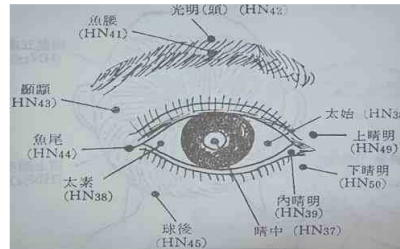
- 가급적 눈을 감은 상태에서 환자에게 턱을 쳐다보라고 하는 것이 좋다. 그러면 상안검을 뚫더라도 침이 공막을 뚫지 않을 확률이 높다. (공막은 애초에 잘 뚫리지도 않는다.)

2) 遠端部에 常用되는 穴位

- 風池, 翳風 / 合谷, 曲池, 內關 / 足三里, 三陰交, 太衝 / 肝俞, 腎俞

3) 開導法

- 삼릉침으로 환부를 放血하여 開鬱祛邪, 逐瘀消滯 시킴



4) 梅花針法

- 매화침 혹은 피부침 5~7개를 星狀으로 모아 두드리듯 자극하여 疏通經絡, 調理氣血 시킴
- 가볍게는 피부가 潮紅, 무겁게는 피부에 미량 出血 유발 미용 쪽에서 동안 만드는 등에 用
- 부위: 後頸部 및 眼窩周圍
- 적응증: 視力低下, 眼睛疲勞

5) 電鍼法

- 적응증: 目偏視, 口眼喎斜 및 內障眼病

- 전침 자극이 너무 강하면 다른 부위보다 鍼量이 쉽게 발생

6) 耳針法

- 耳尖, 神門, 目1, 目2, 腎, 肝, 脾, 口, 心, 肺, 眼, 面頰穴 등

7) 藥鍼療法

- 藥液을 소독 주사기에 담아 穴位에 주입. 頭面(0.3~0.5ml), 四肢(1~2ml), 胸 (0.5~1ml), 腰臀(2~10ml) 환자가 부담가짐 → 용량을 조금 더 약하게 하는 것이 좋다.

8) 艾灸法

- 眼病의 虛證이나 風, 寒, 濕邪로 인한 眼病에 사용

針刺麻醉

- 針眼, 目疔, 胬肉攀睛, 胞生痰核, 目偏視, 漏睛, 圓翳內障 등의 手術에 활용 가능

1) 體針麻醉에 사용되는 穴位

- 攢竹, 陽白, 魚腰, 球後, 承泣, 四白
- 合谷, 支溝, 內關
- 耳針(肺, 神門, 目1, 目2)

2) 體針麻醉의 方法

- 손으로 行針하거나 電針을 써서 마취에 필요한 자극을 유도
- 15~20분 정도 誘導한 후에 수술을 개시. 體針, 耳針은 留針

제7장 관리 및 예방법

1. 眼病의 관리

1) 의학적 관리: 전염성 안병

- 사용한 수건, 베개 등은 煮沸消毒
- 환자 단독 격리 또는 환자들끼리만 거주. 사용한 용구는 반드시 소독
- 單眼인 환자는 수면시에도 患側으로만 눕도록 한쪽 눈에 눈병이 났을 때 그쪽 눈이 밑으로

- 안약 점안시 약병이 睫毛에 접촉하지 않도록

2) 병정에 근거한 합리적인 調養

- 약물치료를 제외하고 視力, 體力, 精神 등 방면에서도 調理가 중요

3) 음식의 관리

- 흡연, 음주를 禁. 辛辣, 腥臭, 기름에 볶거나 튀긴 음식은 적게, 과일이나 야채는 많이 섭취

4) 藥物煎服法

- 辛散, 輕揚, 芳香性 藥物: 강한 불로 짧게 전탕
- 補益滋膩 藥物: 오랫동안 전탕
- 甲殼類, 礦石類 藥物: 별도 先煎

2. 眼病의 豫防

1) 外氣法

★ 안병의 예방법 중 양 손바닥을 뜨거워지도록 마찰하여 눈을 가리는 방법으로 안정피로에 활용하는 방법은? (11,12,14,15,18)

- 양 손바닥을 뜨거워지도록 마찰하여 눈을 가리는 방법. 안정피로시 활용

2) 안구자체의 導引法 외안근 강화운동

- 상하좌우로 直視한 다음 시계 방향, 반시계 방향의 순서로 回轉하며 때로 대각선으로 直視
- 6개의 外眼筋을 신장시키고 강화하여 눈을 건강하게 함

*외안근 6개 방향을 가장 기본 방향으로 세팅 → 그거 이외의 시계, 반시계 방향 등을 첨가하면 됨.

3) 안구의 刺戟法 마사지

- 눈을 감은 상태에서 上眼瞼 아래의 안구를 手指로 지그시 누르거나 回轉시키고 또는 안쪽에서 바깥쪽으로 쓸면서 마사지하는 方法

4) 안와 및 안구 주변의 刺戟法

- 안구 주변과 眼瞼, 前額, 觀骨, 鼻根을 누르거나 문지르고 回轉시켜 자극을 주는 것
- 睛明, 攢竹, 攢竹下 三分의 天應, 四白, 太陽, 絲竹空, 瞳子膠, 魚腰, 承泣穴을 활용

cf) 일상에서 눈 건강 유지법

1. 때때로 하던 일을 멈추고 눈을 쉬게 한다.
2. 눈을 자주 깜빡인다.
3. 텔레비전은 적어도 2.5m, 화면크기의 5배 이상 떨어져 본다.
4. 책과의 거리는 35~50cm 를 유지한다.
5. 야간 공부시 반드시 이중조명을 이용한다.

cf) 계절에 따른 눈 관리

- 봄 - 꽃가루, 황사 등에 의한 알레르기성 결막염
- 여름 - 유행성 각결막염, 강한 자외선 조심
- 가을 - 외상, 알레르기성 결막염
- 겨울 - 안구 건조증

- 눈을 감고 있거나 창 밖의 먼 산을 바라본다. 먼 곳의 녹색을 바라보면 좋다.
- 근거리 작업 50분 작업, 5분 휴식
- 방 전체를 밝게 하고, 스탠드는 앉은 위치의 왼쪽 조금 뒤에서 비추도록 위치함

눈 깜빡이는 횟수 컴퓨터 등 전자기기를 오래 보면 눈이 적게 깜빡임 → 안구건조

- 정상시: 12~15회/분
- 독서시: 10회/분
- 컴퓨터: 7회/분

안과학각론

목차

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. 안검질환 | 8. 수정체질환 |
| 2. 눈물 및 눈물배출계질환 | 9. 유리체질환 |
| 3. 결막질환 | 10. 망막질환 |
| 4. 공막질환 | 11. 시신경질환 |
| 5. 각막질환 | 12. 굴절 이상 |
| 6. 포도막질환 | 13. 사시 |
| 7. 녹내장 | 14. 전신질환과 동반된 안질환 |

제1장 안검질환

★ 안검은 오륜 중에 ()에 해당하니 비위와 관련되고, 주로 외부의 영향을 받아 병이 생기는데 외인은 (), 내인은 ()이다. (12,13,15,18) / 답: 육륜, 풍열, 비위습열

- 眼胞 및 眼瞼은 肉輪인 脾胃와 유관. 대부분 외인(풍열), 내인(비위습열)

아래와 같이 양방병명과 한방병명을 매칭하는 것이 중요한데, 風赤瘡癢와 같이 꼭 1대1이 아닌 경우도 있음

1. 눈꺼풀 피부염: 瞼弦赤爛, 風赤瘡癢, 胎風赤爛
2. 맥립증: 瞼硬黏睛, 鍼眼, 眼瞼癰, 眼丹, 土疳, 偷鍼, 目眦瘍
3. 산립증: 胞生痰核
4. 안검 단독: 風赤瘡癢
5. 안검 대상포진: 風赤瘡癢, 癍瘡入眼
6. 눈꺼풀테염: 瞼弦赤爛, 兩瞼黏睛
7. 눈꺼풀 속말림: 皮急緊小, 瞼急眼小
8. 눈꺼풀 겹말림: 皮翻粘瞼, 風牽瞼出, 脾翻粘瞼, 風吹出瞼
9. 눈꺼풀 떨림: 胞輪振跳
10. 속눈썹난생: 倒睫拳毛, 小兒目眨
11. 눈꺼풀 처짐: 眼瞼下垂
12. 눈꺼풀 부종: 胞虛如球, 胞腫如桃
13. 안검의 약성종양: 안검 육아종(胞肉膠凝), 안검 암종(鷄冠蜆肉)

1. 눈꺼풀 피부염

① 급성 알러지부종

- 원인: 벌레, 혈관부종, 두드러기, 약물
- 증상: 안와주위와 안검에 돌연 통증없는 우묵부종(pitting edema)
- 치료: 항히스타민제 전신투여

② 접촉피부염

- 원인: 국소약의 성분, 보존제
- 증상: 안검종창, 홍반, 유루, 소양. 심하면 홍반지속, 피부비후, 딱지 형성
- 치료: 원인물질 제거

③ 아토피 피부염

- 매우 흔한 특발성 질환. 종종 천식이나 고초열과 연관되어 발생
- 항상 전신적인 피부염과 동반
- 증상: 안검 비후, 딱지, 수직틈새 발생. 포도상구균 안검연염이나 눈썹탈락증과 동반
- 치료: 피부연화제, 약한 국소 스테로이드
- 동반증상: 어린이(봄철 각결막염), 성인(만성 각결막염)

★ <風赤瘡癢>

- 洋: 안검습진, 대상포진, 단순포진, 아토피 피부염
- 증상: 안검피부가 癢痒, 朱砂 바른 듯 紅腫, 疼痛, 점차 水疱, 發疹, 粘液이 滲出, 膿疱, 潰破後 膿血, 糜爛, 結痂. 失治하면 翳膜 발생
- 변증론치: 風盛(消風散加減)/濕熱(清脾散加減)/血虛風燥(當歸飲子加減)/외치(고삼탕)

2. 맥립종(Hordeolum)(다래끼)

★ 맥립종의 ① 한방병명을 2가지 이상 쓰고, ② 내맥립종과 ③ 외맥립종으로 구분하여 설명하시오.

① 내맥립종

- 개요: 마이봄선의 급성포도상구균 감염에 의한 농양
- 증상: 검판 내의 통증, 압통이 있는 종창. 병변이 점점 커지다가 결막을 통해 뒤쪽, 또는 피부를 통해 앞쪽으로 배농
- 치료: 결절이 남으면 절개 제거. 안쪽으로 터지면 결절이 남을 수 있음

② 외맥립종

- 개요: 모낭 및 싸이스샘, 물샘의 급성포도상구균 농양
- 증상: 검연의 압통 있는 종창이 피부를 통해 앞으로 돌출
- 치료: 온찜질, 감염된 모낭의 속눈썹을 발모

★ <鍼眼>

- 洋: 내, 외맥립종
- 증상: 안검 변연부나 眦部에 紅赤, 癢痒, 微痛微腫. 점차 麥粒狀의 硬結로 변하면서 紅腫熱痛 동반. 이후 膿點, 潰瘍
- 변증론치: 風熱(형방패독산, 은교산)/實熱(선방활명음, 통비사위탕)/膿疱나 膿點(탁리소독음)/외치(농점 절개 배농 후 소독)

★ <臉硬黏睛>

- 洋: 마이봄선의 급성 화농성 염증인 내맥립종
- 증상: 검연 내측이 紅赤, 堅硬하며 疼痛, 澁痒, 流淚 발생.甚하면 眼痛이 극심해 頭部까지 脹痛, 怕目, 羞明 등이 발생
- 변증론치
 - 1) 火毒內蘊: 五味消毒飲 合 黃連解毒湯加減
 - 2) 瘡毒內陷: 清營湯加減
 - 3) 正虛邪戀: 托裏消毒散加減

3. 산립종(Chalazion) - 콩다래끼

★ 16세 여아가 좌하안검 국소종창으로 내원하였다. 초기에 동통, 발적, 소양감은 없었다고 한다. 안검연 피부 밑에서 미립대 크기의 담핵이 촉진되고 손으로 밀어도 이동하지 않으며 피부색은 정상이다. 의심되는 한방병명과 양방병명은? (11,14,16)

- 마이봄선 낭포(meibomian cyst)
- 만성적이고 무균적인 지방육아종성 염증질환. 마이봄선 입구가 막혀 분비물이 배출되지 못해 발생
- 증상: 다양한 크기의 압통이 없고 둥글며 단단한 병변이 검판내에 발생. 간혹 여러 개이거나 양측성. 병변이 검결막을 통해 터지면 폴립모양의 결막육아종이 보임
- 치료: 종종 자연 소실. 지속시 수술, 스테로이드 국소 주사, 테트라사이클린의 전신투여

★ <胞生痰核>

- 증상: 초기 동통, 발적, 소양은 없고 안검연 피부 밑에서 米粒大의 담핵이 울결. 점차 囊狀, 豆狀으로 커지나 밀어도 이동이 없고 피부색은 정상
- 변증론치
 - 1) 痰濕: 化堅二陳丸加減
 - 2) 해조, 곤포, 패모 가미

4. 안검 단독 표재성 봉와직염

- 개요: 작은 피부상처를 통한 화농성연쇄상구균(strep, pyogenes)의 감염으로 흔하지 않은 피하로 퍼져나가는 급성 연조직염(Erysipelas)
- 증상: 眼瞼 환부는 국한성 腫脹, 丹砂를 칠한 것 같은 선홍색의 경계가 명확하고 굳은 홍반성 피하반 형성. 귀 앞 혹 턱 아래 림프선압통이 명확. 심하면 심부 조직괴사 발생. 전신에 오한발열등등 동반
- 치료: Phenoxy methyl penicillin 경구 투여
- 감별진단

다래끼: 眼瞼의 가장자리에 국한, 밀알 모양, 조기 압통점 발생, 수일 후 농 형성. 농 껍파 후 호전. 일반적으로 전신 오한발열증상 없음

- 변증론치
 - 1) 熱毒壅盛: 普濟消毒飲加減
 - 2) 毒入營血: 犀角地黄湯 合 黃連解毒湯加減

5. 안검대상포진 눈에 국한되어 생기는 대상포진

① 눈대상포진

- 원인: varicella zoster virus
- 증상: 5번 뇌신경(=삼차신경)의 첫분지 부위에 통증 발생. 점차 이마에 반구진성발진, 소수포, 농포, 궤양으로 진행. 안와주위 부종이 넓어져 양측성으로 오인
- 합병증: 결막염, 상공막염, 공막염, 전포도막염, 포진후 신경통(대상포진이 생겼던 부위가 계속 쑤시고 아프다) 등 발생
- 치료: acyclovir 구복, 연고

*대상포진은 감염 우려가 있다. → 감염방지를 위해 장갑 등 착용 필

교수님 말

※ 대상포진은 적극적으로 치료하는 것이 효과적이다. 대상포진이 처음 생겨서 방치하면 3~4일 후 물집 생 → 1주일 후 물집이 터지면서 딱지가 앉음 → 2주가 지나면 딱지까지 완전히 아물어서 떨어져 나간다.(증상이 없어진 것처럼 보임)

그러나 포진후 신경통이 남아 있으면 해당 부위에 통증이 계속 남아 있게 된다.

한방에서 대상포진을 치료하는 방법: 빨개졌을 때부터 소독약 바르고, 장갑 착용하면서 환부를 침으로 찌르고, (수포가 생기면 수포도 터트림), 이후 한약재 등을 적신 거즈를 붙인 후 말린다. → 딱지가 금방 앉게 하는 방법 → 포진후 신경통이 발생할 확률을 줄여준다.

② 단순포진

- 소수포가 모여서 발생, 며칠 후 터져 딱지 앉고 치유

단순포진보다는 대상포진이 더 독하다.

★ 眼瞼에 발생한 대상포진 또는 단순포진에 해당하는 한의학적 병명 2가지를 쓰시오. (07,10)
안 검

★ <癰瘡入眼>

- 증상: 風赤瘡瘍의 증상이 더욱 악화되어 紅腫疼痛, 乾澁, 流淚, 膿泡, 潰破, 糜爛, 結痂, 癰痕 등이 발생

- 감별: 熱瘡(뜨겁다)와 감별. 편측에 국한되지 않고 일주일내에 가피가 생기고 치유. 흉터 없음

- 변증론치

- 1) 濕熱: 眼瞼紅腫痛, 膿泡, 潰爛, 滲出 - 脾胃濕熱(청비제습음가감), 肝膽濕熱(응담사간탕가감)

- 2) 熱毒: 眼瞼皮膚 紅腫劇痛, 化膿, 潰破, 結痂, 癰痕 - 보제소독음가감

6. 눈꺼풀테염

★ 18세 여자환자로 아침 기상 후 우측 눈에서 작열감, 이물감, 가벼운 눈부심과 함께 검연이 발적되고 딱딱한 비듬이 속눈썹에 잔뜩 달라붙어 있어 내원하였다. 의심되는 ①한방병명, ②양방 병명, ③양방원인은? (12,15,18) (12: 딱딱한 비듬, 18: 부드러운 비듬)

★ 전안검연염은 작열감, 이물감, 가벼운 눈부심, 검연의 딱지와 충혈 등의 증상을 보인다. 이 질환의 ①한방병명, ②딱딱한 비듬의 원인, ③부드럽고 끈적한 비듬의 원인은? (11,13)

★ 전안검연염의 증상은 작열감, 이물감, 가벼운 눈부심과 함께 검연의 발적과 비듬이 동반된다. 이 중에서 비듬의 원인에 따라 딱딱한 비듬과 부드러운 비듬으로 나뉘는데 각각의 원인은? (17)

① 전안검연염

- 원인: 포도상구균, 지루

- 증상: 작열감, 이물감, 가벼운 눈부심, 검연의 딱지와 붉어짐

- 1) 포도상구균 안검연염: 검연의 충혈, 실팩확장증, 속눈썹기저부 주위의 딱딱한 비듬

- 2) 지루 안검연염: 검연의 충혈, 기름기 많고 속눈썹들이 서로 붙어 있음, 부드러운 비듬

- 3) 심하고 오래된 전안검연염: 포도상구균이 심하고 오래되면 검연의 비대, 흉터, 눈썹탈락증, 속눈썹증, 흰털증 발생가능

- 치료: 눈꺼풀위생(자주 세척), 항생제연고, 약한 국소스테로이드, 인공눈물

② 후안검연염

- 원인: 마이봄선의 지루, 염증

- 종류

- 1) 마이봄선 지루: 분비물 과다가 특징. 마이봄선 입구에 작은 기름방울이 맺힘, 눈물막은 기름기가 많고 거품이 있음

- 2) 마이봄선 염: 마이봄선의 염증, 폐쇄가 특징. 후안검연의 충혈, 실팩확장증과 마이봄선 폐쇄. 오래되면 마이봄선 분비물이 혼탁 농축되어 치약같이 보임. 합병증-산립증

- 치료: Tetracycline 전신투여, 온찜질로 배출 촉진. 이외 전안검연염 치료와 동일

★ <瞼弦赤爛>

- 洋: 안검연염(앞(포도상구균 감염, 지루 피부염)/뒤(마이봄선 지루))

- 증상: 瞼弦이 紅潮, 刺痒, 乾澁, 灼熱疼痛하고 점차 赤爛, 鱗屑, 白屑 등이 발생.

★ <兩瞼黏睛>

- 洋: 세균, 진균에 의한 궤양성 안검연염

- 증상: 膿潰로 인해 붓고 오래도록 낫지 않고 癢痒이 심함

7. 눈꺼풀 속말림(Entropion)

- 분류

- ❶ 퇴행: 검판이 좁은 하안검에 다발. 나이들면서 내반이 진행되면 속눈썹이 각막을 손상(거짓속눈썹증)하여 궤양과 판누스를 형성
- ❷ 반흔: 트라코마, 외상, 화학적 손상 등에 의한 검결막의 심한 흉터 형성으로 상하안검연을 안구쪽으로 잡아당겨 발생
- ❸ 선천:
 - 1) 상안검내반: 소안구증의 기계적 효과에 의해
 - 2) 하안검내반: 하견인근막의 발육부전으로 하안검과 속눈썹 전체가 내반되며 아래쌍꺼풀선이 없음

<皮急緊小>

- 증상: 상하안검의 肌肉, 筋脈이 緊縮되어 眼睛이 점차 緊小해져 乾澁不爽, 視物模糊, 羞明, 流淚, 癢痒하며 倒睫拳毛가 발생하여 안구를 자극
- 변증론치: 脾胃虛弱, 氣血不足(황기탕가감)/陰血不足(가미사물탕)

8. 눈꺼풀 겉말림(Ectropion)

- 분류 ★눈꺼풀 겉말림을 유발하는 서양학적 원인 4가지를 쓰시오. (12)

- ❶ 퇴행: 나이든 사람의 하안검에 발생. 유루, 오래되면 검판결막이 만성적 염증으로 비후, 각질화
- ❷ 흉터: 피부와 피부아래 조직의 흉터형성이나 구축으로 안검이 외반. 국소적 외상, 화상, 피부염 등
- ❸ 마비: 안면신경마비에 의한 안륜근 마비. 상하안검의 후퇴와 눈썹처짐이 동반
- ❹ 기계: 검연위 또는 바로옆에 있는 종양이 기계적으로 안검을 뒤집어서 발생

<皮翻粘瞼>

- 증상: 안검이 외측으로 뒤집혀 안구가 乾澁疼痛, 流淚不爽하고 백정, 흑정이 노출되어 混濁, 翳膜 등을 형성
- 변증론치: 風中經絡(牽正散加味)/風痰阻絡(天麻鉤藤飲加減)

9. 눈꺼풀떨림 마그네슘 부족이 대표

- 원인: 주로 과로나 스트레스. 이외 마그네슘이나 칼륨 같은 전해질 부족, 안면신경 및 동안신경 이상과 안면근육의 일시적 경련에서 발생. 녹내장과 안압상승이 심할 경우에도 발생
입가까지 떨리면서 실룩거림? → 오랜 시간 지속되면 안면신경의 주행을 확인할 필요가 있다.
마그네슘제를 열흘~2주 정도 섭취했는데 계속 떨림이 나타남? → 마그네슘 문제는 아님.
일차적으로 스트레스 의심!

- 증상: 상안검 또는 하안검이 자주 跳動, 時作時止, 특히 수면부족, 과로 혹은 사려, 독서과다하면 跳動이 더욱 빈번하며 휴식후에는 감소. 심하면 안면경련
단순하게 눈꺼풀만 떨리는 게 아니고, 안면신경이 지배하는 안면근육까지 떨리면 더 복잡해진다.

교수님 曰

입가까지 떨리면, 안면신경이 머리에서부터 주행하면서 신경과 혈관이 근접하는 부위가 있는데, 긴장하면 심장박동이 신경을 자극하게 된다.

*MRA를 찍어서 혈관이 신경과 근접된 부위가 보인다? 그때 뒤쪽을 절개해서 신경과 혈관 사이에 패드 등을 넣는 외과수술도 하기는 함! 근데 이는 얼굴 반쪽에 전체적으로 경련이 심하게 나타날 경우!

- 치료: 보툴리눔 독소 주입, 일부 근육을 절제하는 외과 수술

<胞輪振跳>

- 증상이 가벼운 사람이나 우연히 한번 발병한 사람은 치료할 필요가 없음
- 변증론치 스트레스가 있다 없다 장기간 지속됨(심비양허, 기혈휴허, 혈허 등)

- 1) 心脾兩虛, 氣血虧虛: 四物歸脾湯, 八珍湯加減
○ 비양허 기혈유허 사물귀비탕 팔진탕가감
- 2) 血虛生風: 當歸活血飲加減
혈허생풍 당귀활혈음가감

10. 속눈썹난생(Trichiasis)

- 원인: 단독 또는 만성 안검염, 눈대상포진, 트라코마 등에 의한 2차적인 안검연의 반흔의 결과로 발생
- 감별: 안검내반에 의한 거짓속눈썹증과 감별
- 증상: 속눈썹 기시부는 정상이나 방향이 뒤쪽으로 잘못된 상태. 각막상피를 손상, 오래되면 각막궤양이나 판누스 형성
- 치료: 속눈썹뽑기(4~6주내 재발), 전기분해술, 냉동요법 등

<倒睫拳毛>

- 증상: 睫毛가 눈을 자극하여 流淚, 疼痛, 癢痒, 羞明, 赤澁, 爛開되고, 손으로 비벼서 黑睛, 瞳神이 손상 점차 翳雲이 발생

11. 눈꺼풀처짐(Ptosis)

- 분류
 - ① 신경성: 동안신경마비, 눈교감신경마비 같은 신경분포결손
 - ② 근성: 중증근무력증, 근육긴장퇴행위축, 눈근육병증 등 상안검거근 자체의 근육병증이나 신경근접합부의 신경전달장애
 - ③ 건막성: 상안검거근 근막 결손
 - ④ 기계성: 덩어리나 흉터의 중력효과로 발생

- 측정

안검연각막반사간거리(MRD1; margin reflex distance 1): 환자 눈에 빛을 비추어 상안검연부터 각막반사점까지의 거리를 측정. 정상(4~4.5mm)

- 치료: 중증 근무력증을 제외하고 대부분의 눈꺼풀처짐은 수술적 치료 가능

<眼瞼下垂>

- 증상: 상안검 肌肉이 下垂되고 升擧되지 않아 동공의 일부 혹은 전부를 가리게 되어 시력 장애를 초래. 仰視하려 함

- 변증론치:

- 1) 脾虛氣陷, 中氣不足: 안검하수 + 易疲勞, 휴식후 호전, 오후 증상 심해짐 - 보중익기탕
- 2) 風痰阻絡: 돌연 안검하수 + 사시, 복시 등 - 정용탕가감
- 3) 血虛氣弱: 益氣養血, 人參養營湯加減
- 4) 先天不足, 脾腎陽虛: 어릴때부터 안검하수 - 우귀음가감

12. 눈꺼풀부종(=포검종창)

- ★ 염증성 안구돌출로 눈꺼풀 부종을 일으키는 질환 3가지는? (11,14,15)
- ★ 포검종창을 실증과 허증으로 구분하여 각각의 양, 한방명을 쓰시오. (08,17)

I. 염증성 안구돌출(=실증)

① 봉와직염

- 1) 안와격막전봉와직염: 외상, 국소감염의 확산, 원거리감염. 한쪽 압통, 발적, 안검부종발생. 안구돌출, 운동장애 없음

- 2) 세균안와봉와직염: 안와격막뒤 연조직의 세균 감염. 소아 안구돌출의 흔한 원인. 눈근육 및 시신경 기능장애 동반

- ② 급성 누선염: 안검 바깥쪽이 부어 특징적 S-모양의 안검하수와 경한 하내측 안구편위, 누선부 압통, 인접 결막 충혈

- ③ 안와골막염: 급성(·:부비동질환, 외상), 만성(·:결핵, 매독 등). 안와봉와직염과 유사

★ <胞腫如桃> 실증

- 증상: 暴腫이 발생, 紅赤 疼痛, 怕目, 羞明, 熱淚 동반. 점차 堅硬 拒按, 심하면 眼珠疼痛, 前方으로 돌출

- 변증론치: 外感風熱(은교산, 선방활명음)/肝火乘脾 濕熱(세간명목탕, 용담사간탕가미)/心經實熱(도적산가감)/脾肺壅熱(상백피탕)

II. 비염증성 안구돌출(=허증)

① 해면정맥류

- 원인: 높은 혈압이나 두 개저외상으로 안와내 정맥울혈 발생
- 증상: 박동성 안구돌출, 결막부종 및 충혈, 안압상승, 외안근마비, 시신경유두 부종 등

② 갑상선 안병증

- 임상적인 갑상선 기능항진을 보이지 않으면서 눈에 갑상선항진증의 징후가 나타남. 진행성 안구돌출
- 증상: 안와주위와 안검부종, 결막충혈 및 부종, 안검 후퇴, 안구돌출, 시신경병증(중심시력 감소로 시작), 외안근마비

★ <胞虛如球> 허증

- 증상: 안검의 腫脹이 마치 공처럼 속이 빈 것 같으면서 紅赤, 疼痛은 없고 手按 無痛
- 변증론치: 心脾虛損, 陰血不足(귀비탕가감)/脾虛, 水濕停滯(삼령백출산)/久病 氣血不足(신효황기탕, 보중익기탕)

13. 안검의 악성종양

❶ 기저세포암

- 가장 흔한 악성종양. 주로 노인에서 발생. 위험인자(흰 피부, 햇빛에의 만성적 노출)
- 안검악성종양 90% 차지. 하안검>내안각>상안검>외안각 순
- 종양은 국소적, 침습적이나 전이 안 함. 재발가능성 높음

❷ 편평세포암

- 기저세포암보다 드물지만 더 공격적. 국소림프절로 전이*기저세포암과 다른 점
- 안검악성종양의 5~10% 차지
- 하안검과 검연에 호발

<胞肉膠凝>

- 洋: 마이봄선의 만성 육아성 염증 또는 낭포, 안검의 양성종양
- 증상: 안검이나 외안각에 아교와 같은 것이 서로 膠粘, 또는 紫色의 瘰肉이 桃李狀으로 종대, 돌출. 視物模糊, 羞明, 熱淚 등 동반
- 변증론치: 風毒邪(소풍산)/脾胃積熱(통비사위탕)/외치(세안탕)

★ <鷄冠蜬肉> (암)

★ 눈과 귀의 기저세포암, 편평세포암의 한방명은? (06,07)

- 洋: 심한 감염의 산립종, 안검의 기저세포암 및 편평세포암
- 증상: 안검내에 紅肉이 닭의 벼슬(鷄冠), 가막조개의 살(蜬肉) 모양을 띠고 眦部에 까지도 발생. 청색, 홍색, 흑색을 띠고 점차 黑睛을 가려 羞明, 怕目, 澀痛 등이 동반. 심하면 瘰肉이 돌출되어 통증이 극심
- 변증론치: 脾胃積熱 + 風邪(추풍탕, 석결명산, 양격청비음)/외치(삼릉침으로 刺破)

《교수님 댁 알아줘야 할 것》

눈과 오름

한방병명-양방병명 매치(한방병명은 증상, 원인을 포함하는 경우가 있음 + 항상 1대1 대응은 아님)

눈병 중 실증은 외감사기로 인한 경우가 많은데, 어떤 과정으로 침범하는가? (위기영혈변증 관련)

Cf. 변증논치를 이해하는 것은 어렵지 않으니, 변증논치보다는 위의 내용들에 집중하기

안이비 3주차

01 눈물 및 눈물배출계질환

★ 눈물 관련 질환의 辨證으로는 實證은 (), 虛證은 ()에 해당한다. 각각의 변증을 채우시오. (10)

- 眦部: 血輪, 心 小腸 三焦와 관련

1) 실증 : 心火上炎

2) 허증 : 心陰不足, 虛火上炎

- 눈물: 肝液으로 肝膽과 관련

1) 실증 : 肝膽火盛

2) 허증 : 肝腎陰虛

- 涕: 누액의 분비이상, 누기의 배출이상, 누낭염

<참고> 누액의 분비 및 배출

- 누액: 주, 부누선 + 장액선, 분비선의 혼합액

- 눈물의 반사자극: 5뇌신경(삼차신경)의 안분지가 민감. 이외 각막 및 결막질환, 비점막 자극 등

- 안검의 순목에 의해 점액층이 상피 표면에 퍼지는 것과 동시에 끊임없이 새로운 누액층이 형성

- 정상 상태에서 TBUT이 순목의 간격보다 길기 때문에 각막표면의 건조가 발생하지 않음

- 배출: 상하누점, 누소관, 누낭, 비루관, 하비강으로 배출

눈물 흘림증

- 눈물흘림의 원인

① 눈물과다분비: 눈의 염증이나 표면질환(각막질환, 비강내 알레르기, 누선의 염증 등) 및 갑상선 질환, 신경과민 등에 의한 반사적 눈물 과다분비로 발생

② 눈물 배출로의 문제 → 대부분 눈물 흘림의 원인이 됨

차고 바람불면 심해지고 따뜻하고 건조한 실내에서는 감소.

- 누점의 위치이상: 안검외반의 2차 증상

- 폐쇄: 누점에서 비루관에 이르는 어느 부위의 폐쇄

- 눈물펌프 기능상실: 하안검 이완, 안륜근 약화(구안와사 등)

- 눈물배출로의 폐쇄

① 일차누점협착: 누점외반 없이 발생. 특발성, 단순포진 안검염, 악성안검종양 방사선치료 후, 홍터결막염 등

② 이차누점협착: 누점외반에 이차적으로 발생. 결막지지기

③ 누소관협착: 일차누점협착과 비슷

④ 비루관폐쇄: 특발성 폐쇄, 코-안와 외상, 비인두종양의 침윤, 선천성(하스너판막)

⑤ 누도결석증: 남자에 다발. 염증성 폐쇄에 의한 2차적 눈물정체로 결석을 촉진

★ <流目> = 눈물과다분비, 눈물배출장애 / 衝風冷淚

- 이명: 衝風淚出, 迎風熱淚, 迎風冷淚, 無時冷淚, 無時熱淚

- 涕: 눈물과다분비, 배출장애

- 증상

1) 熱淚(실증): 眼赤疼痛, 羞明, 眦部가 粘濁 혹은 濕潤 + 열감 눈물 → 간화

2) 冷淚(허증): 無紅腫熱痛, 눈물이 맑고 묽으며, 심하면 眼昏, 眼花 발생. 일반적 눈물흘림증 → 간혈부족, 간음허

★ 衝風冷淚의 원인, 증상, 치법, 처방을 쓰시오. (09)

- 변증론치

1) 열루: 肝火熾盛 + 外感風邪 - 용담사간탕, 당귀용회환

2) 냉루: ex) 나이 들어서 실내에 있는데 갑자기 눈물이 흐름

① 肝血不足, 復感外邪: 止淚補肝散

② 肺氣不足, 感受外邪: 補肺湯加減

③ 氣血不足, 收攝失司: 八珍湯加減

④ 肝腎兩虛, 約束無權: 左歸飲加減

만성 눈물주머니염

① 만성 누소관염

- 원인: 드문 질환. 혐기성균
- 증상: 만성 점액고름성 결막염이 동반된 유루, 누소관의 부종, 결석도 보임. 비루관 폐쇄는 無

② 만성 누낭염

- 노인이 가장 많고 청년이나 아동은 비교적 적으며, 여성이 남성보다 많음.
- 대개 외상이나 눈물주머니 결석에 의해 발생
- 증상: 유루, 내안각의 점액낭종, 누르면 점액고름의 역류
- 치료: 항생제 점적이 필요. 폐쇄증상을 감소시키는 것이 유일한 치료

<漏睛>

- 洋: 만성 누낭염, 만성 누소관염 등

- 증상

- 1) 눈의 赤腫은 확실하지 않고 大眦의 피부색이 정상 혹은 조금 紅赤
- 2) 睛明穴 下方에 작은 용기가 있어 닦으면 粘濁한 膿汁이 스며나옴.
- 3) 淚道를 물로 씻으면 膿性 분비물이 나오고 淚道가 閉塞

- 변증론치

- 1) 風熱停留: 自薇丸
- 2) 心脾濕熱: 竹葉瀉經湯
- 3) 正虛邪留: 托裏消毒飲

급성 눈물주머니염

- 원인 : 비루관의 폐쇄에 2차적으로 발생. 성인은 포도상구균 감염, 소아는 인플루엔자 감염의 결과로 발생. 비교적 드뭄
- 증상 :
 - 1) 睛明穴 하방에 돌발적으로 紅腫이 高起하고 계속해서 膿液이 유출.
 - 2) 睛明穴 부위의 압통, 붉은 긴장성 부종과 눈물흘림이 아급성으로 발생. 심한 경우 안와 사이막앞 연조직염이 동반
- 치료 : 국소 온찜질, 항생제

<漏睛瘡>

- 洋: 급성 누낭염

- 증상: 초기에 점막한 淚液이 유출, 정명혈에 홍색 腫核이 돌출, 동통 수반. 점차 홍증, 작열, 동통이 심해져 화농, 궤파되면서 농즙이 유출
- 변증론치: 발병이 급하고 병세가 맹렬하여 반드시 제때 치료해야 함

- 1) 風熱上攻: 仙方活命飲加減
- 2) 熱毒熾盛: 黃連解毒湯 加減
- 3) 正虛邪留: 托裏消毒散加減

02 결막질환

- 白睛 : 氣輪, 肺 · 大腸과 관련

<결막염증의 임상양상들>

1. 증상

- 1) 일반 증상 : 유루, 자통, 작열감, 수명 등
- 2) 통증, 이물감 : 각막침범 시사
- 3) 소양감 : 알레르기, 건성각결막염, 안검연염

2. 분비물

- 1) 물같은 분비물 : 급성 바이러스성, 급성 알레르기성 결막염
- 2) 점액성 분비물 : 봄철 결막염, 건성 각결막염
- 3) 고름성 분비물 : 심한 급성 세균감염
- 4) 점액고름성 분비물 : 약한 세균감염, 클라미디아감

3. 여포 vs 4. 유두 ★★★

- ★ 상피하 기질 속 증식된 림프조직이 부혈관신생을 동반하고 미세혈관으로 둘러싸인 0.5~5mm의 작은 쌀알형태의 명칭과 원인질환 2개를 서술하시오. (12,14,15,18)
- ★ 결막여포에 대하여 설명하시오. (08)
- ★ 상안검 내측에서 호발되며, 증식된 결막상피가 자체적으로 부풀어 올라 주름, 돌출부를 형성하여 융기된 다각형의 충혈된 부분이 창백한 홈에 의해 구별되는 미세한 모자이크 양상인 병리가 일어나는 질환명과, 이것이 일어나는 원인질환 3가지를 서술하시오. (11,13,17)
- ★ 결막 유두의 병리변화에 대해 설명하시오. (09,10)
- ★ 결막여포와 유두를 비교하여 서술하시오. (15)

	여포	유두
구성	- 상피하 기질 속 증식된 림프조직이 부혈관신생 동반. (주변이 더 붉고중심이 연함) - 미세혈관으로 둘러싸인 0.5~5mm의작은 쌀알 형태. - 여포가 커지면 혈관이 여포 기저부를 둘러싸는 혈관주머니 형태	- 증식된 결막상피가 여러 개의 주름이나 돌출부를 형성한 것. - 중심에 혈관이 있고 염증세포들이광범위하게 침윤. - 상안검결막에서 호발, 융기된 다각형의 충혈된 부분이 창백한 홈에 의해 구별되는 미세한 모자이크양상.
원인	바이러스, 클라미디아감염, 국소약제의 과민반응	만성 안검연염, 알레르기와 세균결막염, 콘택트렌즈 착용 등
예후	예후 불량	예후 양호

<결막질환의 종류>

1. 세균성 결막염 : 暴風客熱
2. 바이러스성 결막염 : 天行赤目
3. 만성 결막염 : 赤絲蟬脈
4. 춘계 각결막염 : 時復症
- * 알레르기성 결막염 : 粟癢
5. 트라코마(클라미디아성 결막염) : 椒瘡
6. 포성 결막염 : 金疳
7. 결막하출혈 : 白睛溢血
8. 익상편(군날개) : 努肉攀睛
9. 건성 각결막염 : 白澀症, 神水將枯
- * 막성 결막염 : 狀若魚胞

세균성 결막염

① 단순 세균 결막염

- 가장 흔하고 10~14일내 저절로 호전. 봄, 가을에 호발. 어린이에 다발
- 원인: 포도상구균, 인플루엔자균, 폐렴구균, 연쇄상구균 등
- 증상: 충혈, 이물감, 작열감, 밤에 삼출물 축적으로 아침에 안검이 들러붙음. 물 같은 분비물 이 하루 지나면 점액고름성으로 변화, 검결막이 벨벳같음

② 임균결막염(膿漏眼)

- 증상: 결막부종, 동통, 충혈, 고름성 분비물, 결막 위막을 형성. 진행되면 각막 궤양, 천공 형성

★ <暴風客熱> 급성 세균성 결막염

- 증상: 돌연히 안검 紅腫疼痛, 백정 紅赤, 羞明, 熱淚, 眵糞膠粘, 심하면 焮赤熱痛, 胞瞼腫脹 되어 백정 부종이 흑정보다 높게 융기되고, 失治하면 星點翳膜, 瘀血灌睛
- 변증론치 → 주로 풍열의 범주
- 1) 風盛: 강활승풍탕, 형방패독산
- 2) 熱盛: 사폐음가감, 세간명목탕
- 3) 風熱俱盛: 방풍통성산

바이러스성 결막염

★ 폭풍객열, 천행적목을 증상으로 구분하여 설명하시오.

★ 바이러스성 결막염 바이러스성 각결막염의 한방명 2개 (08)

★ 12세 여아 2일 전부터 증상 호소. 안통, 수명, 다량의 유루가 있고, 결막에 출혈 발생. 귀 앞 림프선의 종창이 있으나 각막은 정상이었다. 한방병명과 양방병명은? (12,15)

▶ 아데노 바이러스 각결막염

- 잠복기 4~10일. 결막염 발생후 약 12일간 바이러스 방출(전염)

- 분류

① **인두결막염**: 어린이 호발. 38.5 ~40도 고열, **인두통**과 양안에 급성 여포성 결막염 발생

② **유행성 각결막염**: 충혈, 심한 안통, 유루. 점차 수명, 위막, 여포, 결막하 출혈, 결막부종, **귀앞의 임파선 종창 발생**. 3~4주간 지속. 약 80%에서 **표층 상피 각막염 발생**. 이때 각막 혼탁은 수개월에서 수년에 걸쳐 소실

- 치료: 대증치료. 2주 내 자연회복

-

③ 급성 출혈성 결막염(Apollo 눈병)

- 원인: 장내 바이러스, 콕사키 바이러스 감염

- 증상: 8~48시간의 **짧은 잠복기**, 5~7일간 **짧은 경과기간**이 특징. 안통, 이물감, 수명, 다량의 유루. 점차 환측 안검홍종, 결막의 심한 충혈, 종창, 결막하 출혈, 검결막 여포 증가, 귀 앞 임파선 종창. **각막에 침범하지 않음**

→ 기간이 짧아 더 심해보이지만, 예후는 아폴로가 더 좋음

★ <天行赤目>

- 暴風客熱보다 초기증상은 경미하나 전염성이 강함(時氣邪毒)

- 洋: 바이러스성 각결막염

- 증상: 초기에는 眼瞼微腫, 沙澁한 癢痒感, 점차 白睛紅赤, 灼熱痛, 溢血星點 혹은 片狀, 怕熱, 羞明, 眵糞膠結이 단안에서 쌍안으로 발생. 심하면 흑정에 翳膜, 耳前에 腫核이 발생

- 변증론치 → 폭풍객열의 치료와 비슷

1) 初感疫病: 구풍산열음자가감

2) 熱毒熾盛: 사폐음가감

3) 외치: 세안탕

★ cf) 폭풍객열과 천행적목 감별 → 세균성, 바이러스성 구분

- 폭풍객열: 白睛溢血은 적고 星翳가 흑정 주위에 다발

- 천행적목: 白睛溢血은 항상 발생 星翳는 흑정 중앙에 다발. 오랫동안 지속됨

→ 천행적목이 더 심한 증상

cf) 천행적목, 천행적목폭예 감별 → 각막을 침범하느냐, 하지 않느냐

- 천행적목: 급성 출혈결막염(Apollo)

- 천행적목폭예: 유행성 각결막염 폭예: 각막에 혼탁이 온 것

만성결막염

- 洋: 결막의 퇴행성 질환이나 급성 결막염 후의 만성적인 결막혈관 이상

- 증상: 乾澁微痒, 灼熱淚出, 眼瞼沈重하면서 굵기나 밀집도가 서로 다른 赤脈이 白睛表面에 縱橫으로 발생, 심하면 視物昏朦해짐

<赤絲虯脈, 赤絲蟬脈> → 赤絲는 섞인다는 뜻

- 변증론치

1) 外障眼病後 熱鬱脈絡: 退熱散加減

2) 脾胃濕熱: 清脾散加減

3) 虛火上炎: 知柏地黃丸加減

춘계 각결막염

★ 춘계 각결막염에 대해 설명하시오. (18)

★ 알레르기성 결막염 또는 카타르성 결막염과 관련된 백정질환의 한방상병명 3가지 (05,09)

- 양측성, 자주 재발. 따뜻하고 건조한 기후에서 소년, 젊은 성인에서 호발. 봄철 후반이나 여름에 호발

- 증상: **심한 눈가려움**. 수명, 이물감, 작열감 동반. 진한 점성 분비물, 안검하수 동반. 상검판에 **자갈 모양 유두 비대**. **각막 표면 방패모양 궤양**, 각막판(혼탁), 가성 노년환 형성

★ <時復症>

- 洋: 춘계 카타르성 결막염
- 증상: 春夏季에 소양감이 극심하고 灼熱微痛, 수명, 유루, 沙澁不快하며 眵黃色白, 形如粘絲, 眼瞼微腫 발생. 추계에 점차 쇠퇴

★ <粟瘡>

- 洋: 알레르기성 결막염의 유두
- 증상: 안검내 비교적 큰 원형, 연한 황색(연한 붉은색)의 작은 쌀알에서 석류씨 모양의 과립으로 椒瘡보다 형태가 크나 반흔을 남기지 않고 심하면 안구를 자극 沙澁疼痛, 流淚 발생. 癢痒感 심함
- 時復症과 비슷(계절성)

★ <白澁> → 건성안(건성 각결막염)에 해당하는 내용

- 洋: 만성 결막염, 만성 카타르성 결막염
- 증상: 백정이 紅赤하지 않으나 항상 爽快不得, 沙澁微痛, 灼熱微痒, 羞明 발생.
- 시력 정상, 久視하면 안정피로 및 건조가 발생. 현미경 상 각막 표층 착색점 (건조하기 때문)

알레르기성 결막염

❶ 춘계 각결막염

- 양측성, 자주 재발. 따뜻하고 건조한 기후에서 소년, 젊은 성인에서 호발. 봄철 후반이나 여름에 호발
- 증상: 심한 눈가려움. 수명, 이물감, 작열감 동반. 진한 점성 분비물, 안검하수 동반. 상검판에 자갈 모양 유두비대. 때로 각막 표면에 방패모양 궤양, 각막판, 가성노년환 형성

❷ 알레르기 비결막염

- 눈, 코의 알레르기증 가장 흔함
- 코의 알레르기성 비염이 눈까지 파급되는 경우
- 분류
 - 계절성: 여름, 고초열, 꽃가루

- 통년성: 일년, 먼지 진드기, 곰팡이. 가을에 악화
- 증상: 갑자기 심한 분비물, 충혈, 재채기, 콧물 동반. 결막의 우유빛 부종, 안검부종

❸ 아토피 각결막염(드물지만 극심)

- 춘계 각결막염의 증상과 비슷. 단, 저절로 치유되지 않고 수년간 지속 심한 시력장애 야기
- 증상: 작열감, 이물감, 발적, 수명. 결막 유백색 충혈, 작은 유두, 각막 주변 반흔, 신생혈관 등

트라코마 - 클라미디아성 결막염

★ 개발도상국에서 다발하는 예방 가능한 실명의 가장 흔한 원인으로 상안검 내측에 미세과립이 보이다가 점차 상안 검결막, 각막윤부의 상부, 구결막 등에 회백색 괴사성 여포를 형성하고 더 진행되어 심한 반흔 및 흉터, 각막 궤양, 혼탁 등이 나타나는 질환의 1)한방 병명, 2)양방 병명을 각각 쓰시오. (11)

❶ 트라코마

- 전세계에서 예방이 가능한 실명의 가장 흔한 원인. 개발도상국에 다발(위생상태 불량관련)
- 증상: 세균성 결막염과 비슷한 증상으로 발생. 진행되어 상안검결막, 각막 윤부의 상부, 구결막 등에 회백색 괴사성 여포(Herbert 오목) 형성. 표층성 각막염 발생. 더 진행되면 심한 반흔 및 흉터, 각막궤양 및 혼탁으로 실명됨

❷ 성인클라미디아 결막염: 큰 여포가 하안 각결막에 발생

★ <椒瘡>

- 증상: 초기에는 별무증상. 점차 微痒, 流淚, 沙澁痒痛, 視物疲勞하면서 花椒狀의 미세과립 발생. 진행되어 반흔이 안검내(안검내반, 도침권모 등), 흑정내(적막하수, 취성장, 화예백함 등) 동반 失明

→ 알레르기성 : 소양감 / 세균, 클라미디아 : 삼출물

→ 세균성은 점액 / 바이러스는 물처럼

★ 결막염은 4종류가 있다. 심한소양감은 () 결막염에서 나타나고, 다량의 유루는 바이러스성 결막염에서 나타나고, 다량의 삼출액은 세균성, 클라미디아성에서 나타나고, 귀앞 림프절종창은 (), ()에서 나타난다. (09,11,12,13,14,15)

답: 알레르기성, 바이러스성, 클라미디아성

결막염의 감별 ★ → 색칠된 칸 꼭 기억해두기

	세균성	바이러스성	클라미디아성	알레르기성
소양	경함	경함	경함	심함
충혈	전반적	전반적	전반적	전반적
유루	중등도	다량	중등도	중등도
삼출액	다량	소량	다량	소량
귀앞 림프절 종창	드뭄	흔함	흔함	없음
실험실 소견	세균, 다핵구	단핵구	다핵구, 형질 세포	호산성구
인후염 및 발열	가끔	가끔	없음	없음

椒瘡, 粟瘡의 감별

초창	속창
眼胞 및 白睛에 나타나는 과립성 질환	
- 과립이 紅色, 質堅結한 花椒狀의 가늘고 작은 것. 赤脈下垂 동반	- 과립이 黃色, 質軟한 粟粒狀의 비교적 큰 것. 赤脈下垂 없음
- 트라코마의 여포(follicular)로 반구형 융기	- 알레르기성 결막염의 유두(papilla)로 편평한 융기
- 전염성 있으며 다른 안질환과 병발	- 전염성 없으며 다른 안질환과 병발 없음
- 궤양, 반흔 및 실명 가능	- 반흔을 남기지 않음

포진 결막염(포진성 결막염; 프리텐증)

- 원인: 세균, 결핵균 등에 의해 생성된 단백질에 대한 결막 또는 각막상피세포의 비특이성 지연성 과민 반응

- 증상:

- 1) 어린이에서 수명, 유루, 안검경련 등을 호소하면서 작은 크기의 연분홍색 결절상을 띠는 포진이 검열부 근처 각막연의 구결막에서 융기
- 2) 주위 결막충혈 동반. 수일 후 포진이 회색으로 변하면서 괴사, 중심부 탈락되며 신속히 회복. 1~2주 지속
- 3) 드물게 심한 재발로 각막을 침범하여 각막윤부에 기저를 둔 삼각형모양의 반흔 형성 시력장애 초래

★ 金疳과 木疳을 감별하시오. (17)

★ <金疳> 금감의 종류에 대해서 이해 잘 하기!

★ 서양의학의 포진성 결막염 또는 포진성 각결막염에 해당되지 않는 것은? (05,09,10,11)

- 이명: 白睛粒起, 金瘍玉粒

- 분류 / 악화 순서: ① → ② → ③ → ④

I. 포진성 결막염

① 金疳: 小泡가 백정 표층에 융기, 주위 홍적, 심하면 화농됨. 반흔은 남지 않음

II. 포진성 각결막염, 결핵 포도막염

② 玉粒分經: 백정, 흑정에 동시 발생, 증상이 금감보다 심함

③ 白睛侵睛: 미세한 小泡가 각막변연부에 융기되고 백정에 적맥이 얹혀있음

④ 風輪赤豆: 흑정 중앙부로 玉粒과 같은 小泡가 융기, 주위 적맥이 감싸 적두 형태(중증)

- 증상:

- 沙澁痛, 流淚, 怕目하면서 백정 표층에 粟狀과 같은 과립 혹은 玉粒狀의 小泡가 결절상으로 융기.
- 주위는 赤脈으로 紅赤. 진행되면 玉粒이 파괴되나 반흔은 남지 않음.
- 심하면 각막변연부를 침범해 궤양, 반흔을 남김

- 변증론치

- 1) 肺經燥熱: 瀉肺湯加減
- 2) 肺陰不足: 만성적 반복 - 養陰清肺湯加減
- 3) 脾肺兩虛: 參苓白朮散加減
- 4) 흑정에 玉粒 형성: 龍膽瀉肝湯加減

결막하출혈

- 원인: 외상이 많고 전신 감염(바이러스> 세균 감염), 혈관 벽의 이상, 혈액질환, 여성의 생리시기에 대상출혈 등
- 증상: 결막의 모세혈관 파열로 결막하부에 울혈이 발생. 편측성으로 갑자기 발생되어 밝은 적색을 띠나 뚜렷한 다른 증상 없음
- 대부분 50세 이상의 사람에게서 발생하고 대개 발병 2주후 자연 소실

<白睛溢血>

- 이명: 色似胭脂
- 증상: 유루, 치분, 수명, 동통 없이 백정 표층내에 一片, 點狀의 鮮紅色 血痕 발생. 경계 뚜렷, 오래되면 暗紫色, 紫色으로 변하고 7~14일 지나 자연 소실. 재발을 자주함
- 변증론치 → 어혈로 볼 수 있음, but 약 안써도 나음
- 1) 肺熱傷絡 : 퇴적산가감
- 2) 肝腎陰虛 : 육미지황탕가감
- 3) 外傷 : 도홍사물탕가감
- 4) 婦人 血熱逆經 : 조경산가감

결막 변성질환

★ 노육반정, 유금능목, 황유장을 각각 구분하시오. (05,07,08,10,17,18)

★ 익상편과 가성군날개를 구분하시오. (12)

① 익상편(군날개) = 努肉攀睛

- 변성된 구결막 조직이 각막 윤부에서 각막 쪽으로 자라 들어가는 삼각형 모양의 상피하 섬유 혈관조직.
- 남성이 여성보다 많음. 만성적 건조조건이나 자외선 노출에 대한 반응.
- 합병증: 만성적 자극증상, 시력저하, 난시, 눈물층 파괴 등

② 검열반 = 黃油障

- 매우 흔하고 무해하며 양측성
- 비측 혹은 이측 각막 윤부에 가까운 구결막에 생기는 황백색 침착물

③ 가성 군날개 = 假性 翼狀努肉(流金凌木)

- 결막의 주름이 주변부의 각막궤양이나 얇아진 곳에 부착한 것. 각막에는 꼭지만 붙어있음
- 중간 공간이 들떠 있고 양 끝만 붙어있는 형태
- 군날개처럼 보이지만 아니다. → '가성' 군날개
- 실제 군날개는 결막하부조직 모두가 각막에 부착되어 있음

★ 努肉攀睛, 黃油障, 假性 翼狀努肉(流金凌木)

① 努肉攀睛(익상편): 자부에 생긴 翼狀의 삼각형상 노육이 백정을 가로질러 흑정쪽으로 침범

② 黃油障(검열반): 담황색의 삼각형 斑塊가 脂膜처럼 백정에 나타나나 흑정은 침범하지 않고 별다른 증상 없음

③ 假性 翼狀努肉(流金凌木)(가성 군날개): 안구 외상이나 흑정 변연에 예막 형성 후 익상편과 비슷한 노육이 백정과 흑정 사이에 둘러붙음. 각막 변연부의 반흔, 궤양

- 증상: 초기에 澀痒, 微痛, 眵部에 赤脈이 점차 비후해져 蟲翼狀, 脂狀, 膏膜狀의 노육 발생. 미황색 혹은 백색을 띠면서 頭尖은 厚大하고 齊而薄한 삼각형의 주벽이 백정을 관통하며 흑정에 침범하여 視物昏暗해짐

건성안(건성각결막염)

★ 25세의 남자환자로 평소 컴퓨터 작업을 오랫동안 하는 직업으로 일하던 중 며칠부터 안구 건조감, 구건, 비건, 누액감소, 백정무광택, 흑정암담불택 등의 증상이 발생하여 로컬 안과에 서 건성 각결막염을 진단받고 내원하였다. 진찰해보니 이 외에 건해, 오후 상열감, 한출, 설 흑무태, 맥색삭 등을 수반하였다. 의심되는 한방병명 및 변증은? (15,14,10)

★ 48세의 남성으로, 평소 컴퓨터 작업을 오랫동안 하는 직업으로 일하던 중 며칠 전부터 안구 건조감, 자극감, 이물감을 호소하였다. 각막에 실 같은 점액성 분비물이 관찰되었다. 의심되는 한방병명과 실시할 수 있는 검사는? (18)

★ 건성 각결막염이 의심될 때 시행해야 하는 검사 2가지를 쓰시오. (12,13)

- 원인

① 저분비성, 비분비증: 중간물층, 내점액층의 부족.

저(쇼그렌 증후군), 비(나이/ 종양, 염증, 갑상선 눈병증으로 눈물샘조직 파괴, 심한 결막홍터로 폐쇄)

② 증발성: 외기름층, 내점액층의 부족. 폐쇄성 마이봄선기능장애, 눈물막의 재표면화결손

- 증상: 자극감, 이물감, 작열감, 실 같은 점액성 분비물

- 검사: 눈물막파괴시간, 쉬르머

- 치료: 실내 온도 감소, 가습기, 인공눈물(점안제, 겔, 연고), 눈물 배출 감소(눈물점 폐쇄)

※ 안구건조증: 눈을 자주 깜빡이는 게 도움이 될 수 있음

★ <神水將枯> 쇼그렌 증후군과 유사

- 洋: 건성안, 건성 각결막염

- 증상: 眼乾, 口乾, 鼻乾 또는 多飲, 누액감소, 白睛無光澤, 黑睛 暗淡不潤의 증상 발생. 심하면 각막혼탁, 視物昏暗 해짐

- 변증론치: 肺陰不足(생맥산 합 청조구폐탕가감), 肝腎陰虛(기국지황환), 脾虛氣弱(귀비탕가감)

<白澁>

- 洋: 만성 결막염, 만성 카타르성 결막염

- 증상: 백정이 紅赤하지 않으나 항상 爽快不得, 沙澁微痛, 灼熱微痒, 羞明 발생. 시력 정상, 久視하면 안정피로 및 건조가 발생. 현미경상 각막 표층 착색점

막성 결막염, 프리텐증

① 막성 결막염

- 원인: 디프테리아, 연쇄상구균 감염으로 발생

- 증상: 결막 부종이 가성막(바이러스, 임균 감염)보다 심하게 발생. 진짜 막이 회황색을 띠고 잘 벗겨지지 않으며 벗기면 심한 출혈 발생. 귀앞 림프절 화농, 발열, 단백뇨 등도 발생

② 프리텐증

- 원인: 세균항원에의 비특이성 지연성 과민반응. 특히 결핵균

- 증상: 소아에서 수명, 유루, 안검경련 발생. 각막윤부에 작은 연분홍색 결절이 결막출혈 동반하여 발생. 정점이 각막쪽을 향하는 삼각형 모양.

<狀若魚胞>

- 洋: 막성 결막염, 프리텐 각결막염, 각막실질염에 의한 각결막 부종

- 증상: 沙澁痛, 灼熱流淚하고 백정에 백색 또는 담홍색의 魚胞狀과 비슷한 부종이 발생. 심하면 흑정, 동신에 침범되어 예막이 발생되며 視物昏暗 해짐

- 변증론치

1) 초기 肺熱, 風熱毒 未盡: 상국음, 사백산, 사폐탕

2) 氣滯血瘀, 外傷

3) 외치: 洗眼靑皮湯으로 洗眼

03 공막질환

- 공막: 白睛의 주요 부분. 白珠, 白仁, 白眼 등으로 표현
- 공막 혈관은 적고, 혈액순환이 왕성하지 않아 상대적으로 영양 공급이 적으므로, 발병하면 병정이 길고 치료가 어려움
- 白睛은 氣輪, 肺大腸과 관련.
- 白睛에서 공막은 안구의 일부분에 불과하고 병이 肺와 밀접한 관계에서만 발생하는 것이 아니고 다른 장부와도 밀접한 관계가 있으므로 공막 질환의 치료시 정체관념으로 局部와 全身으로 병의 진행을 살펴서 辨證施治 해야 한다.

상공막염

- 젊은 성인 여성에서 흔하게 발생, 자연 치유되나 자주 재발. 50%에서 전신질환(R.A, 결절성 홍반, 결핵 등)과 병발
- 증상: 약간의 불편감, 압통, 유루를 동반한 단안성의 충혈
- 분류
- ① **단순 상공막염**: 가장 흔한 형태. 1~3주내 자연 호전. 돌발적인 미만성 충혈, 수종이 홍색을 띠. 심부혈관 충혈 및 국한성 결절은 없음
- ② **결절 상공막염**: 국소적 용기, 충혈된 결절이 특징. 담홍색

<火疳>

- 洋: 상공막염, 공막염
- 증상: 초기에 백정 심층에 자홍 혹은 암홍색의 소결절이 용기, 삼통, 수명, 유루 동반. 점차 결절이 커져 椒狀, 粟狀, 榴子狀 혹은 豆粒狀의 청자색, 청람색으로 변하고 동통이 극심
- 주로 단안, 여자에서 다발
- 변증론치
- 1) 肺熱亢盛: 瀉肺湯加減
- 2) 經期血熱: 加味逍遙散加減
- 3) 風濕侵襲: 散風除濕活血湯
- 4) 火毒熾盛: 還陰救苦湯加減
- 5) 濕熱困阻: 三仁湯加減
- 6) 腎陽不足: 腎氣丸加減
- 7) 虛火上炎: 養陰清肺湯加減

공막염

- 공막 전체 두께에 걸친 부종과 세포 침윤을 특징. 드물게 발생
- 원인 질환: RA 등의 전신질환, 수술 후, 감염성(결핵, 매독, 나병, 대상포진 등의 감염)
- 분류 및 증상
- ① **전부 공막염**(98%): 심한 자색의 미만성 충혈, 극심한 통증, 수명, 유루
- 비괴사성(85%): 미만성, 결절성
- 괴사성(13%): 공막 얇아짐
- ② **후부 공막염**(2%): 심한 안통, 안구돌출, 시력장애, 복시, 율혈유두, 삼출성 망막박리 등

<白睛靑藍>

- 증상: 백정 심층 또는 흑정 주위 백정에 淡紫紅色 결절이 반복적으로 용기. 백정이 靑藍色으로 변하며 潰瘍. 더 진행되면 黑睛 및 瞳神에 파급되어 瞳神縮小, 散大, 雲霧移睛, 綠風內障가 발생
- 변증론치 (화감의 치료법과 비슷)
- 1) 肺肝熱盛: 還陰救苦湯加減
- 2) 濕熱蘊蒸: 三仁湯加減
- 3) 陰虛火旺: 滋陰地黃丸加減

괴사성 공막염

- 염증을 동반한 전부 괴사성 공막염. 가장 심한 공막염으로 5년 이내 25% 사망
- 증상: 점진적 통증, 출혈. 통증은 점점 심해져 점차 안면 방사통을 띠
- 병리: 심부 혈관층 율혈 → 폐색으로 인한 무혈관성 구역 → 공막의 괴사, 상충부 결막의 궤양 → 백정청람 형성
- 치료: 경구용 프레드니솔론, 면역억제제 사용, 수술

<偏漏>

- 공막염의 가장 심한 형태 → 정도 : 화감 < 백정청람 < 편루
- 급성으로 발생하고 심한 통증과 국한된 충혈 및 괴사로 공막의 교원섬유가 얇아져 파괴되는 질환
- 노년 여성에게 호발
- 변증론치: 수술후 補 위주
- 1) 痰濕結聚 : 半苓祛痰湯加減
- 2) 熱毒入侵 : 五味消毒飲 合 黃連解毒湯加減

공막의 색깔변화

① 미만성 색상변화

- 노란색: 황달(원개부>각막윤부), 말라리아치료약(quinacrine: 각막윤부> 원개부)
- 청색: 공막의 콜라겐이 얇아지고 투명해지면서 그 하방의 포도막이 비쳐 보이는 것. 전부 괴사성 공막염, 선천성 녹내장

② 국소적 색깔변화

- 노년성 투명 공막: 수평 외안근의 부착부위에 난원형 짙은 회색 부위
- 혈색소증, 금속성 이물: 녹빛의 색조변화

04 각막질환

- 각막(黑睛)은 風輪, 肝膽과 관련. 더불어 瞳神을 보호 및 濡養하고 있기 때문에 風輪의 병변은 瞳神에도 영향을 미쳐 腎과도 밀접한 관계

- 翳膜: 시력 저하나 장애 초래

① 외장애막: 黑睛에 반흔, 궤양 등의 손상으로 시력저하가 발생. 外障眼病에서 가장 볼길한 징후. 크게 新翳, 老翳, 星翳, 雲翳 로 분류

- 新翳: 흑정이 흐려지는 초기 증상. 회색 혹은 회황색의 형태가 뚜렷하지 않고 더 커지고 깊이 들어감. 星翳, 凝脂翳, 花翳白陷
- 老翳: 백색 혹은 자백색의 형태가 뚜렷한 반흔이 발생하여 視物昏朦이 발생. 熟翳, 水瑕翳, 雲翳
- 星翳: 경증. 백색의 星點이 발생. 반흔 없이 낫고 반복 발생
- 雲翳: 중증. 흑정이 흐려지고 반흔이 생기며 흑정이 함몰됨

② 내장애막: 瞳神 내에 있는 眼睛이 흐려지는 것. 眼睛의 色, 部位, 形態에 따라 圓翳內障, 水翳, 橫翳 등으로 분류

각막질환의 특징 ★

- 발병기회가 많음: 外界와 직접 접촉하고 쉽게 邪毒에 침습되므로 흔한 질환
- 회복이 느림: 자체에 脈絡이 없어 영양이 부족하고 저항력이 비교적 약함
- 자각증상이 극렬: 감각이 예민하여 극렬한 眼痛, 怕光, 流淚(유루) 등 발생
- 시력에 영향을 끼침: 발병하면 종종 癍痕翳障 등이 남아 시력장애 유발

각막기질 병변

- ① 침윤: 국소 회백색 과립형 혼탁이 앞쪽 기질에 발생. 주로 세포 침윤. 충혈, **침윤 주위 달무리 동반(hallo)**. 비감염성(렌즈 착용), 감염성(세균, 바이러스, 진균 등의 감염)
- ② 부종: 각막 두께 증가, 투명도 감소. 원추각막, 각막 상피 및 내피세포의 손상
- ③ 반흔: 각막실질이나 보우만막의 손상. 백색의 치유성 반흔
- ④ 신생혈관: 많은 각막병변에서 발생. 대부분 정맥

각막질환의 징후

1) 표면 병변

- 점상 상피 미란: 작고 약간 함몰된 상피 병변. 상부(춘계 각결막염, 렌즈 착용 이상), 안검열 사이 (건성안, 자외선 노출), 하부(각막 노출, 하안검 질환, 딸기코, 안약 독성 등)
- 점상 상피 각막염: 바이러스 감염. 과립형의 투명한 상피 부종이 염색 없이 보임
- 상피 부종: 급성으로 안압 상승, 내피세포의 대상부전
- 각막실: 작은 점모양 점액가지가 상피에 싸여 각막표면에 붙음. 눈을 깜빡이면 움직임. 건성 각결 막염, 각막노출, 눈대상포진 등
- 판누스: 섬유혈관조직이 각막 윤부에서 각막상피 하부로 자라 들어오는 염증성 혹은 변성병변

2) 각막기질 병변

- 침윤: 국소 회백색 과립형 혼탁이 앞쪽 기질에 발생. 주로 세포 침윤. 충혈 동반. 침윤 주위 달무리(hallo). 비감염성(렌즈 착용), 감염성(세균, 바이러스, 진균 등의 감염)
- 부종: 각막 두께 증가, 투명도 감소, 원추각막, 각막 상피 및 내피세포의 손상
- 반흔: 각막실질이나 보우만막의 손상. 백색의 치유성 반흔
- 신생혈관: 많은 각막 병변에서 발생. 대부분 정맥임.

각막의 신생혈관

① 표재성 혈관신생

- 원인 질환: 트라코마, 나병, 각막변성 등
- 증상: 각막질환에 대한 일종의 방어작용. 상피, 보우만막, 실질 표층에 나뭇가지 모양의 분지를 하고 결막혈관과 연속됨

② 심부 혈관신생

- 원인 질환: 각막실질염
- 증상: 모양혈관에서 생겨 각막윤부에서 각막실질로 들어감
- 신생혈관은 각막부종 및 혼탁과 동반되며 무지개 현상(halo), 극심한 안통, 시력저하의 특징

★ <赤膜下垂, 血翳包睛>

- 洋: 각막 신생혈관(沙眼 진행)
- 증상: 초기 백정상연이 혼탁해지며 赤色の 미세한 血絲가 비후해져 薄膜을 형성. 점차 黑睛에 下垂. 유루, 수명, 통증, 소양 동반
- 血翳包睛: 赤膜下垂가 심해져 삼통, 작열, 유루, 두통과 赤脈이 흑정을 따라 사방에서 중앙으로 발전하여 血翳가 흑정 주위를 감쌌
- 변증론치

1) 肝肺風熱, 血熱壅滯: 歸芍紅花散

2) 心肝積熱, 熱瘀互結: 破血紅花散

★ 적막하수와 혈예포정을 구분하시오.

적막하수	혈예포정
섬유혈관이 증식해 아래로 내려오는것. 초기 백정상연이 혼탁해지며 赤色の 미세한 血絲가 비후해져 薄膜을 형성. 점차 흑정에 하수가 일어나지만, 아직 흑정을 침범하지 않은 상태	赤膜下垂가 심해져 삼통, 작열, 유루, 두통과 赤脈이 흑정을 따라 사방에서 중앙으로 발전하여 血翳가 흑정 주위를 감쌌

각막염

★ 11세 남아가 우측 눈앞의 점모양 혼탁이 커지는 것 같아 내원하였다. 과거력상 4세 때 우측 눈꺼풀 결막에 염증이 있었다. 검안경상 점상, 수지상 궤양이 각막에 보였고 플루레신 염색에서 가지끝이 두꺼워 보였다. ① 한방질환명 ② 양방질환명을 각각 쓰시오. (11,13,17,18)

- 선행요인: 콘택트렌즈 착용, 외상, 각막대상부전, 노출각막증, 각막지각감소 등 선행각막 질환, 만성누낭염, 눈물층 결핍 등
- 원인: 세균성, 진균, 바이러스 등으로 발생. 이외 여러 원인
- 증상: 초기 이물감, 충혈, 부종 발생. 진행하면 심한 통증, 무지개 halo현상, 눈부심, 유루, 고도의 시력저하

① 세균성 각막염

- 발병이 빠르고 치명적임
- 원인: 폐렴구균, 진균, 녹농균, 포도상구균, 매독, 아메바 등
- 증상: 결막과 각막윤부충혈, 각막기질부종, 침윤, 전방축농, 전부 포도막염, 각막천공, 세균성 안내염 등으로 진행

② 바이러스성 각막염

- 원인: 단순포진, 대상포진, 천연두, 아데노 바이러스 등
- 분류

★ 바이러스성 각막염에서 단순포진과 대상포진의 수지상 궤양의 특징은? (14,15)

	단순포진 각막염	대상포진 각막염
호발 연령	6개월~5세 사이 소아에서 호발	노약자(50~60세)
증상	- 일차눈감염: 안검결막염의 증상 - 재발질환: 초기 각막상피에 점상, 성상의 혼탁 발생 → 점차 수지상, 지도모양, 아메바 모양으로 확대. - 각막혼탁, 홍채염, 원판 각막염 발생	- 각막상피 뿐 아니라 각막실질, 홍채, 모양체 등에서 발병됨 - 발진 후 2일 내 수지상, 별모양 궤양 발생. 점차 동전모양(발진10일 후), 원반형(발진 3주 후) 등으로 확대
수지상 궤양★	가지 끝이 두꺼워져 있음	궤양 끝부분에 망울(bulb) 없이 가늘어지면서 끝남

<聚星障> ★ 聚星障과 銀星獨見을 구분하시오.

- 洋: 표층 점상 각막염, 포진성 각막염
- 銀星獨見: 흑정에 단독의 회백색 銀星과 유사한 一翳가 발생. 경미한 聚星障, 또는 발생 전 증상
- 증상: 초기 사삼통, 작열, 수명, 유루 + 포륜부 紅赤, 회백색 혹은 미황색 미세한 星點이 흑정상연에 발생. 점차 雲霧狀, 樹枝狀, 片狀, 地圖狀 됨. 심하면 花翳白陷과 凝脂翳로 진행
- 변증론치
 - 1) 風熱: 상국음, 형방패독산
 - 2) 肝火: 용담사간탕, 석결명산
 - 3) 肝濕熱: 오인탕
 - 3) 虛火上炎: 지백지황탕, 감로음

표층 점상 각막염 (聚星障)

- 원인: 불명. 바이러스 감염
- 증상: 각막 상피에 눈송이 모양의 난원형혼탁이 있고 플루오레신 용액에 점모양으로 염색. 눈꺼풀 연축, 경미한 시력감퇴, 눈부심 등 동반. 결막염이나 홍채염 동반 안함
- 치료: 스테로이드점안액

각막궤양

- 각막에 부종, 침윤, 화농, 괴사조직의 탈락으로 반흔성 혼탁이 되어 시력장애, 오래되면 천공으로 실명됨

① 중심성 각막궤양

- 각막중심 궤양과 전방축농으로 위험한 증상
- 원인: 상피손상 후 폐렴구균, 녹농균, 진균, 바이러스 감염

★ 응지예(세균성 각막궤양) vs 습예(진균성 각막궤양)

(1) 세균성 각막궤양 (= 응지예)

- 녹농균: 소프트렌즈 착용자에 다발. 청록색의 궤양부위 및 삼출물, 심한 동통, 시력장애를 호소

- 포도상구균: 가장 흔한 원인균. 단순포진, 건성안, 아토피 등에 의한 각막이상이 동반되면 특히 호발됨
- 폐렴구균: 최근 감소추세. 중년 이후 각막에 벼, 보리 등의 미세외상이 원인. 회색 또는 회황색 침윤

(2) 진균성 각막궤양 (= 습예)

- 예전 농부들 곡물, 먼지 등에 의한 상피 손상이 원인
- 최근 스테로이드 안약 과다사용으로 도시에서도 발생
- 회황색 원형침윤 주위 위성병소 발생
- 표면 불규칙, 건조, 동통 경미
- 전방축농 동반

(3) 바이러스성 각막궤양

- 단순포진
 - 각막염 자각증상과 각막지각 소실
 - 궤양은 각막상피만 침범하여 점상, 수지상, 지도상으로 발전
 - 전방축농은 잘 동반 안 함
- 대상포진:
 - 각막실질 이외에 홍채, 모양체까지 침범
 - 점모양 혼탁, 각막실질부종, 상피하 침윤, 파열, 궤양 형성

② 주변성 각막궤양

- (1) 변연성: 포도상구균 감염으로 다발. 통증이 매우 심함. 각막에 계란모양 혹은 선상침윤 발생 하나 윤부와 간격을 유지
- (2) 윤상: 전신 세균감염에 의한 과민반응 또는 자가면역질환의 합병증. 각막주위 궤양이 융합 하여 전 주위를 둘러쌘
- (3) 잠식성: 자가면역질환의 일종. 40세 이상 성인의 편안에 다발. 각막 주변부 침윤이 중심부로 확대됨

③ 기타 각막궤양

- (1) 건성 각결막염: 누선 분비저하
- (2) 비타민 A 결핍증: 각막연화증 각막 상피가 약해짐 (+vit.A 결핍증 => 야맹증 유발)
- (2) 신경영양(마비성) 각막염: 삼차신경 안분지 마비로 발생(바늘로 찔러도 아픔을 못 느낌)
- (3) 노출 각막염: 토안성 각막염
- (4) 매독성 각막실질염
- (6) 결핵성 각막실질염

★ 《濕翳와 凝脂翳의 鑑別》

★ 응지에는 표면이 습윤하고 굳은 기름 같으며 () 각막궤양에 해당한다. 습에는 표면이 거칠고 건조하며 치아에서 나오는 고름 같고 () 각막궤양에 해당한다. (14,15)

★ 응지에 습예를 예막의 형태와 원인균으로 구분하시오. (11,13,18)

★ 응지에, 습예를 설명하시오. (07)

	습예	응지에
誘因 유인	각막 外傷(벼 등의 식물성)	각막 外傷(일반성)
病勢 병세	진행이 완만	진행이 빠름
症狀 증상	모두 궤양이 심하고 전방축농 동반	
	자각증상은 가벼움 (통증이 상대적으로 적음)	자각증상이 심함
眵粉 치분	粘液性 점액성	膿性 농성
翳膜형태 예막	표면이 거칠고 건조하며 치아에서 나오는 고름 같음	표면이 습윤하고 굳은 기름같음
病原검사 병원	절편에 병균이 미세하게 있고 진균배양 가능	절편, 배양에서 모두 세균이 보임

凝脂翳

- 洋 : 세균성 각막궤양
- 증상 : 頭額痛, 眼痛이 극심하며 삼통, 작열, 유루, 眵囊 粘稠, 안검부종, 포륜부 紅赤하면서 흑정에 점상, 편상의 회백색 또는 아황색의 예막 발생. 중앙이 潰陷되면서 굳은 곳에 응고된 動物油脂 같은 것이 달라붙어 있음. 오래되면 瞳神缺損, 黃液上衝, 蟹睛 발생
- 치료

- 1) 항생제 투여 전 : 궤양부위 찰과 표본 채취 - 도말표본검사, 배양검사, 항생제 감수성 검사 시행
- 2) 원인균 동정되기 전 : 퀴놀론제제 단독 점안, 또는 세파졸린과 아미노글리코시드 함께 점안
- 3) 각막궤양이 심한 경우 : 항생제 결막하 주사 또는 전신투여

《凝脂翳 初期와 聚星障의 鑑別》

	응지에 초기	취성장
誘因	黑睛 淺層損傷	感冒 후
각막 지각	변화 없음	지각 감퇴
眵淚	膿性	眵粉 少 或 無
翳膜 형태	한 개의 星狀翳가 灰白色, 邊緣不清, 表面混濁 如覆薄脂	초기 다수의 針尖樣 微細星點 발생, 점차 융합하여 樹枝狀, 地圖狀을 띠
재발	無	반복 발작
화농 및 천공	化膿穿孔, 黃液上衝	不化膿, 不穿孔

濕翳

- 洋 : 진균성 각막궤양
- 증상 : 사삼통, 畏光, 유루, 점성 분비물이 있으면서 각막중심부에 회황색의 원형 침윤 발생. 표면이 평활하지 않고 건조. 통증은 凝脂翳보다 상대적으로 적음. 궤양 주위에 위성 병소 형성. 진행되면 전방축농, 불규칙한 각막내피반, 천공도 발생
- 치료
- 1) amphotericin B의 점안 또는 결막하 주사
- 2) 칸디다의 경우 flucytosine 복용

花翳白陷

- 洋 : 각막의 궤양(중심성, 변연성, 수지상), 반흔
- 증상 : 초기 사삼, 작열, 열루 등이 빈발하다가 극렬한 전액두통과 胞腫難睜 동반. 聚星障과 비슷한 예막이 발생해 魚鱗狀, 樹枝狀, 花瓣狀 등의 궤양 형성. 진행되면 黃仁, 神水에도 파급 黃液上衝도 발생. 천공은 생기지 않음

黃液上衝

- 이명 : 黃膜上衝
- 洋 : 중등도 각막궤양과 급성 앞포도막염에서의 전방축농
- 증상 : 초기에 포륜부가 홍적, 수명, 유루, 사삼하다가 흑정과 黃仁사이에 황백색 膿液이 발생. 점차 上衝되면 흑정이 황색으로 변하고 眼珠가 파괴됨

黑翳如珠

- 洋 : 대상포진성 각막염, 각막 반흔 및 궤양
- 증상 : 수명, 유루, 두통 및 안통이 심하면서 흑정의 潰陷된 심처에서 흑색의 圓珠狀 小泡 돌기형태의 翳膜이 계속해서 발생. 주위는 회백색을 띠. 凝脂翳가 항상 출현

蟹睛(포도막질환)

- 洋 : 동공연의 결절상 삼출물인 Koeppe 결절, Busacca 결절 또는 홍채탈출
- 이명 : 損翳, 蟹目, 離睛
- 증상 : 凝脂翳, 黃液上衝 등과 흑정 표면에 갈색의 蟹眼, 蠅頭狀 융기 발생, 심하면 黑豆狀. 동공도 靑黃色의 杏仁, 棗核狀으로 변형. 치유 후 두터운 斑脂翳 발생. 오래되면 시력저하 동반, 녹내장 발생 가능

正漏

- 黑睛 가운데 작은 漏口가 있어 유합되지 않고 神水가 부단히 누출
- 증상 : 안통, 유루, 눈부심, 안검 발적. 風輪 편측에 漏口가 있는 경우 검은색 작은 점 형태를 띠며 형광색소 염색시 환부에 黃綠色의 가는 흐름 보임
 - 1) 漏口가 저절로 封閉 : 방수액 증가로 안압 상승하고 수정체 경화되어 脹痛 발생
 - 2) 封閉된 漏口가 다시 궤파 : 동통이 완화되고 수정체가 다시 軟해짐

混睛(混睛障)

- 洋 : 각막실질염 혹은 결핵, 매독, 바이러스성 각막염에 의한 각막혼탁
- 증상 : 삼통, 작열, 유루, 수명과 함께 백정 混赤, 흑정에 입김같은 회백색의 혼탁한 예막이 발생. 오래되면 赤脈이 흑정을 관통하여 凝脂와 같아짐. 輕症, 重症으로 분류
 - 輕症 : 초기에 目赤痛, 眵糞, 流淚 등의 증상과 赤脈이 나타나는 것. 洋(각막염 발생때 생기는 홍채혈관의 충혈확장, 각막부종)
 - 重症 : 오래되어 회백색 혹은 적색의 翳膜이 발생하는 것. 難治. 洋(각막의 혈관신생, 반흔 및 침윤)

매독 사이질각막염

- 각막상피나 내피를 침범하지 않고 각막기질에만 염증이 발생. 5~25세 사이에 급성, 양측성 통증, 심한 시력저하 발생
- 징후
 - 1) 심층 혈관이 각막기질로 들어가는 각막윤부에 염증성 돌출부 발생. 연한 핑크색 반(연어반; salmon-patch) 형성
 - 2) 몇 달이 지나 각막이 깨끗해지고 유령혈관 형성
 - 3) 기질이 얇아지고 반흔이 발생. 종종 각막 편평해지면서 치유
- 치료 : 전신적 페니실린, 국소 스테로이드, 조절마비제 점안

風輪赤豆

- 洋 : 결핵 포도막염
- 증상 : 흑정 중앙부에 玉粒과 같은 회백색 과립이 돌기처럼 융기, 주위 적맥이 감싸 赤豆의 형태(金疳의 重症). 치유후 癍痕 형성, 시력에 영향
- 특징 : 時發時止. 소아나 청소년에서 다발
 - 1) 발작시: 紅赤色을 띠고 乾澀, 疼痛, 流淚
 - 2) 휴지시: 白色을 띠고 증상이 완화

木疳

- 洋 : 포성 각막염
- 체질이 약한 아동이나 청소년에서 발생
- 증상 : 초기에 沙澀疼痛, 羞明流淚, 眼險難睜 등의 증상이 있고 흑정에 한 개 또는 여러 개의 회백색 과립모양 소포가 발생. 단, 적맥이 감싸지는 않음. 병변이 얇으면 반흔을 남기지 않으나 깊으면 반흔으로 시력에 영향. 일반적 예후 양호. 드물게 蟹睛 발생

감별

★ 금감과 목감을 감별하시오. (17)

금감	목감
小泡가 백정 표층에 용기, 주위 홍적, 심하면 화농됨. 반흔은 남지 않음	小泡가 각막 위에 회백색 과립 모양으로 용기. 단, 적맥이 감싸지는 않음. 예후 양호(·신생혈관이 안만들어짐). 드물게 蟹睛 발생

→ 금감 : 백정에 생김 / 목감 : 흑정에 생김

大泡性 角膜炎

- 黑睛 淺層에서 발생하며, 항상 녹내장, 포도막염, 망막 박리 등의 질환에서 기인하여 失明을 유발
- 증상 : 초기에 沙澀疼痛, 羞明, 流淚, 때로 극렬한 통증이 있고 각막 상피상에 단독 또는 몇 개의 파동성이 있는 水泡狀 용기 발생. 수포를 터트리면 찌르는 듯한 통증 가중. 각막 천층에 신생혈관 발생 가능 (變性 角膜血管翳)

暴露赤眼生翳

- 洋 : 노출성 각막염, 토끼눈 각막염
- 원인 : 심한 안구돌출, 안륜근 마비(Bell's palsy), 눈꺼풀겉말림, 결막유착, 순목반사 소실(혼수상태) 등
- 증상 : 각막의 오랜 노출로 건조되어 쉽게 외상, 잠을 잘 때 눈을 완전히 감지 못하여 각막건조가 악화. 가벼운 외상에도 쉽게 궤양으로 진행, 대개 각막의 아래쪽 1/3에 호발. 때로 이차적으로 세균감염 발생

- 치료 : 항생제 눈연고 점안, 안대 차폐, 그 밖에 치료용 콘택트렌즈 연속 착용, 눈꺼풀봉합술 등 시행

宿翳

- 洋 : 각막부종, 혼탁 및 반흔
- 분류
 - 1) 氷瑕翳: 얼음 위에 생긴 흠집. 표층성 각막염의 점상, 수지상 각막혼탁. 肝熱
 - 2) 雲翳: 흐린 날에 생긴 뜸구름. 玉翳浮滿(玉翳遮睛). 표층성 각막염의 각막부종. → 肝熱 + 風熱
 - 3) 厚翳: 자기 같은 백색을 띠고 매끄러우며 두텁고 광채가 남
 - 4) 斑脂翳: 翳膜이 홍채와 粘着되어 瞳神欹側. 백색중에 흑색을 띠거나 가는 赤脈에 얹힘

旋螺突起

- 洋 : 세균성(폐렴구균) 각막궤양
- 이명 : 旋螺突起, 旋螺突出
- 증상 : 초기에 眼脹痛, 沙澀, 前額 및 眉稜骨痛, 流淚 + 청백색에서 흑색으로 黑睛의 多處에 潰陷되면서 하나 또는 여러 개의 旋螺狀의 突起 발생. 홍채, 동인이 변형

旋膿泛起

- 洋 : 원추각막
- 항상 봄에 발생, 대부분 양측성, 여성이 남성보다 다발
- 증상 : 眼 無紅赤疼痛. 각막 중심부가 얇아지고 앞으로 돌출되어 원추형을 형성. 데스메막 파열과 불규칙적인 혈관신생 발생. 급성 각막수종 발생시 방수가 기질 내로 침입하여 심한 각막부종을 유발하므로 시력저하 심함

★ 선라돌기, 선라범기를 감별진단하시오. (17)

★ 선라돌기와 선러범기의 서양의학적 차이를 쓰시오. (09,07)

구분	선라돌기	선러범기
洋	세균성(폐렴구균) 각막궤양	원추각막
증상	각막중심부에 다슬기같은 "나선형"의 궤양이 여러 개 발생. 이로 인해 각막 표면이 울퉁불퉁해짐. 홍채, 동인이 변형	각막 중심부가 얇아지고 돌출되어 원추형 형성. 불규칙적인 신생혈관이 일어남. 급성각막수종 시 심한 각막부종 유발로 시력저하

원추각막

- 사춘기 주변에서 발병. 유전 X.
- 동반질환: 전신(다운, 터너, 마판증후군, 아토피 등), 눈의 동반질환(춘계각결막염, 청색 공막, 망막색소변성 등)
- 형태상 분류
 - ① 유두형 원추: 크기 5mm이하. 중심부 또는 하비측 편위
 - ② 타원형 원추: 5~6mm. 하이측
 - ③ 공모양 원추: 6mm이상.
- 증상: 진행성 근시, 중심부 각막기질 얇아짐, 꼭지돌출, 불규칙 난시. 진행되면 문슨징 후, 급성 수종, 각막반흔 발생
- 치료: 초기 콘택트렌즈로 교정, 심하면 전체층 각막이식 시행

偃月侵睛

★ 양안의 흑정 상부와 백정이 만나는 곳에 얇고 표면에 광택이 있으며 폭이 약 1~2mm 인 고리모양의 회백색 또는 청백색 혼탁이 발생하는데 띠의 중심부쪽 경계는 불확실하나 주변부쪽은 명확하고 각막 가장자리와의 사이에 투명부분이 있고 통증, 시력장애는 없는 질환의 한방질환명과 양방질환명은? (11,12,13)

- 洋: 노년환

- 증상:

- 흑정 상부와 백정이 만나는 곳에 회백색의 초승달 모양 혼탁 발생. 얇고 청백색, 표면에 광택이 있으며 폭이 약 2mm인 고리모양 흰색 혼탁이 보이고 각막 가장자리와의 사이에 투명 부분 있음.
- 통증, 시력장애 없음. 양안에 발생.
- 50세 이하 발생시 고콜레스테롤혈증 동반

★ <노년환>

- 각막기질의 지질침착이 상하부의 각막윤부 주위에서 시작해 1mm두께의 띠를 형성하면서 진행
- 두께: 수직경선 > 수평경선
- 띠의 중심부쪽 경계는 불확실하나 주변부쪽은 명확하고 각막윤부와 투명대로 분리됨

★ 연월침정과 연월내장을 비교하시오. (15)

연월침장	연월내장
상부 각막윤부 주위에서 시작	수정체 상부에서 시작
- 초승달 모양으로 회백색 혼탁 발생	- 초승달 모양으로 상부가 두텁고
- 점차 고리모양의 혼탁으로 진행	하부가얇은형태의 백색 혼탁 발생
- 시력장애 없음	- 점차 백내장으로 진행되어 시력장애 발생

釘翳根深

- 洋 : 각막의 궤양, 반흔 병태로 재발 또는 침윤이 반복 발생하는 각막실질염
- 증상 : 초기에 단안에서 양안으로 수명, 유루, 작열이 생기며 頭額痛, 眼痛이 심하고 흑정에 翳膜이 銀釘子頭와 같은 형태로 潰陷. 瞳神도 梨子狀, 瓜子狀의 변형이 발생

逆順翳

- 洋 : 표층성 각막염에서 사상의 반흔 또는 혈관 신생
 - 증상 : 포륜부 혹은 백정 변연부에서 赤絲가 시작되어 흑정에 침범, 오래되면 血翳 형성
- 1) 順生翳 : 翳膜이 下에서 上으로 퍼진 것. 易治 → 예막이 아래에서 위로 : 치료 잘됨
 - 2) 逆生翳 : 上에서 下로 퍼진 것. 難治 → 예막이 아래에서 위로 : 치료가 어려움

陰陽翳

- 洋 : 각막염에서 홍채모양체의 충혈, 주변성 각막궤양의 윤상 궤양
- 증상 : 흑정에 두 개의 翳膜이 모두 백색을 띠면서 서로 環狀으로 연결. 미세한 赤絲가 동반되면 難治

★ <윤상형 주변성 각막궤양>

- 전신 세균감염에 의한 과민반응 또는 자가면역질환의 합병증
- 각막주위 궤양이 융합하여 전 주위를 둘러쌘

膜入水輪

- 洋 : 각막 반흔
- 증상: 흑정상에 瘡이 발생 후 나았으나 반흔이 남아 翳膜 형성해 빛을 보지 못함. 難治

안이비 4 주차

<써머리 참고사항>

- 검은 글씨 : 강의자료 PPT 내용
- 회색 음영 : PPT 빈칸
- ★노란 음영 : 기출
- 빨간 글씨 : 중요 내용
- 회색 글씨 : 교수님 말씀

<목차>

1. 포도막질환
2. 수정체질환
3. 사시

제 6 장 포도막질환

- 포도막(= 색소막, 혈관막): **홍채, 모양체, 맥락막**으로 구성
- 포도막에는 **혈관이 풍부하고 결합조직이 많아서 염증이 생기기 쉽다.**
- 포도막염(uveitis)은 진행에 따라 인접 조직인 각막, 유리체, 망막, 시신경, 공막 등에 염증을 일으키며, 특히 뒤포도막염은 대부분 망막과 유리체에 염증을 동반
- **흔한 증상:** **시력저하, 날파리증, 통증, 충혈, 눈물 흘림, 눈부심** 등
- 대부분의 포도막염은 내인성 염증으로 **인체의 자가면역반응과 밀접히 관련되며**, 전신 류머티스 질환을 동반하기도 함
- **치료:** 급성 포도막염 발생 시 통증과 함께 **홍채후유착** 등 합병증 방지를 위해 국소 스테로이드제와 함께 조절마비제를 점안(→양방에서 가장 중시하는 것)

<瞳神>

- **이명:** 瞳仁, 瞳子, 金井 / 水輪으로 **腎, 膀胱과 관련**
- 洋: **협위(홍채, 모양체, 맥락막), 광의(망막, 시신경, 시로 포함)**
- **동공:** 유아기에는 동공이 작고, 소아기 청년기 동안 커지며, 다시 나이 들수록 작아짐 (축동 > 2mm > 정상 > 4mm > 산동)
- **병기** ★ **동신 질환의 변증시치, 실증과 허증(08)**
- 1) 實證: 肝風上冲, 肝膽熱盛, 外感風熱, 痰濕, 瘀血, 外傷 "간의 열증과 관련이 많음"
- 2) 虛證: 肝腎陰虛, 氣血不足 "신의 허증과 관련이 많음"

산동(교감)	축동(부교감)
어두울 때	밝을 때
마취 초기(흥분 상태일 때), 중추신경계 병변이 중뇌 파급	수면상태(대뇌, 간뇌의 기능이 활발하지 못해)
녹내장	앞포도막염

★동신 질환의 분류

★ 원인질환이 다른 것은? (07,11)

- ① 瞳人縮小 ② 瞳神乾缺 ③ 瞳人散大 ④ 血灌瞳神
⑤ 瞳神欹側

동 인 축 소 동 신 건 결 동 인 산 대 혈 관 동 신 동 신 의 축

- 동인산대: 급성 원발성 폐쇄각 녹내장에서 안압상승으로 산동과 동공반사가 결여 혹은 부동

★ 동신질환 중 Koeppe결절, Busacca결절, 홍채 탈출을 동반하는 질환의 한의학적 병명은? (09)

1. 黃膜上衝: 중등도 각막궤양과 급성 전포도막염에서 발생하는 전방축농 (누런 막이 위로 올라오는 것)
2. 蟹睛: 동공연의 결절상 삼출물인 Koeppe 결절, Busacca 결절 또는 홍채탈출
3. 瞳人縮小: 급성 전포도막염에서 모양체혈이 진행되어서 발생하는 일종의 축동 (말 그대로 동공이 작아지는 것)
4. 瞳神乾缺: 홍채의 위축, 홍채후유착, 홍채모양체염 *결 = 뭔가 부족하다, 빠졌다.
5. 血灌瞳神: 각막주위 또는 모양체의 혈관확장으로 증상이 심한 방사상 모양의 모양체출혈
6. 瞳神欹側(동신기측): 홍채후유착으로 동공이 변형된 증상, 동공의 구조이상 (동신건결과 비슷, 동신기측은 구조적 이상까지 다루는 개념)

黃膜上衝

황 막 상 충

- 洋: 중등도 각막궤양과 급성 앞포도막염에서의 전방축농
- 증상: 초기에 포륜부가 홍적, 수명, 유루, 사삽하다가 흑정과 黃仁 사이에 황백색 膿液이 발생. 점차 上衝되면 흑정이 황색으로 변하고 眼珠가 파괴됨

蟹睛

해 정

- 洋: 동공연의 결절상 삼출물인 Koeppe 결절, Busacca 결절 또는 홍채탈출
- 이명: 損翳, 蟹目, 離睛
- 증상: 凝脂翳, 黃液上衝 등과 흑정 표면에 갈색의 蟹眼, 蠅頭狀 용기 발생, 심하면 黑豆狀. 동공도 靑黃色의 杏仁, 棗核狀으로 변형. 치유 후 두터운 斑脂翳 발생. 오래되면 시력저하 동반, 녹내장 발생 가능

瞳人縮小

동 인 축 소

- 이명: 瞳神緊小, 瞳人鎖緊, 肝決
- 洋: 급성 앞포도막염에서 모양체 출혈 진행되어 축동 형태
- 증상
 - 1) 급성: 안통사삽, 미륵골통, 유루, 수명, 포륜부가 홍적, 혼탁. 심하면 高腫突起 발생
 - 2) 만성: 黃液上衝, 蟹睛 등으로 전변. 視物昏朦, 瞳神乾缺 발생
- 변증론치
 - 1) 肝膽熱盛: 사간탕, 사청환 *실증(간열, 간담습열 위주)
 - 2) 甚(심해지면): 황련해독탕 합 오미소독음
 - 3) 虛火上炎: 환음구고탕 *허증(허화상염 위주)

★《暴風客熱과 瞳神緊小의 鑑別》(18)

	暴風客熱 폭풍객열	瞳神緊小 동신긴소
痛症 통증	異物感, 沙澁感 이물감 사삽감	眼球墜痛, 眉骨顫顫 放散痛 안구주통 미골삽전 방산통
眼眇 안치	多, 膠粘 눈곱 많음 다 교 전	無 눈곱과 무관 무
紅赤 홍적	白睛淺層 紅赤 백정전층 홍적 검은자에서 멀수록(특히 결막 주변부)	抱輪 紅赤 혹은 白睛 混赤 포륜 홍적 백정 혼적 검은자에 가까울수록(특히 각막윤부)
瞳神 동신	正常 정상	縮小 축소
視力 시력	正常 정상	下降 시력 저하 하강
傳染性 전염성	有 유	無 무

瞳神乾缺

동 신 건 결

- 洋: 홍채의 위축, 홍채후유착, 홍채모양체염
- 증상: 눈에 은은통, 또는 眼痛이 지속되며 乾澁 不明하고 眼前에 黑花가 보임. 瞳神이 원형이 아닌 梅花狀, 鋸齒狀의 乾缺이 발생. 홍채도 土黃色으로 변하면서 오래되면 시물혼몽, 실명 발생

血灌瞳神

혈관동신

- 洋: 각막주위 또는 모양체의 혈관확장으로 증상이 심한 방사상 모양의 모양체충혈 (초기증상)
- 증상: 흑점과 황인사이에 혈액 섞인 액체가 하방에 수평면으로 발생. 심하면 안통, 사삼과 선홍색의 片狀 翳膜이 발생
- 변증론치
 - 1) 肝膽熱盛: 용담사간탕, 서각지황탕
 - 2) 外傷(혈액이 고여있는 건 외상도 고려): 대황당귀산
 - 3) 虛火上炎: 자음강화탕가감

瞳神欹側(기측)

동신의측

- 이명: 瞳神偏斜, 瞳神不正, 瞳欹
- 洋: 홍채후유착으로 동공이 변형된 증상, 동공의 구조이상
- 증상: 瞳神이 不正, 不圓하여 視物昏朦이 발생

포도막염

1. 해부학적 분류(빈발순)

- 1) 전포도막염: 홍채염, 홍채모양체염으로 세분 (제일 흔함!)
- 2) 중간포도막염: 모양체 평면부, 망막의 극도 말초부 및 밑의 맥락막 포함
- 3) 후포도막염: 맥락막과 유리체 기저부 뒤쪽 망막 염증 포함
- 4) 전체포도막염: 전 포도막을 포함하는 염증

2. 임상적 분류

- 1) 급성 포도막염: 급격히 시작, 3개월까지 지속
 - 2) 만성 포도막염: 3개월 이상 지속. 대개 잠행성으로 시작, 무증상
- 피부쪽은 급성과 만성에 기준점이 6주!

3. 원인에 의한 분류

- 1) 외인성: 감염, 외상 등으로 유발. 급성 앞포도막염 양상
- 2) 내인성: 원인불명의 전신질환, 특히 면역장애질환, 결합조직의 이상 등에서 발생. 만성 후포도막염 양상

포도막질환의 분류: 전포도막염, 후포도막염, 교감성 안염, 베체트 증후군, 화농성 포도막염

1. 전포도막염(홍채모양체염)

증상	급성: 수명, 통증, 충혈, 시력저하, 유루증 등이 특징 *羞明=眼力이 부족해서 밝은 빛을 잘 보지 못하는 병 만성: 무증상, 혹은 경한 충혈, 비문증을 느끼는 정도 *비문증=원가 떠다님
징후	① 급성에서 각막주위 충혈(모양체충혈): 보랏빛 색조 ② 각막침전물: 각막내피의 세포 침착. 전방 내 대류 때문에 주로 각막의 중간과 아래쪽에 형성 1) 내피 살포(가장 가벼운 경우, 초기 증상): 급성뿐만 아니라 만성 염증의 급성악화도 발생 2) 중간 각막침전물: 급성, 만성 3) 큰 각막침전물: 주로 육아종성 포도막염에 발생. 굳기름, 납빛 모양 변화 (내피세포들이 더 많이 침착되면 굳기름 생) 4) 오래된 각막침전물: 색소, 젓빛 유리 모양 변화 ③ 세포 : 활동성 염증. 전방축농 ④ 방수흐림: 손상된 홍채혈관에서 방수로 유출된 단백질에 의한 빛의 산란 ⑤ 홍채 결절: 육아종성 염증특징 1) 궤폐결절: 작고 동공 가장자리에 위치 2) 부사카결절: 흔하지 않음. 동공에 떨어져 위치
합병증	★ 앞포도막염의 3가지 합병증을 기술하시오. (12) 답: 홍채후유착, 백내장, 녹내장 1. 홍채후유착: 홍채와 수정체전낭사이의 부착. 급성이나 중등도에서 고도 만성 전포도막염에서 형성 2. 만성 혹은 재발성 전포도막염의 다른 합병증: 백내장, 녹내장, 황반부종, 락모양 각막병증 등 교수님曰: 홍채후유착, 백내장, 녹내장 정도는 알아두셔야 합니다. (설명은 악마 파일에 정리함)

- 변증론치:

肝經風熱(新制柴連湯加減), 肝膽濕熱(龍膽瀉肝湯加減), 風熱夾濕(抑陽酒連散加減),
간 경 풍 열 신 제 시련탕 가 감 간 담 습 열 용담 사 간 탕 가 감 풍 열 협 습 역 양 주련산 가 감
 陰虛火旺(知柏地黃湯加減), 脾腎陽虛(附子理中湯加減)
음 허 화 왕 지 백 지 황 탕 가 감 비 신 양 허 부 자 리 중 탕 가 감

*실증: 간 관련(간경풍열, 간담습열) / 급성이 많기 때문에 간열 관련해서 많이 씀!(특히 간담습열)

*허증: 간신음허, 음허화왕 등(비신양허쪽은 쓸 일 별로 없음)

- 때에 따라 동공확장제를 사용하여 瞳神乾缺 등 병의 발생을 예방
동 신 건 결

2. 중간포도막염 중요도 ↓

증상	초기 비문증 같은 증상이 있고, 나중에 낭포황반부종으로 중심시력 손실 발생
징후	유리체염. 백색 삼출물, 후안저에 국소 염증병변 부재
합병증	낭포황반부종, 백내장, 견인망막박리 등

3. 후포도막염(맥락막염)

증상	비문증, 시력 손상(주증상 2개). 중심와를 포함하는 급성 맥락막염은 중심시력 손상을 유발
징후	① 유리체 징후: 혼탁, 후유리체 박리등 ② 맥락막염: 노란색 혹은 초록색 반점이 특징 (아직 망막까지는 침범하지 않음) ③ 망막염: 망막혈관 폐쇄와 함께 흰색의 흐린 망막이 발생. 망막 부위가 침범되면 중풍처럼 혈관이 막히게 되어 흰색을 띠게 된다. 노란빛 계열을 띠면 맥락막염 / 좀 더 흰색을 띠면 망막염!! ④ 혈관염: 망막정맥에 호발. 활동성 정맥주위염은 혈관을 둘러싼 애매한 흰색 흐림이 특징
합병증	염증 황반부 침범, 황반허혈, 부종, 혈관폐쇄, 망막박리, 시신경염 등 발생 ==> 황반부 침범으로 황반허혈, 부종이 발생해 시력에 많은 영향을 미침

- 특징: 후부에 국한된 육아성 병변이 주로 발생. 미만성이고 눈의 통증이 별로 없음

- 청장년층에 다발. 환자의 70%에서 양안에 발병

- 수종 水腫, 滲출이 기본 병리

- 검사:

- 전방각경 검사상 房角에 끈적한 황색의 삼출물 침착. 유리체는 흐려지고 앞의 1/3이나 기저부 에작은 티끌상 혼탁.
방 각
- 三面鏡으로 鋸齒緣을 볼 수 있고 모양체 편평부와 각막주변 회황색 작은 구형의 삼출물.
오 면 경 거 치 연

- 변증론치:

肝膽火盛(龍膽瀉肝湯), 肝氣鬱結(逍遙散加味), 濕熱內蘊(三仁湯加減),
간 담 화 성 용담 사 간 탕 간 기 울 결 소 요 산 가 미 습 열 내 운 삼 인 탕 가 감
 痰瘀互結(活血散結湯), 虛火上炎(知柏地黃湯)
담 어 호 결 활 혈 산 결 탕 허 화 상 염 지 백 지 황 탕

<포도막염의 치료> _ 합병증 예방이 가장 중요!

주목적: 합병증 예방, 불편함 해소, 기저질환 치료

사용 약제: 산동제, 스테로이드, 전신 면역억제제.

감염의 경우 적절한 항생제나 항바이러스제 사용

(산동제와 스테로이드 2개를 많이 사용하고, 필요에 따라 항생제 or 항바이러스제 사용)

4. 교감성 안염

★ 45세 남자환자로 6주 전 건설현장에서 철사에 우측 눈이 찢려 인근병원에서 수술 후 지내다가 어제부터 갑자기 우측 눈에 비문증, 변형 시 암점 등이 발생하고 좌측에도 혼탁, 시력저하가 발생 하여 내원하였다. 의심되는 병명은? (12,13,15,17)

- 한쪽 눈에 천공 외상이나 눈속 수술을 받은 후 수일에서 수년 후 비외상안이나 외상안에 나타나는 육아종 포도막염 (양안에 나타남!)
- 모양체의 손상이 심한 외상, 외상을 입은 후 4~8주가 특히 위험
- 증상
 - ① 외상안(主交感眼): 전구증상(수명, 시력장애), 자각증상(비문증, 변형시, 암점, 조절장애 등)
 - ② 비외상안(被交感眼): 전안부염증, 유리체 혼탁, 유두출혈과 부종, 후극부에 국한된 장액망막 박리 (강조하신 포인트 = 기출에 나온 개념)
- 안과수술 후 후유증 가장 심함
- 치료: 스테로이드제 전신 투여, 결막하 주사, 테논낭내 주사, 점안. 홍채후유착 방지 위해 동공산동제 점안. 재발이 잦을 경우 면역억제제 사용. 효과 없을 때 외상안 적출 고려

- 변증론치:

肝膽火盛(龍膽瀉肝湯), 毒邪壅遏(加減化斑湯), 氣陰兩虛(三才湯加味),
간 담 화 성 용담 사 간 탕 독 사 용遏 가 감 화 반 탕 기 음 양 허 삼 재 탕 가 미
 '肝腎陰虛, 虛火上炎'(知柏地黃湯)
간 신 음 허 허 화 상 염 지 백 지 황 탕

*증상 상 요런 약들을 쓸 수 있을 정도로만 알고..교감성 안염은 적출까지 고려해야 하는 심각한 상태이므로 스테로이드 등 강한 약을 사용해야 한다! 응급질환이라 양방으로 보내는 것이 현명함!!

5. 베체트 증후군

- 눈증상은 종종 양측성, **청장년층, 25~35세 사이**, 여성보다 남성에서 **다발. 실명을 높음.**
HLA-B51(일종의 혈액검사?)과 관련

- 증상
- ① **눈: 급성 재발성 앞포도막염, 유동성 전방축농**, 흰색의 표층 침윤물이 특징인 망막염, 혈관 폐쇄와 황반허혈의 망막혈관염, 시신경유두부종 발생
- ② **피부: 결절성 홍반, 혈전정맥염, 심한 여드름**
- ③ **점막: 구강궤양, 외음부궤양**
- ④ **기타: 관절염, 장궤양, 부고환염, 혈관질환(동맥류)**

- 중동과 극동아시아에 많으며, 우리나라에서도 전체포도막염 중 발생빈도가 가장 높은 포도막염

- 검사: 안저 출혈, 형광안저 혈관조영술에서 혈관염과 모세혈관폐쇄 등이 관찰

- 진단: **Pathergy test**(Needle prick test; 자침 후 24~48시간 내에 **홍반** 또는 **농포** 발생)
교수님 **ㄷ *반드시 기억하기!!**

* 알레르기가 있는 사람한테 침을 놓으면 약간 빨개지는데, 홍반과 감별해야 함! 그래서 홍반 약간 애매..

- 치료: 스테로이드제와 면역억제제 병용

▶ 감별진단

- ① **Stevens-Johnson 증후군: (다형홍반의 중증형이라고 생각!) 급성, 중증형.** 전신무력, 頭痛, 畏寒發熱, 高熱 등을 동반. 피부에 수포, 滲出性紅斑 발생, 심하면 전신에 퍼짐.

두통 외한발열고열 삼출성홍반
치유 후 결막유착, 눈물소실, 심하면 안구천공 등 후유증 및 사망 *비교적 예후가 불량.
- ② **Reiter syndrome:** 여러 관절의 急性 疼痛, 壓痛, 腫脹, 활동제한, 피부 다발성 紅斑 + 眼部증상(결막염, 점액화농성). 비임균성 요도염으로 인해 排尿시 작열감, 빈뇨, 尿色 혼탁.
안부 배뇨뇨색
- ③ **폭스 포도막염 증후군(Fuchs uveitis syndrome):** 얼굴의 紫紺색 腫脹 발생, 暴風客熱 重症을 뒀. 병정이 짧고, 항상 1개월 정도 이내 모두 회복. 재발 적음
자갑홍창폭풍객열중증

6. 화농성 포도막염

- 사물에 의한 안구 손상이나 화농성골수염, 폐렴, 산욕열, 농포창, 봉와직염 등으로 화농되어 발생. 병세가 위험하고 발병이 신속함

- 증상:
 - 초기에 눈주위 沈重感, 刺痛이 頭面頸部로 확산
 - 羞明, 流淚가 **침하증** **침** **자하증** **두면경부**가 있으면서 시력이 신속히 저하되어 심하면 겨우 손의 움직임이나 빛의 감각만을 인지.
 - 眼瞼紅腫, 각막 혼탁, 전방축농 동반.
안검홍창
 - 진행되면 극렬한 眼痛, 發熱, 煩躁, 失明
안통 발열 반조 실명
- 치료 : **안과질환의 응급질환.** 瀉火解毒, 消膿散滯.
사 화 해 독 소 농 산 제

- +cf) 보그트-고야나기-하라다 증후군(葡萄膜 大腦炎)
포도막 대뇌염
(굳이 외울 건 아니고 이런 특이한 질환도 있다는 거 가볍게 살피고 넘어가기)
- 특발성, 양측성, 육아종성 전체포도막염
 - 처음 두통, 구토, 경항강직, 혼수 등 **뇌막자극증상 발생.** 점차 포도막염 증상(**視力, 聽力 低下**). 후기에 白毛, 脫毛, 皮膚 白斑 등의 순서로 발생
하 백모탈모피부백반
 - ① 보그트-고야나기 증후군: **피부증상**(백모, 탈모, 피부백반)과 **앞포도막염**이 주요특징
 - ② 하라다병: **중추신경계 증상, 삼출망막박리**가 주요 특징
 - 후유증 : 홍채후유착으로 인한 녹내장, 백내장, 맥락막 혈관신생 등이 합병

제8장

수정체질환

- 안구의 외부에는 별다른 증상이 없이 동신내의 黃精이 혼탁해져 翳膜이 나타나 물체가 구름이 낀 것처럼 보이고 점차 昏朦해지는 것

- 수정체질환의 종류

① 圓翳內障: 백내장 ② 驚振內障: 외상성 백내장 ③ 胎患內障: 선천성 백내장

① 백내장

- 병리: 수정체 단백질의 변성으로 가용성 단백질이 감소되고 불용성 단백질(알부노이드)이 증가되며 수분, 칼륨, 아스코르빈산 등의 함량이 줄어 혼탁 (수정체 내 수분량 ↑ or 나이 들어 경화)
- 분류: 선천성, 후천성(노년성, 외상성, 합병, 후발, 당뇨, 중독 백내장)으로 분류

1. 후천성 백내장 기출 多

★ 수정체 핵의 경화로 수정체 굴절률이 증가하여 수정체 근시를 유발하는 것은 () 백내장이고, 차의 전조등이나 밝은 전조등 하에서 더 시력장애를 호소하는 것은 () 백내장으로 주맹증에 해당되며 ()에 속한다. 답: 핵, 후낭하, 후천성

- 원인: 노화, 외상, 전신질환, 안질환 및 독소 등으로 발생
- 증상:

- ① 시력감퇴 - 혼탁이 동공 부위 또는 후극부에 있으면 밝은 곳에서 축동이 일어나 주맹 발생
- ② 단안복시 - 부분적 혼탁. 굴절상태가 각 부분마다 다르거나 혼탁이 시축을 방해해 발생
- ③ 수정체근시 - 수정체핵의 경화로 수정체 굴절률이 증가. 일시적 현상(노년기의 제2의 시력)

→ 이후에 시력저하

<圓翳內障>

- 동신 내의 黃精(수정체)에 원형의 銀白色, 심하면 棕褐色의 혼탁이 점차적으로 생겨서 昏朦이 되는 질병

- 洋: 백내장

- 분류(수정체 혼탁 정도에 따라)

① 초기 및 미숙백내장: 偃月翳, 仰月翳

② 성숙백내장: 圓翳內障, 如銀內障, 滑翳, 滲翳, 浮翳, 黃心翳 (원예내장은 성숙백내장에 해당)

③ 합병성 백내장: 如金內障(여금내장), 銀風內障, 金花內障(금화내장) *금=누런색

- 증상: 초기에는 안통, 수명, 유루 등이 없이 視物昏朦, 眼前昏花가 경미하게 나타나고 점차 동신의 내측에 여러 형태의 內障 翳膜이 일어나며 혼탁이 진행되어서 視物昏朦이 발생

형태학적 분류

① 전후낭하 백내장

- 전낭하 백내장: 수정체 전상피의 섬유성 화생과 관련됨
- 후낭하 백내장: 극부에 작은 소포형, 과립형 또는 얇은 판상형 혼탁 발생. 핵 백내장이나 피질백내장보다 시력에 더 큰 영향. 차의 전조등이나 밝은 태양 광선에서 더 시력장애 호소(주맹: 낮에 더 잘 안 보임). 근거리 시력에 더 많은 불편을 호소

② 핵백내장(노인성)

- 수정체 핵의 정상적인 노화현상인 핵경화가 심해져 시작.
- 종종 감소된 근시 때문에 안경 없이도 다시 읽을 수 있게 됨. 시력이 점점 떨어지다가 순간순간 좋아질 수 있는데, 오래가지는 않음
- 핵의 경화는 초기(노란색), 진행(갈색)을 띰. 원시, 근시 모두 소실.

③ 피질백내장

- 수정체 피질에서 수정체 섬유들 사이의 갈라진 틈새나 소포로부터 시작.
- 전형적인 쐐기모양 또는 방사상의 차바퀴살 모양의 형태
- 흔히 하비측에서 시작

① 초기 백내장(초발기): 수정체 주변에서 중심부로 향한 쐐기모양 백내장. 동공부는 투명하고 산동시키지 않으면 발견되지 않음

② 미숙 백내장(팽창기): 쐐기모양 혼탁 중심부로 진행. 수정체 용적 커지고 시력 점차 감퇴. 때로 다시증(여러 개로 보임)

★ 백내장의 성숙도에 따른 분류에서 쐐기모양 혼탁이 중심부로 진행되어 수정체 용적이 커지고 시력이 점차 가퇴되어 다시증이 나타나는 질환은? (09,11,12)

③ 성숙 백내장(성숙기): 피질 모두 혼탁하여 육안으로도 희게 보임. 시력 극히 불량. 수정체 정상용적으로 복귀

④ 과숙 백내장(과숙기): 피질이 액화되어 죽과 같고 결정 성분도 관찰. 액화된 피질 속에 갈색의 수정체핵이 가라앉은 모르가니 백내장 발생

★ 백내장의 성숙도에 따른 분류에서 피질이 액화되어 죽과 같고, 결정성분이 관찰되며 때로 액화된 피질속에 갈색의 수정체 핵이 가라앉는 것도 보이는 경우의 백내장은? (08,10,13)

성숙도에 따른 분류

원인에 따른 분류

① 노년성 백내장

- 대개 50세 이후에 발생. 40대(초로 백내장), 40세 미만(연소백내장)으로 구분
* 40세 이하에서부터도 노년성 백내장이 생길 수 있음.
- 혼탁이 수정체 피질보다는 핵이 혼탁해지는 핵백내장 형태
- 자외선 조사량 햇볕에 노출됨 => 야외에서 일을 많이 함, 당뇨, 고혈압, 관절염, 흡연, 안구좌상, 여성의 분만횟수와 많은 관련

② 당뇨병성 백내장

- 양측성, 전후낭하에 공포가 발생. 점차 특징적인 눈보라 치는 양상의 피질 백내장으로 나타남. 성숙되는 과정이 매우 빠름

③ 합병성 백내장 -> 노란빛이 특징적

- 심한 안질환 후에 초래되는 백내장. 만성인 각막염, 홍채모양체염, 녹내장, 망막박리, 유리체 변성 및 출혈 등에 합병
- 혼탁은 후낭하 피질부터 시작
- 기존 염증으로 예후 나쁨

④ 후발성 백내장 = 수술

- 수정체 낭외적출술, 외상백내장의 수정체물질 흡수 후 발생

⑤ 중독성 백내장

- 스테로이드, Chlorpromazine, 축동제, 금 등을 오래 사용해 발생

2. 선천성 백내장

- 출생아 1만 명당 3명꼴로 발생. 이중 2/3는 양안성
- 원인: 대부분 원인불명. 상염색체 우성 유전(다운증후군), 임신 중 풍진, 매독, 수두 등의 태내감염, 대사성 질환(갈락토스혈증) 등
- 증상: 대부분 정지성. 수정체핵에 여러 형태(관상, 막성, 푸른 점 혼탁, 미세가루 등)로 다발
- 유아는 황반기능이 덜 발달된 상태 → 백내장으로 중심와 기능이 악화 → 약시, 시력저하, 주시 안진

<胎患內障>

- 개요: 선천적으로 동시 내에 백색의 혼탁이 발생하는 질병
- 洋: 선천성 백내장
- 증상: 양안의 안구에 동일하지 않은 乳白色, 粉青色의 混濁이 여러가지 형태를 보이고 점차 진행
- 변증론치

脾胃虛弱(參苓白朮散), 腎陰不足(杞菊地黃丸)
비 위 허약 삼 령 백출산 신 음 불 족 기 국 지 황 환

3. 외상성 백내장

★ 눈의 좌상 후 수개월이 지나 후낭 아래 혼탁이 생기고 꽃 모양의 피질 혼탁이 발생하고, 흑갈색 고리모양의 홍채 색소가 수정체 전방 표면에 발생하는 vossius환이 나타났다. 알맞은 한방 질환명과 양방질환명은? (08,10,14,15)

- 젊은 연령에서 발생하는 편측성 백내장의 가장 흔한 원인
- 원인: 외상으로 수정체를 직접 관통하거나 타박으로 수정체가 혼탁이 오는 경우
- 증상: 눈의 좌상 후 眼痛, 羞明, 流淚, 시력 저하 등의 증상이 있다가 수개월 지나 후낭 아래 혼탁이 발생. 흑갈색 동그란 고리 모양의 홍채 색소가 수정체 전방 표면에 발생 (Vossius 환), 꽃 모양의 피질 혼탁을 유발

★ <驚振內障> *눈을 찔리면 놀라므로 쓰는 표현

- 개요: 눈이나 두부에 타박 혹은 刺傷을 받은 후 점차 안구가 은백색으로 변하고 혼탁이 나타나는 질병
- 洋: 외상성 백내장
- 증상: 초기에는 포륵부가 홍적, 사삼동통, 유루하고 흑정에 반흔, 혹은 血灌瞳神도 발생. 점차 안구 전부가 혼탁해져 백색을 띠게 됨
- 변증론치:

外傷으로 氣滯血瘀(除風益損湯加減), 風毒夾瘀(分珠散加減)
외 상 기 제 혈 어 제 풍 익 손 탕 가 감 풍 독 염 어 분 주 산 가 감

4. 노안

- 연령 증가에 따라 모양체근의 수축력과 수정체의 탄력성이 감소되어 45세 전후에서 근거리 작업(30cm 이내)이 장애를 받는 4D 이하의 원시 상태
- 증상: 40~50세가 되어서 멀리 있는 것은 잘 보이나 가까이 있는 것은 잘 보이지 않고 眼昏, 眼花가 발생. 衝風淚出, 眼脹感, 頭痛, 眉骨痠重 등도 발생
- 원인: 모양체 조절력 감퇴로 인한 근거리 시각장애, 황반변성으로 생기는 중심암점, 허혈성 시신경증 등에서 발생
- 증상: 양안 시력저하가 주증상. 연령 증가에 따라 수정체의 탄력성이 감퇴되어 수정체 변형이 어려워지고 조절력이 감퇴되어 근거리 작업 불가능해짐. 원시에서 노안현상을 빨리 느끼게 되며, 특히 조명이 어두우면 증상이 더 심해짐
- 치료: 최소한 볼록렌즈로 교정. 조절력의 1/3은 예비로 남김
- 변증론치

老衰 腎精虧損 陰精不足(명목지황환, 기국지황환, 환정산)

노 쇠 신 정 유 손 음 정 부 족

제13장

사시

1. 용어정리 및 사시의 정의

- ❶ 사시: 안구의 비정상 배열
- ❷ 사위: 안구편위가 있지만 융합에 의해 정위가 유지되는 것
- ❸ 시축: 중심와에서부터 눈의 교점을 통해 주시점을 지나는 선. 중심와는 보통 후극부 약간 이측에 위치하므로 시축이 각막을 통과하는 지점은 각막중심에서 약간 비측이 됨
- ❹ 해부학적 축: 각막 중심부와 후극부를 연결하는 선
- ❺ 카파각: 해부학적 축과 시축이 절점에서 만나서 이루는 각. 보통 5도

2. 안구운동 및 6개의 주요 주시방향

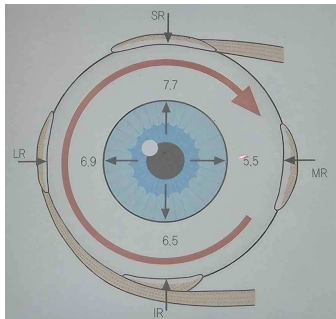
1) 외안근 및 신경 지배

❶ 외안근 (6개 외안근)

수평직근 : 내직근(내전) 외직근(외전)
 수직직근 : 상직근(상전/내전, 내회선) 하직근(하전/내전, 외회선)
 사근 : 상사근(내회선/하전, 외전) 하사근(외회선/상전, 외전)

❷ 신경 지배

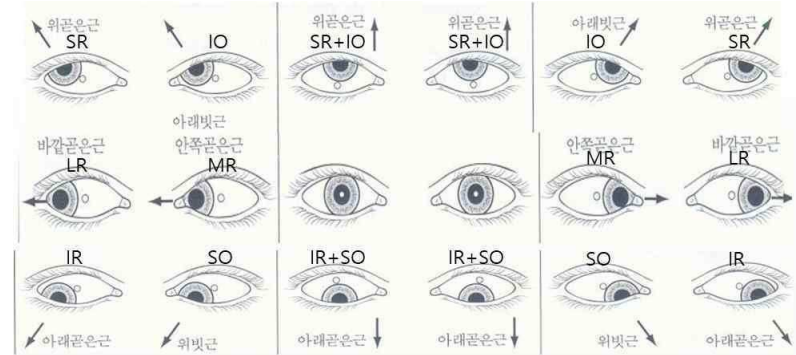
- 외직근: 외전신경
- 상사근: 활차신경
- 이외 외안근, 상안검거근: 동안신경



※ 티로우나선

- 네 직근의 부착부위(정지부)가 만나는 가상의 선.
- 수술을 시행할 때 중요한 해부학적 경계부
- (사진상) 숫자: 각막윤부(눈의 각막과 공막의 연결부)에서 각각의 직근들의 거리를 의미 /
- 상직근이 제일 멀고 내직근이 제일 가깝다.

2) 6개의 주요 주시방향 근육배속



- 외측상방: 상직근 • 내측상방: 하사근(미간쪽으로) • 내측: 내직근
- 외측하방: 하직근 • 내측하방: 상사근(코쪽으로) • 외측: 외직근
- 수직으로 위를 볼 때(12시 방향): 상직근(SR), 하사근(IO)
- 수직으로 아래를 볼 때(6시 방향): 하직근(IR), 상사근(SO)

3) 안구운동

- ❶ 동향운동(동명성 운동): 두 눈이 동시에 같은 방향으로 움직이는 것.
- * (왼쪽을 볼 때) 우안의 움직임이 작음하면 좌안의 외직근이 작용한다.

★ 양안의 안구운동 중 이항운동에 해당되는 것 두 가지를 쓰시오. (08)

- ❷ ★이항운동(이명성 운동): 두 눈이 동시에 반대방향으로 움직이는 것.

- 눈모음(폭주): 두 눈을 안쪽으로 모으는 것
- 눈벌림(개산): 두 눈을 밖으로 벌어지게 하는 것

양안시

- ❶ 융합: 물체가 선명하도록 망막의 대응점인 양안의 중심와에 결상하도록 하는 기능
- ❷ 주시: 시선을 물체 쪽으로 돌려 물체를 가장 선명하게 볼 수 있도록 하는 기능
- ❸ 양안 단일시: 양쪽 중심와 주시를 통해 동시에 양안을 사용하는 능력. 그 결과 공통의 동일한 인식력을 가짐.
- ❹ 시방향: 망막이 그 부위를 자극하는 외계물체의 방향을 판단하는 능력
- ❺ 대응점: 각 망막이 같은 시방향을 갖는 부위. 한쪽 눈의 비측 망막 부위는 다른 눈에서 측두 망막에 대응점을 가짐
- ❻ 생리적 복시: 한 물체를 주시하고 있을 때, 주시점보다 근거리 물체는 교차 복시, 원거리 물체는 동측 복시를 일으킴 *iphone '인물 사진'의 원리!! 근거리의 인물: 또렷하게 보임!
- ❼ 입체시: 깊이에 따른 시각 물체의 상대적인 순서. 수평으로 이중의 망막 영역을 동시에 자극했을 때 발생. 눈이 물체의 약간의 다른 면을 보기 때문에 물체는 입체적으로 보임.

3. 사시의 증상

- ❶ **복시**: 물체가 여러 개로 보임 / 증상을 없애려면 한쪽 눈을 가리는 게 좋다. 그러나 아픈 눈만 계속 가리게 되면 약시가 발생할 수 있으므로 가급적 양안 교대로 가리는 것을 권장!
- ❷ **억제**: 사시에서 복시를 없애기 위해 편위된 눈의 중심와에 맺혀진 상을 의식하지 못하게 함
- ❸ **약시**: 편위된 눈에 지속적인 억제작용으로 시력이 감퇴됨.
- ❹ **이상망막대응**: 사시에서 정상안의 중심와가 편위된 눈의 중심와가 아닌 **비중심와 영역과 짝을 이루어 공통의 주관적인 시방향을 얻는 것**. 추후 융합장애, 사시약시를 초래

*사시의 눈에 적응이 된 것. '사시안에서 중심와 이외에 망막영역에 상이 맺히게 해 그 부분을 뇌가 인식'

- ❺ **중심와 주시**: **사시가 오래되어** 사시안 단독으로 물체를 주시해도 **중심와 이외 망막에 주시** (이상망막대응과 유사)

4. 사시의 검사

- 1) **히르쉬버그 검사(Hirschberg test)**: 각막반사법_각도를 평가하는 것
- 방법: 빛을 30cm정도 거리에서 비추고 환자가 주시할 때 빛의 각막반사점이 **동공 중심**에 있으면 정상. ★ 동공연이면 15°, 동공연과 각막윤부 중간이면 30°, 각막윤부면 45° 편위

- 2) **카파각 측정**: 광선을 주시시 각막반사가 동공중심(안축과 시축이 일치)이면 Kappa각 없음
- **양성 Kappa각**: 동공 내측에 각막반사가 일어남. 이 각이 크면 **외사시 유사**(동공이 외측으로 치우쳤다는 것이므로 외사시)
- **음성 Kappa각**: 동공 외측에 각막반사가 일어남. 이 각이 크면 내사시 유사. 내사시가 되면 동공의 외측에 광선이 보임

3) 가림검사(차폐법)

- ❶ **단안 차폐법**: 양안으로 주시시키고 **좌안을 차폐**하며 **우안의 운동을 관찰** / (반대로) **우안을 차폐**하며 **좌안의 운동을 관찰** / 만일 좌안 차폐 시 우안이 주시하려 외측으로 움직이면 내사시
- ❷ **교대 차폐법**: 양안으로 광점을 주시 후 **우안을 가렸다가 즉시 좌안을 가리면서** → 가렸던 **우안**의 움직임을 관찰 / (반대로) 다시 또 **우안을 가려 좌안의 움직임을 관찰** / 움직이지 않으면 **정시**, 움직이면 **좌위 또는 좌시**
- ❸ **프리즘 차폐법** **마비성 사시**보다는 **비마비성 사시**에서 활용됨
- 교대가림검사를 먼저 시행

- 프리즘의 기저부를 편위된 부위의 반대편 방향으로 향하게 함. 내사시의 경우 기저부를 밖으로 함
- 교대가림검사를 다시 시행
- 위를 반복하여 안구의 움직임이 없을 때의 프리즘 수치를 읽음. 정확한 편위각을 측정할 수 있음

★ 15세 남자환자가 외사시로 내원하였다. 히르쉬버그 검사상 반사불빛이 각막반사점이 동공연과 각막윤부의 중간에 위치하였다. 편위도는 몇 도인가? (10,14,15) 답: 30도

★ 히르쉬버그 검사 빛의 반사점이 동공연과 각막윤부 중간이면 ()도 (08) 답: 30도

★ 히르쉬버그 검사법은 각막반사법으로 환자의 30cm 앞에서 불빛을 비추어 환자가 주시할 때의 빛의 각막반사점이 있는 위치를 가지고 편위를 알아보는 방법으로 만일 각막 반사점이 동공연에 위치할 경우 ()의 편위를 보인다. 답: 15도

5. 사시의 치료 - 소아의 시력과 융합기능이 완성되는 시기가 보통 8세 ★

1) 사시의 치료 목적

- 양안 시력을 증진
- 안구의 위치를 정상으로 하여 외관상 모양을 좋게 함
- 양안의 단일시, 즉 입체시를 얻게 함

2) 사시의 치료 방법

비수술	수술
⌚ 안경 착용 - 난시: 전교정 - 내사시: 원시(전교정: 완전 교정), 근시(불완전하게 교정) - 외사시: 근시(전교정), 원시(시력장애가 없을 정도로 부족하게 교정 혹은 교정 안 함) ② 약물요법 - 축동제 장기점안: 안경 착용이 어려운 2~4세 이하 조절성 내사시 중 4D 이하의 원시 - 보툴리눔 독소 주사: 일시적 외안근 마비시켜 효과	- 안근을 단축시켜 근의 견인력을 강하게 하는 방법 - 안근을 연장시켜 근의 견인력을 약하게 하는 방법

6. 사시의 종류

1) 종류

- ❶ **사시(현성 사시)**
- 마비성 사시: 주로 **신경장애**로 인한 외안근의 마비로 발생. 편위도가 주시 방향에 따라 달라짐 **비공동성 사시**라고도 함

- 비마비성 사시: **단안의 안구운동에 이상이 없고**, 편위도가 주시방향에 관계없이 항상 일정하여 **공동성 사시**라고도 함
- ❷ **사위(잠복 사시)**: 양안시는 가능하나 **융합을 중단할 때**(한쪽 눈을 가리거나 주시하려는 노력을 안 할 때) 편위가 나타남

I. <비마비성 사시>

내사시	외사시
❶ 본태성 영아 내사시(선천성 내사시): 굴절이상이나 안구운동장애 없이 생후 6개월 이전에 발생하는 내사시. - 각은 대개 크고(>15도) 안정적 - 정면주시에서 교대주시, 측면주시에서 교차주시 - 안진은 대개 현성 눈떨림, 수평방향. 간혹 잠복도 있음 - 굴절률은 대개 정상(+1.5D) - 치료: 약시(50%)가 있으면 차폐를 실시. 2세 이전 수술(내직근 후전술) *후전술: 근육을 뒤로 붙이면 여유가 생기게 하여, 내직근을 약화시켜 정상 위치로 돌아갈 수 있게 함. ❷ 후천성 내사시 - 2~3세 이전 소아에서 다발. 원시와 밀접 a. 조절 내사시: 조절과 폭주의 불균형, 특히 폭주과다로 안구가 내측 편위. 18개월~4세 사이 아침 기상시, 피곤할 때, 늦은 오후에 간헐적 발생. 원시로 근거리 주시 때에만 발생 b. 비조절 내사시: 내사시의 50%. 생후 6개월~1년 이내. 유전, 선천 고도난시, 외안근 부착 이상, 백내장 등으로 발생 - 치료: 안경교정, 축동제, 수술(폭주의 원인인 내직근을 약화)	❶ 간헐 외사시 - 2~3세 이후 아침 기상시, 피로시, TV 장시간 시청시, 밝은 빛에 노출시 한쪽 눈을 감거나 비비는 특징. 약시 적음. 재발 多 - 치료: 근시에서 안경교정, 가림치료, 수술(외직근 후전술) ❷ 항상 외사시 : 발생빈도 낮음 - 대부분 간헐성 외사시가 진행 - 선천외사시(출생시), 감각외사시(5세 이상 혹은 성인의 백내장 후), 속발외사시(이전 내사시 수술 과잉후) +cf) 가성 사시 사시가 없는데 흰자가 덜 보이니까 외관상 사시로 보인다. <小兒通睛> 소 아 통 정 韓: 門雞眼(삼닭), 雙目睛通 원인: 稟賦不足, 驚風, 頭部外傷, 肝腎虛弱 증상: 단안 혹은 양안의 黑珠가 내측으로 偏斜되는 것이 반복적으로 나타나고 심한 경우 視物爲二도 발생. 鬪鷄眼 변증론치 1) 급성: 驚風(우황환, 안신진경환), 風痰阻絡(정용탕가감), 外傷(도홍사물탕) 2) 만성: 肝腎虛弱(기국지황환, 육미지황환), 脾虛氣弱(보중익기탕)

+cf) 특수한사시증후군 _ 4번 근무력증만 수업하셨습니다.

1. 해리수직편위: 유아내사시, 맹. 피로시 또는 무심코 있을 때 양안이 교대로 상방 편위
2. 듀안안구후퇴증후군: 편측 마비안의 심한 외전제한, 내전시 안구함몰, 검열협소
3. Brown's 증후군: 상시근건초증후군, 내전시 안구 상전불가, 외전 및 하전시 상전 가능
4. 근무력증: 수의근의 이상피로 현상. 안검하수, 외안근 운동장애로 인한 복시
초기에 안검하수(주로 한쪽만) → 점차 양쪽으로 진행 → 복시가 나타남 → 전신의 근육들의 힘빠져나감
5. 편안의 현저한 시력장애로 인한 사시: 사시약시와 밀접

II. <마비성 사시>

1) 외안근 자체의 병변: 외상으로 안와골절, 반복 근육수술로 반흔, 근육의 변성, 감염, 종양, 선천성 이상 등

2) ★안근마비

상직근마비	- 상안검거근 마비와 함께 안검하수 발생 + 하사시, 수직복시 - 머리를 마비안 반대쪽으로 기울이고 안면은 동측, 턱을 쳐든다.
상사근마비	- 상사시, 내하방운동 제한 + 회전복시가 독서나 계단을 내려가는 등 내하방으로 주시할 때 심해짐 - 머리를 마비안 반대쪽으로 기울이고 안면을 돌리며 턱을 내린다. - 대부분 안와연 외상으로 활차신경 손상이 원인
하직근마비	- 상사시, 수직복시 + 외하방 주시 때 심해짐 - 머리는 마비안쪽으로 기울어지고, 안면을 동측, 턱을 내린다.
하사근마비	- 하사시, 회전복시 + 내상방으로 운동제한 - 머리는 마비안쪽으로 기울어지고 안면을 반대쪽으로 돌리며 턱을 쳐든다.

- 3) ★**신경마비**(기출 많이 나온 파트 - 악마 참고): 뇌막염, 뇌염 및 뇌혈관 순환장애, 외상, 당뇨병, 원인불명 등 / **외전신경 > 동안신경 > 활차신경**
- 증상: **복시**, **異常頭位**(복시를 피하기 위해), **定位誤認**(마비안만으로 물체위치 오인), 현기증 및

오심
 ④ 상 두 위 정 위 오 인

*이상두위: 해당 근육 및 신경이 마비가 되어 근육이 움직일 수 없을 때, 그 근육을 대신해서 머리 운동을 하는 것

외전신경마비	- 원인: 주로 혈관(내경동맥) 문제. 이외 뇌내 종양, 혈관병, 두개내압 상승, 두개골 기저 골절 등 - 외전신경의 두개강내에서의 주행거리가 다른 신경보다 길어 쉽게 장애를 받음 - 증상: 외직근 마비 로 인한 외전장애 , 내사시 , 동측 복시 , 수평성 복시 , 복시를 줄이기 위해 안면은 마비안 쪽으로 회전 . 마비안을 외전시키면 복시가 현저해지고 내전시키면 소실되거나 감소
동안신경마비	- 원인: 특발성 (약 25%), 고혈압, 당뇨 등의 혈관질환, 직접적 외상 또는 경막하출혈에 의한 간접 외상, 내경동맥의 동맥류, 기타 종양, 매독 등 - 증상 ① 심한 안검하수 발생 (상안검거근을 지배하기 때문) ② 내직근, 상,하직근, 하사근 마비 로 내전, 상전, 하전장애 발생 . 안구 외하방 편위(외사시), 경도 안구돌출, 심하면 동공근, 모양근 등 내안근 마비로 중도 산동 및 조절마비도 발생 ③ 단독 마비시 상직근마비가 하사근마비보다 많음
활차신경마비	- 원인: 동안신경마비의 원인과 비슷. 주로 안와연 외상으로 다발 . 혈관병변은 흔하나 동맥류, 종양은 드뭄 - 증상 ① 상사근 마비 로 인해 정면 주시시 상사시(위로 봄) ex. 계단 내려갈 때 시야 확보 힘들 / ex. 왼쪽 상사근이 마비됨? → 왼쪽 눈으로 코끝을 못 봄 ② 안구 내전시 하전장애 ③ 안검하수 없이 급성으로 수직성 복시, 회선 복시 발생 ④ 복시 극복을 위한 특징적인 머리위치 (눈을 내회선 시키기 위해 건안쪽으로 머리가 기울고 얼굴을 돌리며 턱이 내려감)★ ex. 왼쪽 눈의 활차신경 마비 시 왼쪽은 아래, 오른쪽을 볼 수 없고 내회선을 할 수 없다. → 머리가 이 방향으로 움직여서 이를 보상함.

7. 마비성 사시의 치료

- ① 안근마비 초기: 복시를 피하기 위해 마비안을 차폐. 경우에 따라 부신피질호르몬제와 비타민제 등을 투여함
- ② 마비성 사시는 발병후 **최소한 6개월간은 경과 관찰 요망**. 경우에 따라 **1~2년간 관찰 요망**. 이후 증상 미호전시 수술을 고려함
- ③ 수술원칙: 1)마비근을 강하게 하는 방법, 2)동향근을 약하게 하는 방법, 그리고 3)마비근의 길항근을 약하게 하는 방법을 각각 혹은 동시에 실시

★ <瞳神返(눈)=마비성 사시(공동사시)>

- 증상: 돌연히 單眼, 兩眼에서 안구가 斜翻되어 白睛外向, 黑睛內向 혹은 向上, 向下로 偏斜되어 있으며 視一爲二, 眩暈, 頭痛, 惡心, 嘔吐 발생
 시 일 위 이 현 혼 두 통 오 심 구 토

- 변증론치 / 급성 초기 - 풍담 관련, & 외상 <----> 만성: 간신음허, 기허 쪽

- 1) 급성: 초기 外感風邪, 風傷筋脈(化風丹加減, 소속명탕), 肝陽上亢(진간식풍탕), 風痰阻絡(정용탕가감), 外傷(도홍사물탕)
 풍 담 초 탁 외 감 풍 사 풍 상 근 맥 외 중 난 가 감 간 양 상 향
 풍 담 초 탁 외 감
- 2) 만성: 肝腎陰虛(기국양혈탕), 脾氣虛弱(보익탕합향사양위탕)
 간 신 음 허 비 기 허 약

처방은 참고(강의 3초 컷 하셨습니다)

처방	주치	약재	용량(g)
加味正容湯 가 미 정 용 탕	소아사시	숙지황	5
		남성, 반하(강제), 모과, 토사자, 백복령, 차전자, 구기자	4
		강활, 감초, 조구등, 독활, 백작약주초, 산수유	3
		방풍, 백강잠, 천궁, 계내금	2.5
		감국, 맥문동, 지각, 백지, 진교, 사인(공)	2
		백부자	1

처방	주치	약재	용량(g)
祛痰清心湯 거 탄 청 심 탕	사시	산약, 당귀신	8
		백출, 백복령, 진피, 반하(강제), 나복자, 원육	6
		지실, 죽여, 맥문동, 석창포, 산조인(초), 신곡(초), 맥아(초)	4
		오미자, 황금	3
		원지	2
		기타: 생강 3片, 대조 2枚	

▶ 안구진탕

이명: 轆轤轉關, 轆轤自轉, 目睛自瞤動

- 洋: 안구진전, 눈떨림

- 증상:

- 양안에 紅痛이 없으면서 오직 안구가 가만히 있지 못하고 上下 혹은 左右 혹은 회전
- 肝風內動으로 인한 경우 눈을 감아도 진전이 감소되지 않고 병정이 1주 내, 길어도 3주 내에 소실됨

안이비 6주차

01 녹내장

- 內障眼病: 안구의 외부에는 별다른 증상이 없이 동신 내의 黃精이 혼탁해져 翳膜이 나타나 물체가 구름이 낀 것처럼 보이고 점차 昏朦해지는 것
- 범주: 圓翳內障, 驚振內障, 雷風內障, 胎患內障, 五風內障 등
- 병인: 肝經風熱, 肝腎氣血不足, 肺脾의 機能失調, 外傷 등

<내장질환의 종류>

1. 圓翳內障: 백내장
2. 驚振內障: 외상성 백내장
3. 胎患內障: 선천성 백내장
4. 五風內障: 녹내장

녹내장

1~3번은 녹내장으로 인한 증상들

- 1) 雷頭風: 급성 원발성 폐쇄각 녹내장에서 심한 두통
- 2) 偏頭風: 녹내장에서 심한 두통
- 3) 瞳人散大: 급성 원발성 폐쇄각 녹내장에서 안압상승으로 산동과 동공반사가 결여 혹은 부동

4~8번 5개 風이라고 해서 五風內障. 녹내장의 과정

4~5번은 가장 기본적인 녹내장. 6~8번은 녹내장이 진행되면서 나타나는 증상

청풍, 녹풍 위주로 보기

- 4) 靑風內障: 녹내장 전구기, 개방각 녹내장 → 가장 가벼운 녹내장
- 5) 綠風內障: 급성 원발성 폐쇄각 녹내장
- 6) 黃風內障: 녹내장이 만성기로 이행되어 발생한 각막부종, 홍채주변 유착, 시신경유두 함몰 및 위축
- 7) 黑風內障: 녹내장이 만성기로 이행되어 나타나는 증상
- 8) 烏風內障: 녹내장 각막부종, 녹내장반

방수

- 방수의 생성 및 배출장애로 인해(주로 배출 문제) 안압이 상승되어 발생
 - 안압의 상승은 안구 각 부분을 압박하는데 특히 망막과 시신경에 영향, 시력장애 발생. 조기발견 중요
 - 방수의 생성과 유출
 - ① 생성: 모양체의 비색소상피세포에서 분비
 - ② 유출: 분비된 방수는 동공을 통해 후방에서 전방으로 나와 섬유주(90%)와 포도막 공막(10%) 통로로 배출됨
 - 섬유주: 전방각에 위치하는 체모양의 구조. 90% 방수가 여기로 배출
 - ① 포도막 섬유주: 홍채 기저부에서 쉬발베선으로 뻗은 그물 모양
 - ② 각막 섬유주: 공막극에서 쉬발베선까지 확장되는 중간 대부분(각막과 공막 사이)
 - ③ 내피 섬유주: 각막 그물과 실렘관 내벽의 내피를 연결. 방수유출에 대한 저항의 대부분을 담당
 - 실렘관: 각막윤부 근처의 공막에 위치. 거대공포를 가짐. 수집관의 개구부가 위치. 직간접으로 상공막 정맥과 연결
- 섬유주에 문제가 생겨서 잘 빠져나가지 않는 것이 개방각 녹내장
- 홍채가 올라와서 배출 경로를 막으면 폐쇄각 녹내장

안압

★ 정상안압은 ()mmHg이고, 녹내장은 ()mmHg 이상인 경우 진단함 (05)

- 안압의 분포 : 정상 안압은 10~21mmHg, 양안 차이는 3mmHg 이하. 녹내장은 25mmHg 이상, 양안 차이 5mmHg 이상일 경우 진단.
- 단, 정상안압 녹내장, 고안압증 등의 특수 경우도 있음
- 안압의 일차 변동 : 아침에는 높고 오후와 저녁에는 낮은 경향. 정상 눈에서 일차변동의 평균범위는 5mmHg이고 원발성 개방각 녹내장과 고안압증에선 더 큰 편차를 보임.
- 임상적으로 오전 8시에서 12시 사이에 80% 환자에서 최고치.
- 녹내장의 분류
 - ① 원발성 및 속발성
 - 1) 원발성 : 다른 안질환과 관계 없이 발병. 개방각 녹내장, 급성 폐쇄각 녹내장, 선천성 녹내장, 고안압 녹내장 등
 - 2) 속발성 : 수정체, 홍채, 포도막 등의 질환에 병발, 외상, 수술합병증, 약물 등에 의해 발생

- ② 개방각 및 폐쇄각 : 방수 배출이 손상된 기전에 기초 분류
- ③ 선천성(발생학적) 및 후천성

진단 및 검사

★ 시야 검사 시 녹내장에서 나타나는 증상을 3가지 이상 쓰시오. (11,14,15)

★ 녹내장이 의심될 경우 시행하는 진단 및 검사법 4가지 이상을 쓰시오. (15,19)

- ① 안압측정: 골드만 압평안압계, 쉬외츠 함입안압계
- ② 전방각경 검사: 각막 후면과 홍채 전면이 이루는 각을 검사하여 폐쇄각, 개방각인지 확인
- ③ 시신경유두검사
 - 1) 녹내장성 유두함몰: C/D비가 0.4이상, C/D비의 양안 차이가 0.2이상, 수직난원형 함몰, 부분 혹은 전체 유두주위륜, 움푹 패임과 유두연 출혈
 - 2) 녹내장이 오래되면 시신경이 위축되어 창백. 망막혈관 허혈
- ④ 시야검사: 초기(주시점 주위 시야결손과 코쪽시야결손), 중심부근암점, 비측계단, 활모양 암점, 부채꼴 시야결손
- ⑤ 빛간섭단층촬영검사(Optical coherence tomography, OCT): 망막신경섬유층의 이상 확인

Shaffer 정상각 깊이 분류

- A(제 3~4도): 전방각이 20~45°로 개방각. 전방각 폐쇄가 발생할 염려는 없다.
- B(제2도): 전방각이 10~20°이며 중등도로 전방각이 좁아진 상태이다.
- C(제1도): 전방각이 10°이하이며 극도로 좁아져 있다. 결국 전방각 폐쇄가 발생한다.
- D(제0도): 전방각이 완전 폐쇄된 상태. 각막과 홍채가 맞닿아 있다.

녹내장에서 안압상승에 의해 가장 취약한 시신경 유두부위

- 하이측(Infero Temporal, IT) 부위
- 사진보고 좌우 눈 구분할 때 동정맥이 있는 쪽이 코쪽이라고 보면 됨

<五風內障> 녹내장

- 이명: 五風變, 五風變內障, 五風症
- 동인의 변화형태와 경과에 따른 분류
- ① 雷頭風: 녹내장 초기. 두통 극심하고 머리 속에서 우뢰소리
- ② 瞳人散大: 녹내장 발생 후 산동

- ③ 靑風, 綠風: 녹내장 초기 → 대부분 녹내장
 - ④ 黃風: 말기, 중증의 시물혼몽
 - ⑤ 烏風, 黑風: 녹내장 말기. 드뭄
- 4,5번은 녹내장이 진행되면서 나타나는 상태
- 원인 : 七情內傷 肝膽火盛, 肝腎陰虛 虛火上炎

폐쇄각 녹내장

★ 38세 남성이 아침 기상 후 좌측 눈에 심한 시력저하와 극심한 안통을 주소로 내원하였다. 아울러 두통, 오심, 구토, 안구경결통, 은은한 녹색의 혼탁을 보였으며 안압은 30mmHg였다. 동공 산동과 모양체충혈을 보이는 해당 질환으로 의심되는 한방병명과 양방병명을 쓰시오. (10,13)

★ 37세 남자 환자로 어제부터 급격한 시력저하, 심한 안통, 두통, 오심, 구토 발생하여 내원하였다. 촉진 시 안구는 경결하면서 심한 통증을 나타내었고 모양체 충혈, 산동 등이 보였다. 의심되는 녹내장의 종류 및 한방병명을 각각 쓰시오. (05,07)

- 주변부 홍채에 의해 전방각이 완전히 혹은 부분적으로 폐쇄되어 방수유출 장애로 발생
- 원인: 가족력 경향. 원시안이나 얇은 전방안에서 쉽게 발생
- 증상

- ① 급성: 급격한 시력저하, 심한 안통, 두통, 오심, 구토 발생. 안구경결통, 모양체 충혈, 각막부종, 산동 발생. 48시간 이내 조절 안되면 실명 초래
- ② 아급성: 간헐적 우각폐쇄, halo 현상, 두통, 안통, 각막부종, 산동 등이 발생. 자연회복
- 치료 : 응급치료(48시간 이내). 레이저홍채절개술, 레이저홍채성형술 시행

★ <綠風內障>

- 이명 : 綠水灌珠, 綠風變花, 綠水灌瞳, 綠水貫瞳人, 綠水泛瞳人, 綠翳青盲, 綠盲
- 洋 : 급성 원발성 폐쇄각 녹내장
- 증상 : 두통이 심하고 안구가 脹滿하며 점차 硬結해져 마치 돌과 비슷하고 瞳神散大 및 혼탁이 은은한 녹색으로 변하면서 시력저하 발생
- 변증론치 → 실증 위주. 肝火가 주요 원인
 - 1) 초기 肝鬱氣滯, 氣火上逆: 丹梔逍遙散
 - 2) 肝膽風火, 上攻於目: 綠風羚羊飲
 - 3) 痰火上壅, 阻滯清竅: 將軍定痛丸
 - 4) 肝胃虛寒, 陰邪上犯: 吳茱萸湯
 - 5) 陰虛陽亢, 風陽上擾: 阿膠雞子黃湯

개방각 녹내장

- 선행 안질환 없이 안압상승으로 인해 시신경 장애를 초래, 특징적 시야변화를 보이는 증후군
- 원인: 방수유출로의 저항증가로 발생. 섬유주 변성 및 간격 폐쇄, 실렘관 내피 변성, 상공막 내 방수유출로 저항증가 등
- 증상: 두통, 안통은 가볍고 중심시야는 정상, 주변시력이 점차 좁아짐. 때로 갑작스런 안압상승, halo현상, 안통, 두통 발생. 시신경유두의 녹내장성 함몰을 보임. 말기에 위축으로 실명
- 치료 : 조기발견 및 치료가 중요. 약물치료원칙(21이하로 낮춤)

<靑風內障>

- 洋 : 녹내장 전구기, 개방각 녹내장
- 증상 : 초기 경미한 두통, 현훈, 眼脹感. 점차 동공이 靑山에 연기가 자욱한 것처럼 靑色 혹은 淡烟色을 띠며 혼탁. 眼昏, 眼花 발생, 점차 瞳人散大, 昏朦. 오래되면 綠風內障으로 전변
- 특징 → 녹내장의 기본적인 특징
 - 1) 안압 증가
 - 2) 시신경유두의 병리적인 함몰
 - 3) 시야결손
- 변증론치 : 각 변증에 化癥利水 약을 가하여 방수의 滯留狀態를 개선
 - 1) 氣鬱化火: 加味逍遙散
 - 2) 肝熱生風: 羚羊角湯加減
 - 3) 痰火升擾: 黃連溫膽湯加減
 - 4) 陰虛風動: 阿膠雞子黃湯加減
 - 5) 肝腎兩虧: 杞菊地黃丸 腎氣丸加減
 - 6) 氣虛血瘀, 神水瘀積: 補陽還五湯加減

스테로이드성 녹내장

- 스테로이드제 점안약을 장기간 사용한 사람에서 발생.
- 개방각 녹내장과 유사한 증상
- 부신 피질 호르몬제의 중단으로 병의 진행이 중단될 수 있음

신생혈관 및 출혈성 녹내장

★ 15년 전부터 당뇨병이 있고 5년전부터는 우측눈에 당뇨합병증이 발생하여 약물치료중인 55세의 남자환자로, 며칠전부터 우측 눈에 창통이 심하고 단단하며, 홍채가 홍색을 띠게 되어 내원하였다. 검안경 검사상 홍채와 전방각 시야에 신생 혈관이 다수 보이고 동공은 약간 산대되어 있으며, 약간의 출혈이 전방 아래 고여 있었다. 예상되는 한방질환명과 양방질환명은? (11,13,15,18)

신생혈관은 잘 터지기 때문에 출혈성과 같이 생각해야함

- 원인: 망막중심정맥폐쇄와 진행된 당뇨망막병증에서 홍채 앞면과 전방각이 신생혈관으로 덮여 방수유출의 방해로 발생. 출혈성 녹내장
- 증상: 통증 극심, 안구가 부풀면서 경화, 홍채가 홍색을 띠고 홍채와 전방각사이 신생 赤脈, 瞳神散大, 간혹 血灌瞳神이 반복 발생
- 수술 시도, 예후 매우 불량
- 韓: 烏風內障

선천성 녹내장

- 영아 녹내장: 출생 후 3년 이내 발생
- 약년성 녹내장: 그 이후 발생
- ① 원발성 영아 녹내장(남:여=2:1)
 - 원인: 염색체 열성유전. 섬유주 및 방수유출로의 구조이상
 - 증상: 생후 1년 이내(90%). 양측성. 초기(유루, 수명, 안검경련). 牛眼, 각막 혼탁 및 부종, 수정체 탈구, 백내장과 합병
- ② 풍진 증후군: 산모의 풍진감염. 10%에서 녹내장 발생. 牛眼, 백내장 및 망막 색소변성 병발
- ③ 무홍채: 선천적 홍채결손. 백내장, 수정체편위, 황반부 및 시신경 발육부전
- 치료: 확진시 즉시 수술

속발성 녹내장

- 다른 눈질환, 외상, 수술, 약물 등으로 인해 우각 및 섬유주 폐쇄로 방수 유출로가 장애받아 단안에 발생
- ① 안질환: 홍채모양체염에서 홍채의 종창, 축동, 삼출물로 인해 우각부 폐쇄. 홍채후유착, 동공폐쇄 등으로 발생. 성숙백내장 오래 방치하여 수정체 종창으로 동공폐쇄 유발
- ② 외상: 홍채, 모양체 외상후 전방출혈로 적혈구의 섬유주 폐쇄로 급격히 발생

③ 수술합병증: 백내장 수술후

- 대부분 백내장 수술 후 발생. 드물게 녹내장 수술 후 악성 녹내장 발생
- 증상: 수술 후 頭目脹痛이 도리어 심해지고, 전방소실, 안압의 지속적 증가 발생
- 양안성. 한쪽 눈에 발생한 후 다른쪽도 수술 또는 축동제 사용시 발생함

④ 약물: 스테로이드 장기사용

고안압증

- 녹내장성 장애는 발견되지 않아도 두 번의 연속검사에서 안압이 21mmHg 이상으로 측정 되었을 경우
- 노인에서 젊은 사람보다 안압이 더 높고, 특히 여자가 더 높음. 노년 여성의 정상 안압은 24mmHg까지 볼 수 있음
- 5년이상 지나도 녹내장으로 진행하지 않으면 의미 없음.
- 치료는 필요없음. 고위험군 환자에서만 원발성 개방각 녹내장 발생을 지연, 예방을 위해 필요

정상안압 녹내장

★ 정상 안압 녹내장에 대하여 설명하시오. (17)

- 저안압 녹내장. 원발성 개방각 녹내장의 변형
- 노인에 많고 여자에게 호발
- 증상
 - 1) 평균안압 21mmHg 이하
 - 2) 녹내장성 시신경손상과 시야손실
 - 3) 전방각경검사상 개방각
 - 4) 녹내장성 시신경 유두손상을 일으킬 다른 원인이 없는 경우
- 원발성 개방각과 다른 특징: 편두통, 레이노 현상, 전신성 야간 저혈압 호발
- 고안압증, 정상안압 녹내장은 노년 여성에게 많이 나타남
- 정상안압 녹내장은 기허의 양상을 나타냄

급성 녹내장의 감별

	급성 홍채염	각막궤양	녹내장	
			급성	만성
시력	경도 저하	보통 저하	심한 장애	정상, 심한장애
동통	중등도	중등도, 심함	심함	경도-중등도
분비물	유루	유루-화농성	유루	없음
결막충혈	윤부주위 심함	미만성	미만성	모양체혈관충혈
각막	각막내피침착	병소부위혼탁	부종	수포각막병증
홍채	삼출물	정상	위축	위축
동공	축동	정상	중등도 산대	산대
대광반사	경미	정상	무반응	경미, 무반응
안압	정상	정상	심한 상승	상승
전방각	정상	정상	폐쇄	홍채전방 유착
시신경유두	정상	정상	정상	함몰 및 위축
세균검사	-	원인균	-	-

雷頭風 뇌두풍

- 이명 : 左右偏頭風, 陰邪風, 陽邪風, 卒腦風, 巔頂風, 游風
- 洋 : 급성 원발성 폐쇄각 녹내장에서 심한 두통
- 증상 : 머리속에 광음이 들리는 듯한 극심한 頭痛, 頭風과 단안 혹은 양안에서 시력저하, 동공산대가 있으면서 惡心嘔吐, 壯熱憎寒 등의 증상도 발생
- 변증론치(風熱, 痰火)
 - 1) 壯熱憎寒, 頭痛, 동공산대 - 청진탕가감
 - 2) 동공 형태 정상, 白睛混濁 - 삼황거열전

偏頭風 편두풍

- 분류
 - 1) 陰邪風: 腦後枕骨 동통. 內障翳膜 발생
 - 2) 陽邪風: 前額 및 眉稜骨 동통. 元氣虛弱으로 발생
 - 3) 卒腦風: 雷頭風과 비슷
- 洋 : 녹내장에서 심한 두통
- 증상 : 눈병으로 인하여 좌 혹은 우측에 일측성 두통이 발생
- 치료 : 雷頭風과 비슷

瞳人散大 동인산대

- 이명 : 通瞳, 瞳人散沓, 瞳人開大, 輻輳展開, 瞳人闊大
- 洋 : 급성 원발성 폐쇄각 녹내장에서 안압상승으로 散瞳과 동공반사가 결여 혹은 부동
- 증상 : 雷頭風 또는 偏頭風으로 극심한 안통 및 두통이 일어나면서 동공이 극도로 산대 되고 시력 저하 발생
- 변증론치
 - 1) 痰厥頭風: 정용탕, 청담음
 - 2) 暴怒傷肝: 조기탕, 자주환
 - 3) 外傷: 도홍사물탕
 - 4) 肝腎陰虛: 지백지황환, 자음지황탕

靑風內障 청풍내장

- 洋 : 녹내장 전구기, 개방각 녹내장
 - 증상 : 초기 경미한 두통, 현훈, 眼脹感. 점차 동공이 靑山에 연기가 자욱한 것처럼 淡靑色 혹은 淡烟色을 띠며 혼탁. 眼昏, 眼花 발생, 점차 瞳人散大, 昏朦. 오래되면 綠風內障으로 전변
 - 변증론치
 - 1) 초기 肝火: 단치소요산, 청풍영양각탕, 용담사간탕
 - 2) 肝腎陰虛: 환정환가감, 기국지황환가감, 주경환가감
- 실증에는 영양각 / 허증에는 환정환 사용

黃風內障 황풍내장

- 綠風內障 末期
- 洋 : 녹내장이 만성기로 이행되어 나타나는 각막부종, 홍채주변 유착, 시신경유두 함몰 및 위축
- 증상 : 綠風內障을 失治하거나 오랫동안 진행되어 瞳人散大가 축소되지 않고 동신이 회황색 혹은 황백색으로 혼탁해지면서 시력저하 발생

黑風內障 흑풍내장

- 綠風內障 末期
- 洋 : 녹내장이 만성기로 이행되어 나타나는 증상
- 증상 : 동신내가 흑색으로 혼탁하게 변하면서 시력저하 발생

烏風內障 오풍내장

- 綠風內障 末期
- 洋 : 녹내장 각막부종, 녹내장반, 신생혈관 녹내장 → 출혈도 동반 가능
- 눈앞에 黑花 혹은 烏花가 발생, 동신내의 혼탁이 흑색, 翳膜은 청백색을 띠

02 유리체질환

★ 후유리체 박리에서 비문증과 섬광증의 한방병명은? (11,13,14,15)

- 유리체(=靔膏)는 무색투명하고 혈관이나 신경을 포함하지 않음
- 기능: 광선을 통과시키고 망막을 지지하여 색소상피층과 긴밀하게 서로 붙어 탈락함을 방지하며 정상적인 안구의 형태 유지
- 병변시 유리체 혼탁과 함께 비문증, 광시증, 변시증 등을 일으키고 후유리체 박리, 망막 박리, 출혈 등이 발생
- 분류 → 비문증, 섬광증 위주로 알아두기

① 雲霧移睛: 비문증, 유리체 혼탁 (깨끗해야하는 유리체에 혼탁이 생기는 것)

② 螢星滿目: 섬광증 (후유리체 박리; 망막이 찢어지는 순간 번쩍하는 것)

③ 神光自現: 螢星滿目보다 증상이重的인 것

유리체 혼탁

- 유리체 혼탁의 대표적 증상 : 비문증
- 원인: 유리체염, 망막염, 포도막염, 시신경염 등에서 혈액, 삼출물, 염증세포, 색소 및 섬유 등이 유리체로 흘러나와 혼탁을 일으킴. 이외 유리체 출혈, 후유리체 박리 등에서도 발생
- 증상: 혼탁에 의한 그림자가 망막에 투영되어 자각적으로 혼탁이 보이는 것으로, 주로 까만 점, 실, 먼지 모양으로 느낌
- 시일이 경과되면 혼탁이 없어지거나 환자 스스로 적응됨
- 심한 혼탁에서 물체가 커지거나 많아져 시력장애 발생

★ <雲霧移睛> 운무이정

- 이명 : 眼前黑花, 蠅翅黑花內障, 飛蠅散亂, 蠅影飛越, 飛蚊幻視
- 洋 : 유리체의 감염, 혼탁, 출혈, 박리 등에서 나타나는 비문증
- 증상 : 외부에 별다른 이상이 없이 구름과 같은 陰影, 깃발, 파리, 나비가 움직이는 것처럼 자각. 점차 靑盲, 暴盲이 됨
- 변증론치 → 습, 어혈의 개념으로 봄
 - 1) 濕熱蘊結: 豬苓散加減
 - 2) 氣滯血瘀: 血府逐瘀湯
 - 3) 虛火上炎: 知柏地黃丸
 - 4) 肝腎虧損: 明目地黃丸
 - 5) 痰瘀互結: 活血散結方加減

후유리체 박리

★ 후유리체 박리로 인해 발생하는 대표증상 2가지를 증상-한방병명의 형태로 쓰시오. (19)

- 원인: 대부분 노년 변화. 이외 고도근시, 당뇨, 포도막염, 안구외상 등에 의한 유리체 액화
- 증상: 갑자기 비문증과 함께 망막이 자극 받아 불이 번쩍이는 느낌인 섬광증이 발생. 때로 황반부 부종에 의한 시력장애 발생. 안저소견상 시신경유두에 고리모양 혼탁한 → 찢어지는 순간에 번쩍 하면서 섬광증이 발생. 후유리체 박리가 일어나면 액체가 들어와서 망막손상까지 동반됨. 섬광증이 있다면 안저검사 꼭 해주기
- 합병증: 망막열공(안저 상부, U모양) 및 박리, 유리체 출혈에 주의

★ <螢星滿目> 형성만목

- 神光自現 : 螢星滿目보다 증상이重的인 것
- 洋 : 망막의 열공 및 박리, 후유리체 박리 등에서 발생하는 섬광증(photopsia)
- 증상 : 자각적으로 눈앞에 미세한 별빛, 반디불빛, 電光, 閃光 등이 현란하게 발생. 심하면 화염이 간헐적으로 비치는 느낌이 발생
- 변증론치
 - 1) 肝腎兩虛: 加減駐景丸
 - 2) 心脾兩虛: 天玉補心丹

03 망막질환

- 眼昏 : 시력의 하강으로 인해 자각적으로 시야가 뚜렷이 밝지 않음을 뜻하는 주변시야 및 시력저하
- 眼盲 : 시력의 저하가 심해져 중심시력이 상실하여 사물을 볼 수 없는 상태. 失明
- 洋 : 망막 또는 시신경질환
- 망막의 혈액공급 : 외층 1/3은 맥락막의 모세혈관, 내측 2/3는 망막중심동맥에서 공급. 중심와는 맥락막 모세혈관에서 영향을 받음

망막혈관의 순환장애

1. 원인: 당뇨병, 고혈압 등 혈관질환 및 콜레스테롤 침윤에 의한 혈관 벽의 비후로 발생
2. 병리적 변화(안저 소견상)
 - 1) 혈관의 협세: 기능적 혈관 경련이나 경화로 인한 혈관벽의 비후로 발생. 전반적 협세(망막변성, 시신경위축 등), 국소적 협세로 구분
 - 2) 반사선 변화: 정상 동맥벽에서 가는 반사선이 관찰. 혈관벽의 경화나 콜레스테롤 침윤 되면 반사선이 넓어짐.
 - 3) 혈관초: 동맥경화증에서 혈관벽주위의 섬유성 조직형성으로 벽의 양측, 한쪽에 백색선 출현
 - 4) 혈관의 사행: 당뇨, 고혈압 등에서 혈관벽 조직이 섬유조직으로 대체되면서 길이와 직경이 증가되므로 사행 발생
 - 5) 망막의 정맥박동: 시신경유두 근처에서 심장박동과 일치. 안구 압박시 박동유발가능. 병적인 경우 녹내장, 대동맥판 역류증 등에서 발생
 - 6) 정맥확장: 중심동맥폐쇄, 울혈유두, 당뇨병 등에서 정맥압의 증가 혹은 안압 저하시 발생

3. 망막출혈

★ 망막출혈의 부위에 따라 망막전방출혈, 점상출혈, 불꽃 모양의 출혈로 구분하여 설명하시오. (18)

- 1) 원인: 혈관성 질환(고혈압, 동맥경화증 등), 전신질환(백혈병)
- 2) 종류: 망막전방출혈(망막과 유리체사이 출혈. 황반에 다발), 점상출혈(외망상층과 내과립층의 출혈), 불꽃 모양 출혈 또는 선상 출혈(신경섬유층 출혈).

4. 삼출물 형성: 점상(망막 외층의 만성부종), 황반성(심한 고혈압, 시신경염 등), 면화반(신경섬유층의 허혈경색으로 인한 괴사)
5. 망막의 신생혈관

★ 폭맹의 진단요점 4가지를 쓰시오. (12)

★ 다음 중 급격한 시력저하를 초래하여 폭맹에 이르게 되는 질환은? (08,10,11,12,15)

★ 폭맹과 청맹에 해당하는 상병명을 각각 3가지 이상 쓰시오. (19)

<망막질환의 종류>

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. 망막동맥폐쇄 | 6. 중심성 장액성 망막병변 |
| 2. 망막정맥폐쇄 | 7. 중심성 삼출성 맥락막망막염 |
| 3. 망막정맥주위염 | 8. 노인성 황반변성 |
| 4. 삼출성 망막병변 | 9. 원발성 망막색소변성 |
| 5. 당뇨병성 망막변성 | 10. 원발성 망막박리 |

1. 暴盲 : 망막혈관의 순환장애(폐쇄 및 출혈), 시신경염, 허혈성 시신경증 등
- 진단요점 4가지
 - 1) 외관상으로 정상
 - 2) 시력이 급격하게 하강
 - 3) 심한 경우 실명
 - 4) 眼底病
2. 靑盲 : 당뇨병성, 고혈압성 망막증, 노인성 황반 변성, 유소아의 유전성 망막증, 시신경위축, 영양장애나 중독성 약시
3. 視瞻昏渺 : 맥락막 및 망막변성, 망막염, 유리체 혼탁. 부분적 시야결손의 시로 및 시색질환
4. 視瞻有色 : 색시증
5. 雀目 : 선천성 야맹증(高風雀目; 망막색소 변성, 안저 백점증 등), 후천성 야맹증(肝虛雀目; 비타민 A 흡수장애, 맥락막 결여 및 변성, 안구건조 등)

→ 대부분의 망막 병변은 한의학적으로 폭맹, 청맹의 범주에서 설명됨

망막동맥폐쇄

★ 좌측 눈의 갑작스런 시력저하로 내원하였다. 자세히 보니 동공의 대광반사가 소실되었고, 안저 소견상 망막 동맥이 가느다랗고 망막 내측의 부종으로 망막은 창백하고, 중심와는 앵두반점이었다. 다음 질환의 한방병명과 양방병명은? (12,14,15)

★ 앵두반점이 나타나는 증상의 한의학적 병명과 양방병명을 써라. (09)

★ 망막 동맥 혈관폐쇄로 인한 특징과 안저 소견과 예후를 쓰시오. (17)

망막동맥, 정맥의 폐쇄는 눈질환의 중풍이라고도 함. 중풍과 비슷한 예후를 보임

- 분류

- 1) 망막분지동맥폐쇄(색전증)
- 2) 망막중심동맥폐쇄(세동맥경화)
- 3) 모양체망막동맥폐쇄

- 원인: 세동맥경화 관련 혈전증, 내경동맥 색전증, 심장 색전증, 동맥주위염 등 혈관 폐쇄. 평소 고혈압 이환

- 증상: 노년층에서 편측성. 갑작스런 심한 시력저하, 동공의 대광반사 소실.

- 안저소견: 망막동맥 가늘어짐, 망막내측 부종으로 창백함(혈액공급X), **중심와는 앵두반점**

→ 앵두반점 주위는 하얗게 나옴

- 치료: 초기(안구마사지, 안압저하), 20분 후(전방천자)

- 예후: 불량. 발병후 6~8시간 내 처치해야 시력회복 기대 (응급질환)

- 변증론치 → 동맥이 막힌 것으로 어혈의 관점

- 1) 氣血瘀阻: 通竅活血湯
- 2) 肝陽上亢: 鎮肝熄風湯
- 3) 痰熱上擾: 黃連溫膽湯
- 4) 氣虛血瘀: 補陽還五湯

망막정맥주위염

★ 54세 남자환자. 아침기상 후 갑자기 우측 눈에 심한 시력저하가 발생하였다. 평소 당뇨가 있고 10년 가까이 흡연. 통증은 없고 안저검사 상 정맥혈관이 다수 보이며, 유두 중심의 방사선형 붓질 한 것 같은 출혈과 면화반이 있으며 망막전반에 부종이 보였다. 한방병명과 양방병명을 기하시오. (09,11,15,18)

- 분류

- 1) 망막분지정맥폐쇄(제일 흔함)
- 2) 망막중심정맥폐쇄

3) 절반망막정맥폐쇄

- 발병률 : 망막동맥 혈관폐쇄의 6배

- 원인 및 동반인자: 노령, 전신질환(고혈압, 당뇨, 흡연, 비만, 동맥경화증 등), 이외 혈전성향 질환(적혈구증가증, 골수증 등)

- 증상: 대부분 편안에 동통은 없고 급격한 시력감소. 안저상 폐색부위 주변의 혈관 사행, 유두 중심의 방사선형 붓질한 것 같은 출혈과 면화반, 망막 전반 부종 동반

- 합병증: 망막의 신생혈관(초자체 반복 출혈), 홍채의 신생혈관(전방에 유착하여 녹내장 발병).

- 치료 및 예후: 범안저 광응고술로 혈류순환 향상. 예후(대체로 시력은 회복)

- 기전: 망막정맥이 폐색되면 정맥이 사행, 팽창되었다가 출혈, 수종, 삼출이 특징

- 발병률은 망막동맥폐쇄의 6배

- 변증론치 → 중풍에 준하여 처방 사용

- 1) 氣滯血瘀: 血府逐瘀湯
- 2) 肝陽上亢: 天麻鉤藤飲
- 3) 陰虛瘀熱: 生蒲黃湯加減
- 4) 痰瘀鬱滯: 二陳湯合 桃紅四物湯

망막정맥주위염

- 망막 정맥 주위 간극 혹은 그 혈관 외막 염증.

- 眼底病 환자의 2% 차지

- 20~30세 청년 남자에서 호발, 반복 출혈이 되기 쉬워 '청년 반복성 망막 유리체 출혈'

- 변증론치: 止血, 消瘀, 寧血, 補血의 治法

- 1) 胃火熾盛: 玉女煎合瀉心湯
- 2) 肝火上炎: 龍膽瀉肝湯
- 3) 虛火傷絡: 寧血湯加減
- 4) 心脾兩虛: 歸脾湯加減
- 5) 破血化水: 桃紅四物湯

- 치료 : 대량의 스테로이드제 전신 투여 또는 결막하 주사. 혈관신생부위 레이저광응고술

- 韓: 暴盲

- 이명: 目衄, 血灌瞳人

- 징후: 주변 망막정맥의 출혈, 혈관 확장, 사행 등과 함께 망막과 유리체 내에 혈관신생, 특히 유리체 혈관신생은 특징적인 반복성 유리체 출혈을 유발하여 심한 시력장애 발생

삼출성 망막 병변 (코우즈병; Coats disease)

- 망막모세혈관 확장증의 가장 심한 형태
- 韓: 視瞻昏渺, 暴盲
- 특징: 1세~10세사이 남아, 단안에 발생. 시력상실, 사시, 백색동공
- 징후: 하이측 망막에 망막모세혈관 확장증 발생. 점차 망막내 혹은 망막하에 대량의 백색 혹은 황백색 삼출물과 출혈 발생. 특히 황반부 자주 침범. 말기에 **백색동공**, 사시 등 발생
- 합병증: 삼출성 망막박리, 홍채혈관신생, 포도막염 등
- 치료및 예후: 초기 광응고술, 냉동술 시행. 아동 환자는 스스로 시력장애를 언급하지 못하므로 조기 발견이 어려워 백색동공 등이 나타나서야 비로소 부모가 발견하고 진료를 시작하므로 예후가 좋지 못함
- 변증론치
 - 1) 腎元不足, 痰濕上泛: 三仁五子丸合 二陳湯
 - 2) 心火上搖, 血熱痰瘀: 清營湯加減
 - 3) 脾氣虛弱, 痰濕瘀滯: 參苓 白朮散

<暴盲>

- 洋 : 망막혈관의 순환장애, 폐쇄 및 출혈, 시신경염, 허혈성 시신경증 등에서 급격히 발생한 시력저하, 시야장애
- 증상 : 갑자기 시력저하. 때로 眼脹痛, 안구를 움직이면 통증 발생. 초기에 비문증, 시물이상 등이 있으면서 돌연히 昏矇
- 변증론치 → 습, 담, 어를 제거하는 치료
 - 1) 情志抑鬱, 氣滯血瘀: 단치소요산, 통규활혈탕, 시호소간산
 - 2) 濕熱, 痰熱: 감로음, 주경환
 - 3) 肝腎陰虛: 명목지향환, 환정환
 - 4) 脾腎陽虛: 우귀환가감

당뇨병성 망막변성

- 30세 이전 당뇨병환자에서 30년 후엔 90%에서 발생
- 韓: 靑盲, 視瞻昏渺, 暴盲 → 중심와에서 문제가 되면 폭맹
- 망막의 미세순환장애로 유발되며 후극부 모세혈관에서 다발
- 혈관신생 유무에 따라

① 증식성: 신생혈관이 후극부 동정맥 교차부의 정맥과 시신경유두연에서 흔히 발생. 쉽게 파열되어 유리체 출혈, 견인성 및열공성 망막박리가 발생

② 비증식성: 초기 혈관주위세포 손실과 모세혈관 내벽의 비후로 정맥확장과 소혈관류 형성. 이외 점상(심층) 또는 화염상(표층) 출혈, 면화반 발생

- 치료 및 예후: 혈당조절. 범망막광응고술

→ 신생혈관이 많이 만들어졌느냐, 아니냐로 증식성, 비증식성구분함

- 임상적 당뇨망막병증의 분류

① 배경 또는 비증식 : 망막에 병변

② 증식 : 망막표면 위나 아래로 증식

③ 증식전 : 증식질환이 임박

- 변증론치

- 1) 陰虛燥熱+涼血散血: 白虎加人蔘湯
- 2) 氣陰兩虛+涼血化瘀 : 生脈散合玉女煎
- 3) 肝腎陰虛+活血 : 杞菊地黃湯
- 4) 脾虛氣弱+化濁 : 升陽益胃湯

중심성 장액성 망막병변

장액은 맑은 액체. 장액성 망막병변의 특징은 視物變形

- 황반의 망막색소상피층 부근에 발생하는 국한성 장액성 천층 탈출증

- 韓: 視瞻昏渺, 視直如曲, 視正反斜, 自昏花, 目妄見, 肝風目暗症

- 20~45세 청장년 남성에서 편측성으로 발생, 예후는 좋으나 자주 재발

- 증상: 경도의 시력감소, 視物變形(큰 것을 작은 것처럼 보거나 기울어지게 본다는지, 곧은 것을 굽은 것으로 봄)과 가벼운 색각장애가 동반

- 변증론치

- 1) 濕濁上犯: 五苓散合 二陳湯
- 2) 肝經鬱熱: 加味逍遙散
- 3) 肝腎陰虛: 四物五子丸
- 4) 痰瘀鬱滯: 血府逐瘀湯
- 5) 心脾兩虛: 歸脾湯, 人蔘養榮湯

- 치료 : 누출 부위가 망막중심오목이 아니면 광응고술 실시

중심성 삼출성 맥락막망막염(중심성 장액맥락막병증)

- 황반부 주위에 국한된 감각망막박리(황백색 삼출, 출혈)를 특징으로 하는 맥락막 망막의 육아종성 염증
- 韓: 視瞻昏渺, 視直如曲
- 20~40세 사이의 남녀에서 편안에 발생
- 증상: 편측의 변시증, 소시증, 중심성 암점과 관련된 시력저하 호소
- 변증론치
 - 1) 陰虛火動: 知柏地黃湯
 - 2) 濕熱痰瘀: 三仁湯加減
 - 3) 肝經鬱熱: 丹梔逍遙散合 挑紅四物湯
 - 4) 肝腎兩虛: 杞菊地黃丸

노인성 황반변성

- 대부분 65세 이상의 고령자에서 실명의 주요 원인
- 韓: 靑盲, 視瞻昏渺, 暴盲
- 원인 및 병리: 흡연이 유일한 위험인자. 망막색소상피층에서 만들어진 초자양 물질이 기저막과 내부 콜라겐층 사이의 부르크막 안쪽에 침착되어 색소상피 변성을 유발
- 증상
 - ① 초기: 황반부에 경계가 분명한 황백색 점(드루젠), 색소상피층의 과색소 침착 및 위축
 - ② 후기: 지도모양 망막색소상피 위축 및 박리, 신생혈관 발생. 진행되어 황반부 출혈, 원반상 반흔 형성, 영구적인 시력저하
- 분류
 - ① 위축성(건성, 비삼출성): 가장 흔함. 50세 이상에서 다발, 양안 동시 발병. 드루젠과 망막 색소상피 위축 동반. 視瞻昏渺. → 대부분은 위축성
 - ② 삼출성(습성, 신생혈관): 드물. 예후 불량. 60세 이상에서 다발, 항상 한쪽 눈에 먼저 발생. 맥락막 신생혈관이나 망막하반흔이 특징. 暴盲.
- 변증론치
 - 1) 肝腎虧虛: 四物五子丸
 - 2) 脾虛氣弱: 補中益氣湯
 - 3) 陽虛火旺: 知柏地黃湯合 生蒲黃湯

원발성 망막색소변성

- 염증 소견없이 간체를 침범하는 망막의 퇴행성 위축. 상염색체 우성, 상염색체 열성, X-염색체 열성유전
- 韓: 高風雀目, 夜盲, 雀目
- 증상: 양안 시야협착, 야맹증 발생. 중심시력의 변화는 없음. 안저소견상 망막 세동맥의 위축, 뼈조각 모양의 망막 색소 침착, 왁스 모양 시신경유두 창백
- 예후 및 합병증: 나쁨. 후낭하 백내장, 광우각 녹내장, 근시, 후유리체 박리 등
- 변증론치
 - 1) 肝腎陰虛+活血明目: 明目地黃丸
 - 2) 脾虛氣弱+活血明目: 補中益氣湯
 - 3) 腎陽虛衰+活血明目: 右歸丸加減

원발성 망막박리

★ 원발성 망막박리에서 망막파열 3가지를 쓰시오. (17)

1) 망막파열

1. 원공: 고도근시, 안구좌상, 낭포양 황반변성 등으로 발생
 - 망막 변성으로 얇아진 부위에 작은 원공 발생. 망막박리, 황반 열공의 원인
2. 열공: 망막질환, 유리체 염증 및 출혈, 안구외상 등 발생
 - 망막과 유리체가 유착된 부위에 유리체에 의한 견인력이 작용하여 망막이 찢어짐. 출혈, 비문증, 혼탁 등 발생
3. 해리: 안구외상, 만성 모양체염, 선천적 이상 등
 - 유리체 견인력으로 망막 거상연이 모양체 편평부에서 분리

2) 망막박리

- 망막박리: 망막색소상피로부터 망막하액에 의해 신경망막이 분리.
(열공성, 견인성, 삼출성)
- ① 열공성 망막박리
 - 신경망막 전층 결함으로 액화된 유리체겔로부터의 망막하액이 망막하의 공간으로 접근
 - 증상: **섬광**, **비문증**, 망막박리에 의한 시야결손(검은 커튼이 가리는 증상), 안압이 정상에 비해 대개 5mmHg 낮음
 - 안저소견: 박리된 망막은 안구내로 들떠있고 주름이 잡혀 있으며 회색빛을 띰

② 견인성 망막박리

- 신경망막이 수축하는 유리체망막막에 의해 망막색소상피로부터 당겨짐. 증식성 유리체 망막병증, 미숙아망막증, 관통성 후부외상 등이 원인
- 증상: 유리체망막 견인이 점차적으로 발생. 급성 후유리체 박리와 관련이 없어 **광시증과 비문증은 보통 없음**. 시야결손도 대개 천천히 진행. 망막하액은 열공망막박리보다 얇음. 박리된 망막은 오목하고 열공 없음
- 만일 견인망막박리에서 열공이 발생하면 열공망막박리의 특징을 띠고 더 빨리 진행함

③ 삼출성 망막박리(장액성, 이차성)

- 맥락막 모세혈관에서 나온 망막하액이 손상된 망막색소상피를 통해 망막하 공간으로 도달. 맥락막 종양, 후공막염, 심한 고혈압, 망막하 신생혈관 등이 원인
- 증상: 유리체망막 견인이 없어 **섬광은 없으며** 유리체염이 동반되면 비문증 발생가능. 시야결손이 갑자기 발생, 급속히 진행. 박리된 망막은 볼록한 모양을 갖고 열공은 없으며 유동적. 박리 소실후 **leopard 반점** 발생

<神光自現, 暴盲>

- 남성 환자가 많고 대부분 편안에 발병, 중노년의 고도근시에서 다발
- 변증론치(수술전 益氣活血利水, 수술후 시력회복 위주) → 견인성 망막박리 위주

1) 肝腎虧虛: 杞菊地黃湯

2) 脾虛濕泛: 補中益氣湯

3) 氣陰兩虧: 補水寧神湯

4) 肝經鬱滯: 逍遙散加減

- 치료 : 수술 목표는 모든 열공을 발견하여 열공 주위 망막을 망막색소상피에 접합시켜서 영구적으로 유착시킴

망막박리의 발생기전

1) 열공망막박리

유리체의 액화 → 망막에 열공 발생 (찢어짐) → 액화된 유리체가 흘러들어 망막 박리

2) 견인망막박리

안구 내 섬유조직에 의한 견인. 과자봉지가 찢어지기 직전까지 늘어난 상태

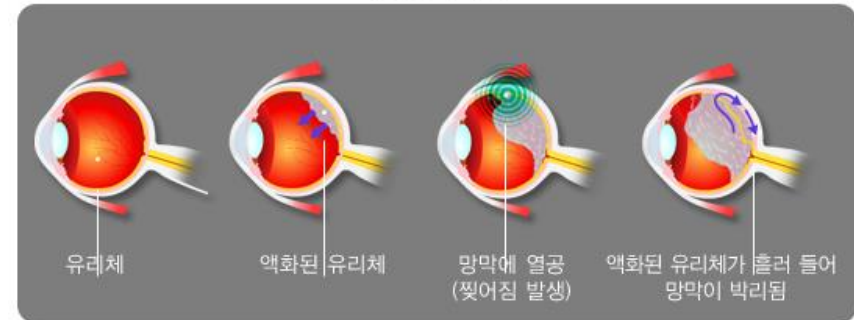
3) 삼출망막박리

맥락막쪽에서 삼출물이 차오르면서 망막이 박리됨

→ 섬광증 여부 = 망막이 찢어졌는지

<그림. 망막박리의 발생기전>

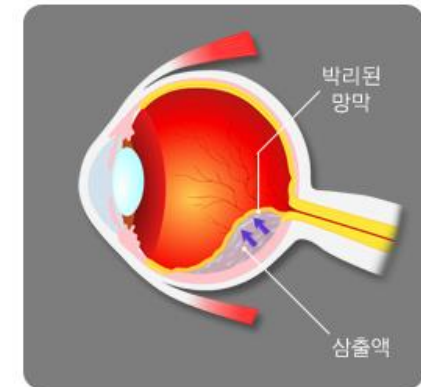
<열공망막박리>



<견인망막박리>



<삼출망막박리>



고혈압성 망막증

- 원인: 본태성 고혈압(140/90 이상의 혈압을 기초)
- 병리: 세동맥 경화로 벽이 두꺼워져 빛반사 소실, 협착과 동정맥 교차부의 동정맥꼬임 발생
- Keith-Wagener의 4단계
 - ① 1단계: 초기, 혈관긴장도 항진되 동맥혈관의 전반적 협소화
 - ② 2단계: 확장기 혈압 110이상. 점차 국부혈관의 협착과 경화. 정맥꼬임
 - ③ 3단계: 화염상 망막출혈, 세동맥폐쇄로 망막부종, 면화반 형성. 별모양황반부종
 - ④ 4단계: 시신경유두부종, 시력저하 심함. 악성고혈압에서 발생

靑盲 靑盲

- 洋: 당뇨병성, 고혈압성 망막증, 노인성 황반변성, 유소아의 유전성 망막증, 시신경위축, 영양장애나 중독성으로 발생한 약시 등의 점진적 시력저하
- 증상: 흑점 및 동전에 翳 膜, 혼탁, 형태 결손도 없으면서 시력이 서서히 하강. 소아에서 痘疹, 溫熱病 후(小兒靑盲)
- 변증론치
 - 1) 肝腎虧損: 명목지황환, 주경환
 - 2) 心脾虛損: 귀비탕, 인삼양영탕
 - 3) 脾腎陽虛: 팔진탕, 보중익기탕
 - 4) 情志抑鬱, 肝氣鬱結: 소요산
 - 5) 小兒靑盲: 진간명목양간환,복명환

선천성 야맹증

① 망막색소변성

- 염증 소견없이 간체를 침범하는 망막의 퇴행성 위축. 상염색체 우성, 상염색체 열성, X-염색체 열성유전
- 증상: 시야협착, 야맹증 발생. 중심시력의 변화는 없음. 안저소견상 망막 세동맥의 위축, 뼈조각 모양의 망막 색소 침착, 왁스 모양의 시신경유두 창백
- 예후 및 합병증: 나쁨. 후낭하 백내장, 광우각 녹내장, 근시, 후유리체 박리 등

② 안저 백점증(흰점 안저)

- 상염색체 열성유전

- 증상 : 안저 소견상 중심와를 제외한 후극부와 망막주변부까지 퍼져있는 작은 황백색의 반점이 특징
- 망막혈관, 시신경유두, 주변부 망막과 시력은 정상

후천성 야맹증

① 맥락막 결여(범맥락막위축)

- 남자에서만 발생하는 반성유전
- 증상: 10대 이전에 야맹증으로 시작됨
- 안저 소견상 중간 주변부 안저에 맥락막 반점과 망막색소상피의 위축이 발생. 점차 중간크기 이상의 맥락막 혈관도 위축되면서 맥락막 아래의 공막이 비쳐 보임
- 예후: 매우 불량. 50대 이후로 매우 심한 시력 소실 발생

② 맥락막 변성

1) 노인성 변화

- 망막 색소상피층 세포의 증식, 변성으로 브루크막에 초자양 물질이 침착해 발생

2) 맥락막 경화증

- 맥락막 모세혈관과 주위 조직의 위축으로 발생
- 증상: 40대 성인남자에서 시력저하, 야맹증, 건조 및 이물감, 착시가 발생하여 60대까지 서서히 진행. 황반부 침범시 실명
- 안저소견: 초기 주변에 작은 반점, 위축소가 발생 점차 파급

③ 비타민 A 결핍증

- 증상: 각막은 연화되고 괴사를 일으키며(각막연화증), 결막상피는 각화되어 외측부의 각막쪽에 저변을 둔 삼각형의 비누거품과 같은 반점(Bitot's spot)이 안검연 틈새에 발생. 야맹증
- 심하면 전신의 상피를 각화시키기도 함
- 치료: 비타민 A를 최소 하루에 근육주사로 20,000IU 투여
- 비타민 A : 소아 실명의 가장 큰 원인

雀目 작목

- 이명: 雀盲, 鷄盲, 鷄矇 眼, 雀目內障, 高風內障, 高風雀目, 肝虛雀目
- 洋: 야맹증(선천성, 후천성)

❶ 高風雀目

- 洋: 선천성 야맹증(망막색소 변성, 안저 백점증 등)
- 증상: 황혼이 되거나 어두운 곳에서 사물을 감별하지 못함
- 변증론치
- 1) 命門火衰, 肝腎不足: 우귀환, 신기환, 명목지황환
- 2) 脾胃虛弱 清陽不升: 인삼양영탕, 보중익기탕

❷ 肝虛雀目

- 洋: 후천성 야맹증(비타민 A 흡수장애, 맥락막 결여 및 변성, 안구건조 등)
- 증상: 야간에 물체를 잘 보지 못하고 眼昏, 眼花 등이 발생. 진행되어 靑盲으로 전변 가능
- 변증론치
- 1) 肝虛血少: 보간산, 환정산
- 2) 小兒疳積: 오미이공산, 사미비아환, 소감산

視瞻昏渺 시침혼묘

- 洋: 중심시력 저하전의 주변시력 및 시야 감퇴, 소시증, 변시증, 색각장애를 동반하는 맥락막 및 망막변성, 망막염, 유리체 혼탁. 부분적 시야결손의 시로 및 시색질환
- 증상: 시력하강, 眼昏하고 눈앞에 까만 점, 실, 먼지, 파리와 같은 비문증과 반딧불 같은 섬광, 視大爲小, 視小爲大, 視直爲曲, 視渺有色 등의 妄視와 視惑症 등이 나타나고 서서히 靑盲으로 변함 → 맹은 아니고, 주변 시야가 감퇴되는 것
- 변증론치
- 1) 肝腎虧損: 명목지황환, 기국지황환, 주경환
- 2) 心脾虛損: 귀비탕, 인삼양영탕
- 3) 情志不舒 肝氣鬱結: 소요산가감, 명목소요탕
- 4) 濕熱痰濁內蘊: 삼인탕, 온담탕, 감로소독단

螢星滿目 형성만목

- 神光自現: 螢星滿目보다 증상이重的한 것
- 洋: 망막의 열공 및 박리, 후유리체 박리 등에서 발생하는 섬광증(photopsia)
- 증상: 자각적으로 눈앞에 미세한 별빛, 반디불빛, 電光, 閃光 등이 현란하게 발생. 심하면 화염이 간헐적으로 비치는 느낌이 발생
- 변증론치
- 1) 陰精虧損: 보수녕신탕, 대보원전
- 2) 上盛下虛: 가미감리환

04 시신경질환

<시신경질환의 종류>

1. 시신경염 - 暴盲
2. 가족 유전성 시신경병변 - 暴盲
3. 허혈성 시신경병증 - 暴盲
4. 시유두혈관염 - 視瞻昏渺
5. 중독성약시 - 靑盲, 視瞻昏渺, 暴盲
6. 시신경유두부종 - 靑盲
7. 시신경위축 - 靑盲

시신경염

- 중심암점을 동반한 급격한 시력장애. 급성으로 편안에 발생
- 韓: 暴盲
- 원인: 감염(대상포진, 벡테르병, 뇌염, 매독 등), 탈수초 질환(다발성 경화증, 시신경 척수염 등), 대사성 질환(당뇨)
- 증상: 50세 이하의 청장년과 아동의 편안에 급격한 색각이상, 시력감소와 중심시야 결손 발생, 수주 후 서서히 호전.
- 구분(안저소견)
 - ① 구후시신경염(정상소견) → 눈 뒤의 시신경 부분을 말함.
 - ② 유두염(유두부종, 출혈, 삼출물)
 - ③ 신경망막염(황반부 성망상 백반, 유두부종)
- 치료 및 예후: 정맥내 스테로이드 투여. 대부분 정상 회복
- 변증론치
 - 1) 肝經火盛: 龍膽瀉肝湯
 - 2) 肝經鬱熱: 加味逍遙散
 - 3) 陰虛火旺: 滋陰降火湯
 - 4) 氣血兩虛: 人參養榮湯

가족유전성 시신경병변(레베르 시신경병증)

- 가족 유전성 대칭성 시신경위축(유전성 구후시신경염, 유전성 시신경위축). 모성유전
- 대부분 20대 남성. 비전형적인 경우 여자에서, 10~60세 사이에서 발생가능. 양안에 시신경염이 발생한 경우 의심 가능

- 韓: 暴盲
- 증상: 한쪽에 심하고 통증 없는 시력소실이 갑자기 발생하고 수일 또는 수주내에 반대쪽에도 발생. 통증 없는 양안의 시력저하와 색각이상이 특징. 초기 적록 색맹의 양상, 후기에도 색각 장애 남음
- 변증론치
 - 1) 肝經邪火: 龍膽瀉肝湯
 - 2) 肝經鬱熱: 加味逍遙散
 - 3) 肝腎陰虛: 四物五子丸
- 예후: 대부분 영구적인 시력 소실이 있으며 일부에서 0.5이상의 시력회복도 가능. 예후 불량

허혈성 시신경증

- 60세 이상의 고령자에서 흔한 실명의 원인. 시신경유두의 부분 혹은 전체의 괴사
- 韓: 暴盲
- 원인: 고령, 흡연, 편두통, 전신질환(고혈압, 당뇨, 고지혈증, 교원성 질환, 백내장 수술 등)
- 증상: 전구증상 없이 통증 없는 단안성의 급격한 시력저하 발생. 시야장애도 다양. 태양혈 압통, 다발성 근육통, 발열 등의 전신증상. 안저소견은 시신경유두의 유백색 부종, 몇 개의 선상출혈 발생. 점차 시신경이 위축됨 → 폐색으로 인해 혈액공급이 잘 안됨
- 치료 및 예후: 스테로이드 투여. 크게 회복 되지 않으며 재발 또는 반대쪽 눈에 발생
- 변증론치
 - 1) 肝陽上亢: 鎮肝熄風湯
 - 2) 氣血兩虛: 八珍湯合 補陽還五湯
 - 3) 肝鬱氣滯: 逍遙散加減

시유두혈관염(유두혈관염)

- 50세 이하의 건강한 성인 남성 청장년에서 발생. 드문 질환
- 韓: 視瞻昏渺
- 시신경유두내 섬모 모양의 혈관 분지에 국한된 병변이나 망막 중앙 혈관의 비특이성 염증 → 시신경유두 주변 혈관의 문제. 생리적 맹점이 확대
- ① I형 유두혈관염: 유두내 섬모 모양의 혈관분지 염증으로 모세혈관 삼출이 증가되어 시신경유두 수종 발생
- ② II형 시유두 혈관염: 유두 표층에 바퀴살 모양의 모세혈관 염증이 누적되어 망막 중앙

정맥염성 폐색 발생

- 증상: 시력장애는 비교적 경미. 시야 검사시 생리적 맹점이 확대, 주변시야는 정상
- 변증론치: 淸 火 涼 血, 疏肝化瘀
 - 1) 肝火亢盛: 龍膽瀉肝湯
 - 2) 陰虛火旺: 知柏地黃湯
 - 3) 肝鬱氣滯: 解鬱逍遙散
- 예후 : 치료 없이도 우수. 대부분 어느 정도 시력 회복

중독성 약시

- 독물이나 약물로 인해 시신경과 망막신경절세포를 손상시켜 시력장애를 유발
- 韓: 視瞻昏渺, 暴盲, 青盲
- 증상: 양안에 대칭성으로 발병. 시력감퇴와 시야손상을 야기, 병이 중하면 시신경위축을 유발
- 유발 약제: 메탄올, 에탐부톨, 디지탈리스, 아미오다론, 트리메타디온, 스트렙토마이신, 클로람페니콜, 설파제, 퀴니딘, 하이드록시클로로퀸, 타목시펜 등
- 변증론치
 - 1) 肝胃火盛: 龍膽瀉肝湯
 - 2) 肺胃陰傷: 養陰清 肺湯
 - 3) 濕熱內蘊: 三仁湯加減
- 치료: 투약을 중지하면 회복

영양 및 중독성 약시

- 양안에서 서서히 중심 암점을 보이는 시신경증. 병중하면 시신경위축 발생
 1. 영양장애: 담배, 술 과용. 비타민 B1(thiamine), B6, B12 결핍시
 - 1) 알코올-담배중독 약시: 단백질과 비타민 B가 부족한 과도한 음주자와 흡연자에서 발생. 진행성, 대칭적인 양쪽 시력장애가 색각이상과 동반되어 서서히 발생. 안저소견상 대부분 시신경유두 정상, 간혹 이측 시신경유두 창백 동반
 2. 중독: 항생제(streptomycin, sulfa med), 항경련제 등에서 발생. 투약을 중지하면 회복

시신경유두부종(유두부종)

- 두개내압 상승에 의해 이차적으로 발생한 시신경유두의 종창
- cf) 시신경유두 종창: 두개내압 상승 없이 다른 모든 원인에 의해 생긴 시신경유두의 부종
 - 종창 : 두개내압 상승 없이 그 부위에 국소적으로 부어오르는 것
 - 부종 : 두개내압의 상승 때문
- 대부분 양안에 발병
- 韓: 青盲
- 증상: 초기에 자각증상으로 물건이 잠깐씩 흐릿하게 보이거나 시야 혼탁 발생. 병정이 오래가면 점차 시력 하강하고, 시야검사상 생리적 맹점 확대. 말기에는 시신경위축으로 심하면 실명. 대부분 두통, 오심, 구토 동반.
- 변증론치
 - 1) 肝陽上亢: 羚羊鉤藤湯
 - 2) 肝膽濕熱: 龍膽瀉肝湯
 - 3) 毒瘀痰濁: 銀翹散合 黃連溫膽湯
 - 4) 脾腎陽虛: 腎氣丸加減
- 치료: 원인 제거하고 두개내압을 정상화하면 대부분 2개월 이내에 유두부종 증상 소실

시신경위축

- 진행된 시신경질환의 중요한 징후. 신경절세포 축색의 광범위한 손상으로 인한 위축변성. 시력저하와 시신경유두 창백이 주요특징
- 韓: 青盲
- 원발성: 구후시신경염, 종양이나 동맥류 같은 압박병변 등. 유두가 창백, 편평하며 경계가 뚜렷. 유두주위 혈관의 약화와 유두표면의 작은 혈관수 감소
- 속발성: 만성 시신경 유두부종, 시신경유두염, 녹내장 등. 유두의 종창이 선행하였다가 흰색 또는 지저분한 회색의 경계 불분명한 유두, 유두 표면의 작은 혈관수 감소
- 변증론치
 - 1) 肝腎陰虛: 四物五子丸
 - 2) 心脾兩虛: 歸脾湯加減
 - 3) 肝氣鬱結: 逍遙散加減
 - 4) 脾腎陽虛: 右歸丸合 補中益氣湯
 - 5) 血瘀絡阻: 補陽還五湯

05 굴절이상

★ 소아의 시력과 융합기능이 완성되는 시기는 보통 ()세이며, 안축은 출생 시 약 ()였다가 약 ()세가 되면 정상 성인의 길이인 ()에 도달한다. (05,06,08,10,11,12,13,14,15,17)

★ 카파각은 ()도의 각을 이룬다. (18)

★ 안축은 출생 시 약 18mm였다가 약 ()세가 되면 정상 성인의 길이인 24mm에 도달하고, 소아의 시력과 융합기능이 완성되는 시기는 보통 ()세이다. (19)

- 렌즈의 굴절력: 초점거리의 역수를 diopter(D)로 표시. 즉, 초점거리 1m는 1.0D로, 2m는 0.5D로, 0.5m는 2.0D가 됨. 오목렌즈 (-), 볼록렌즈 (+)

→ 초점거리 : 눈에서 물체가 맺히는 거리

- 정시안: 조절 안한 상태에서 평행광선이 망막에 초점을 맺는 상태. **출생시 약 +2.5D의 원시, 안축 18mm, 약 14세에 성인크기(24mm)에 도달**

→ 근시 치료는 14세까지 가능

→ **융합기능과 시력이 완성되는 시기는 8세**

- 비정시안

- 1) 근시: 광선이 망막 앞에 결상
- 2) 원시: 광선이 망막 뒤에 결상
- 3) 난시: 굴절면이 구형이 아니라 모든 광선이 초점을 맺지 못함

근시

- 조절하지 않은 상태에서 평행광선이 망막 앞에 후주초점을 맺어 선명치 않은 상을 맺는 상태

- 분류: 경도(- 2.0D 이하), 중등도(- 2.0~ - 6.0D), 고도 또는 강도근시(- 6.0D 이상)

- 원인: 우성유전. 유발요인(근거리 작업량, 조명, 휴식, 영양상태, 내분비의 평형관계 등)

- 증상: 시력장애. -4D 이하의 근시에서는 근거리에서 결상되는 망막상이 정시안보다 커 더 세밀한 작업 가능. 외사시 형태로 오인. 근육성 안정피로, 두통 등도 발생

- 치료: 비수술(안경, 렌즈 사용), 수술(방사상각막절개술, 굴절교정레이저각막절개술 등)

❶ 단성근시: 학교근시. 유전 소인과 장시간 근거리 작업량이 원인. 10세에 시작, 느리게 진행하여 25세 전후 정지됨

❷ 축성근시: 악성근시, 진행성 근시로 점차 고도근시가 됨. 조기(5~10세)에 발생, 시력장애 심함. 심한 안축의 연장으로 녹내장, 백내장, 망막박리가 쉽게 발생. 맥락망막위축, 공

막확장, 유리체 혼탁, 비문증 등 발생

❸ 가성근시: 원시가 교정되지 않은 상태로 과도한 근업이 장기간 계속되어 조절연축을 유발

❹ 합병근시: 당뇨, 초발백내장, 녹내장, 스테로이드 투여, 임신중 등에서 발생. 전해질, 수분대사장애로 굴절률 증가가 원인

<근시>

- 이명: 近視, 能近怯遠, 視近怯遠, 靦靦眼
- 원인 : 품부부족, 작은 글씨나 책 등을 오랫동안 보거나해서
- 증상 : 근거리는 잘 보이나 원거리를 볼 때에는 물체가 모호해지며 때로 頭眼痛, 雲霧移睛, 眼花, 眼昏 등을 동반
- 변증론치 → 근시는 양기가 부족한게 문제. 심양을 보해주는 치료
 - 1) 心陽不足, 陽虛陰盛: 定志丸加減, 天王補心丹
 - 2) 肝腎陰虛: 杞菊地黃丸, 주경환가감, 보신자석환

<加味定志湯> 治근시

숙지황, 황기(밀구) 각 8g

백출, 백복신, 구기자(주초), 육종용(주초), 원지, 충울자, 밀몽화, 차전자 각 4g

감국, 석창포 각 3g

인삼, 익지인, 영양각, 파극 각 2g

감초 1g

원시

- 조절하지 않은 상태에서 평행광선이 망막의 뒤에 후주초점을 맺어 망막에 흐리고 확산된 상을 맺게 되는 상태

- 분류: 전체원시, 현성원시, 잠복원시, 허용원시, 절대원시

- 원인: 축성 원시(안축장이 조절력에 비해 너무 짧음), 굴절성 원시(유전적 소인. 각막, 수정체의 만곡도가 너무 편평해 안구 전반부의 굴절력이 작음), 안내 종양, 무수정체안 등

- 증상: 근거리 작업시 시력감퇴, 안통, 두통, 충혈, 열감, 건조감, 빈번한 눈물, 유루 등

- 5D 이상 원시에서 시신경유두 주변경계 뚜렷하지 못하나(가성 유두염) 중심 암점은 없음

- 치료: 볼록렌즈로 교정. 시력장애와 안정피로가 있으며 폭주과다가 일어나면 교정

<원시>

- 이명 : 能遠視, 不能近視, 能遠怯近, 視遠怯近
- 洋 : 원시, 노안
- 원인 : 稟賦不足, 老年으로 肝腎陰虛, 久病, 大病 등으로 腎陰虧損하여 陰虛陽盛
- 증상 : 원거리는 잘 보이나 근거리를 볼 때에는 물체가 모호해지며 때로 頭痛, 眼脹, 眼昏 등이 발생. 휴식을 취하면 잘 보이기도 함. 쉽게 小兒通睛 진행
- 변증론치 : 肝腎陰虛(기국지향환, 명목지향환, 地芎丸) → 원시는 음이 부족한게 문제. 간신음허 치료

난시

- 굴절부등 난시 : 모든 방향의 굴절력이 균일하지 않고 눈의 경선에 따라 차이가 나는 상태
- 韓: 妄視, 視惑, 肝勞의 일부 증상(이명: 散光)
- 원인: 각막과 수정체의 구면이 일정하지 못해 발생
- 분류
 - ① 정난시(규칙 산광): 정상 안에서 두 점 이상의 초점을 갖음
 - ② 부정난시(불규칙 산광): 각막반흔, 원추각막, 백내장 초기 등 질환에서 발생
 - ③ 주경선의 위치에 따라: 수직방향(직난시), 수평방향(도난시)
 - ④ 굴절이상의 종류에 따라: 경선이 한 개(단순 난시), 두개 이상(복합난시)
 - ⑤ 근시 또는 원시로 경선이 양측에 발생: 근시성 복난시, 원시성 복난시
- 증상: 경미한 경우 별무증상. 조절성 안정피로, 시력장애 발생. 난시표나 물체를 보면 진한 면과 연한 면을 호소
- 치료: 肝氣不和(시호소간산). 원추렌즈로 교정. 근시성, 원시성 복난시는 구면렌즈로 교정 후 원추렌즈 사용 → 사실 한방에서 접근하긴 어려움

약시

- 정의: 교정시력이 1.0이하이고 양안의 시력차이가 시력표상 2줄 이상 차이가 나는 상태
- 변증
 - 1) 脾胃氣虛: 보중익기탕
 - 2) 腎精不足: 九子丸加減
- 치료: 사시, 백내장, 안검하수 등의 기질적 원인을 치료. 굴절이상시 안경 교정하고 차폐요법, 시자극 요법 실시

06

전신질환과 동반된 안질환

갑상선 안질환

- 양안의 진행성 안구돌출이 갑상선 기능항진을 앞서서, 동시에 또는 뒤따라 발생할 수 있으며 갑상선 기능이상 심한 정도와 관계 없음
- 눈그레이브스병 : 임상적인 갑상선 기능항진을 보이지 않으면서 눈에 갑상선 항진증의 징후가 발생. 안과에서 가장 흔함
- 증상 : 안와주위와 안검부종, 결막충혈 및 부종, 안검 후퇴, 안구돌출, 시신경병증(중심시력 감소로 시작), 외안근마비. 표정은 마치 놀란 듯한 눈을 보임
- 韓: 魚睛不夜, 懸球, 脾虛如球
- 변증론치
 - 1) 肝鬱化火: 丹梔逍遙散
 - 2) 陰虛陽亢: 耳聾左慈丸
- 치료 : 스테로이드의 전신투여. 방사선치료, 수술. 수술은 반드시 안구돌출과 사시에 대한 평가가 끝난 뒤에 고려하여 안와, 사시, 눈꺼풀의 순서로 진행.

갑상샘 눈병증의 징후

- ① Darlymple 징후: 정면 주시때 보이는 안검 후퇴
- ② Kocher 징후: 놀란 눈처럼 보이는 것
- ③ von Graefe 징후: 하방 주시때 상안검이 느리게 내려옴

안화질환

★ 서양의학의 안정피로, 안피로에 해당하는 질환으로 독서나 작업시에 눈이 乾澁, 不快하고 脹痛, 頭額痛, 心痛, 嘔吐 등이 발생하여 휴식을 취하면 증상이 완화되고 스트레스, 육체적 피로, 久視, 久病에서는 증상이 더욱 심해지는 한방병명은? (05,10) **답: 간노**

- 일시적으로 물체가 흐리게 보이면서 눈앞에 흑화 또는 꽃무늬를 느끼고 아울러 眩暈, 頭痛 등이 발생하는 것
- 洋: 주변 암점이나 주변 시야의 결손에서 나타나는 시력저하

① 坐起眼花 → 앉았다 일어날 때 눈앞이 핑도는 느낌. 기립성 현훈이나 기립성 저혈압

- 증상: 사물이 흐리게 보이고 갑자기 起立, 坐臥하게 되면 눈앞이 검게 되거나 혹은 여러 가지 꽃무늬 모양을 느끼며 眩暈, 頭痛, 耳鳴 등을 동반

- 변증론치
肝腎陰虛, 陰虛火旺: 환정산, 주경환, 삼화오자환, 자음지황환

② 乾澀眼花

- 증상: 안구가 건삽 혹은 소양, 유루하고 경미한 홍적 및 眼痛, 眼脹感, 頭重感, 眩暈 등을 동반하면서 사물이 흐리게 보이고 黑花, 眼花 등이 발생
- 안정피로인 肝勞와 비슷함
- 변증론치
1) 思慮過度: 사물귀비탕, 보수녕신탕, 대보원전가감
2) 腎陰不足: 자음지황환, 환정산, 기국양혈음

망시 및 시혹질환

- ★ 앞에 물체가 없는데 있는 것처럼 보이는 것을 ()라 하고 물체가 뒤집히거나 색깔이 변하는 등 이상하게 보이는 것을 ()이라 한다. (08)
- 자각적으로 여러 가지 물체가 변화되어 보이거나 혹은 이상한 형태로 보이는 것으로 視瞻昏渺, 雲霧移睛, 螢星滿目, 老人眼昏 등의 일부 증상. 또한 暴盲, 青盲의 초기에 발생되는 內障眼病
- 洋: 변시증, 소시증, 다시증, 명암장애, 기능적 시력장애 등
- 妄視: 亂視. 눈에 이상 없이 遊絲, 舞蝶, 蛇旗, 飛蠅狀 혹은 靑黑, 粉白, 微黃色 등이 허공에서 散亂한 것처럼 자각적으로 느끼는 것
- 視惑: 迷亂眩惑한 것. 눈에 이상없이 돌연히 視物眩惑, 顛倒紊亂, 五色模辨이 발생됨

<서양의학> 변시증

- ★ 시직여곡 시정반사 시대위소 시물전도 등의 변시증을 일으키는 질환이 아닌 것은? (18,19)
- 유발질환
① 망막색소상피 박리: 두꺼워진 부르크막으로 인해 망막색소상피에서 맥락막으로 수액이 동의 장애로 발생. 단안 변시증과 중심시력 저하 호소
② 삼출성 연령관련 황반변성: 맥락막신생혈관에서 누출이 일어나 장액성 망막박리, 출혈, 삼출물 유출. 중심시력저하와 변시증 호소
③ 중심성 장액맥락망막병증: 황반부 주위에 국한된 감각망막박리를 특징. 편측의 변시증, 소시증, 암점과 관련된 시력저하 호소

- ④ 매독성 포도막염: 후천적 맥락망막염의 일종. 양안 시력저하는 심하지 않고 시야결손과 변시증 발생

다시증

- 각막 및 수정체 구면의 굴절력 이상 및 혼탁에서 발생
- 유발질환
① 미숙백내장: 수정체 주변부 켜기모양 혼탁이 중심부로 진행하면서 수정체 용적이 커지면서 시력감퇴, 다시증 발생
② 난시: 각막 구면 굴절력이 균일하지 못해 물체의 상이 두 개 혹은 여러 개의 초점으로 보임
③ 무수정체안 및 부동시
a. 무수정체안: 수정체가 시축내에 없어 각막에 의해서만 굴절
b. 부동시: 양안에 2D 이상의 굴절도 차이로 각각의 망막상의 크기 또는 형태가 다르게 보임. 약시, 사시를 초래하기도 함

시야결손

- 유발질환: 두개내 병변, 순환장애, 외상 등으로 인해 시신경섬유가 장애를 받아 발생
- 증상: 이측과 비측, 상측과 하측에 사분맹, 반맹 등의 시야결손이 나타나고 망막의 결상에도 이상 발생
- 측두엽 및 두정엽 질환의 경우 시야결손 뿐만 아니라 반신마비, 실어증, 실독증, 실서증, 좌우혼돈, 幻視 등 발생

神光自現 신광자현

- 개요: 螢星滿目보다 증상이 심해서 안정에 이상이 없이 電光, 閃光이 보이며 重하면 火焰이 간헐적으로 발생하는 것
- 洋: 섬광증
- 원인: 陰精虧損, 痰火, 火熱
- 변증론치
1) 통치 陰精虧損: 보수녕신탕, 대보원전
2) 陰虛火旺: 자음강화탕
3) 上盛下虛: 가미감리환

黑夜精明 흑야정명

★ 주맹증의 한방병명 및 이를 유발할 수 있는 양의학적 병변을 쓰시오. (08)

- 개요 : 眼睛에 이상이 없이 야간이나 컴컴한 곳에서 물체가 더 선명하게 보이고 밝은 곳에서 잘 보이지 않는 증상
- 洋 : 주맹증
- 변증론치
 - 1) 腎水不足: 팔미지황환가감

<서양의학> 주맹증

- 망막의 추체 변성, 축성 시신경염, 전색맹, 각막과 수정체의 중앙부 혼탁에서 발생

視直如曲 시직여곡

- 개요: 물체가 구부러져 보임
- 洋 : 변시증
- 증상 : 시력이 저하되고 곧은 물체가 휘어보이는 것 같고 때로 暴盲, 眼昏 발생
- 변증론치
 - 1) 濕痰: 삼인탕, 온담탕가감
 - 2) 肝氣鬱結: 단치소요산
 - 3) 肝腎虧損: 환정산, 기국지황환

視正反斜 시정반사

- 개요 : 정상적인 물체가 찌그러져 보임
- 洋 : 변시증
- 증상 : 안정에 이상이 없이 물체가 삐뚤게 보임
- 변증론치
 - 1) 風痰: 정용탕가감
 - 2) 陰精虧損: 좌귀환가감

視定反動 시정반동

- 개요 : 정지된 물체가 움직이는 것처럼 보임
- 洋 : 변시증
- 변증론치

- 1) 風痰: 정용탕, 도담탕
- 2) 氣血虛弱: 십전대보탕, 인삼양영탕, 지백지황환, 기국양혈음

視大爲小 시대위소

- 개요 : 물체가 크게 또는 작게 보이고 점차 昏矇
- 洋 : 변시증
- 변증론치
 - 1) 風痰: 정용탕가감
 - 2) 水濕: 사군자탕합오령산

視物顛倒 시물전도

- 개요 : 물체가 빙빙 돌고 거꾸로 보임
 - 洋 : 변시증
 - 증상 : 시력이 저하되고 물체가 빙빙 돌고 거꾸로 보이는데, 경미하면 앉거나 눈감으면 없어지나 중증이면 어지러워 서있지 못하고 오심, 구토, 현훈, 이명, 혼도 등이 발생
 - 변증론치
 - 1) 肝陽上亢 肝風內動: 영양각산
 - 2) 痰濁: 반하백출천마탕, 온담탕
 - 3) 氣血虧損: 십전대보탕
 - 4) 腎精不足: 좌귀환, 기국지황환
- 변시증은 대부분 황반부에 삼출액이나 수습 등이 차는 요인으로 인해 나타남

視一爲二 시일위이

- 개요 : 한 개의 물체가 둘로 보이는 것. 視岐, 視物爲兩, 視一爲兩, 視一如二
- 洋 : 복시증
- 증상 : 한 개의 물체가 여러 개로 보이며 眼昏, 眼花, 때로 頭目疼痛, 眩暈, 目赤 등도 동반
- 변증론치
 - 1) 肝腎虧損: 신기환, 보간산
 - 2) 火邪壅盛: 내소황련탕
 - 3) 外傷: 도홍사물탕

<서양의학> 복시증

- 사시, 백내장, 부동시, 망막염, 황반부 변성, 시신경질환, 외상

視赤如白 시적여백

- 개요 : 안정에 별다른 이상 없이 色을 감별하지 못하는 것. 視物易色, 視黑爲赤, 視白爲黃
- 洋 : 색각장애
- 증상 : 시력에 변화가 없고 안혼, 안화가 없이 視赤爲白, 視黑如赤, 視白似黃色, 視黃似綠色 似藍色과 같이 오색이 모호함
- 변증론치
 - 1) 先天 稟賦不足, 後天 氣血不調: 氣血調和, 滋陰和肝 - 기국지황환, 명목지황환, 신기환, 익기총명탕, 인삼양영탕
 - 2) 七情鬱結: 소요산가감

<서양의학> 색각장애

1. 색맹 및 색약

1) 선천적 색각장애

- X염색체성 반성열성유전
- 이상 3원색시가 2원색시 보다 배가량 많다

2) 후천적 색각장애

- 망막 추체변성, 시신경염, 시신경위축, 시피질 경로 이상
- 시세포 장애(청색각), 시신경섬유 장애(적색각), 수정체 핵의 착색(청색각)

2. 색시증: 무색의 물체가 착색되어 보이는 증상. 적시증(수정체 적출후), 청시증(백내장의 황색 수정체 제거후), 황시증(황달)

→ 뒤쪽 내용은 증상을 한의학적으로 이렇게 보고 처치를 이렇게 했다 알아두면 됨. 이런 명칭도 있다 정도. 따로 외우지는 않아도 됨

*** 중간고사는 안과파트만 시험 봄